

Bunga Rampai

PELAYANAN KEBIDANAN PADA PEREMPUAN USIA SUBUR

Dalam Upaya Menjaga Kesehatan Reproduksi

Eny Retna Ambarwati • Syahridayanti • Dwi Ardani Rochmaniah
Ida Susila • Januar Dwi Christy • Liana Muslihah
Sitti Hadriyanti Hamang

Editor: Dr. Budi Astyandini



BUNGA RAMPAI: PELAYANAN KEBIDANAN PADA PEREMPUAN USIA SUBUR DALAM UPAYA MENJAGA KESEHATAN REPRODUKSI

Penulis:

Dr. Bdn. Eny Retna Ambarwati, S.Si.T., M.Kes.

Syahridayanti, S.ST., M.Kes.

Dwi Ardani Rochmaniah, S.ST., Bdn., M.Keb.

Bdn. Ida Susila, S.ST., M.Kes.

Januar Dwi Christy, S.ST., Bd., M.Kes.

Liana Muslihah, S.Si.T., M.K.M.

Sitti Hadriyanti Hamang, S.ST., M.Keb.

Editor:

Dr. Budi Astyandini, S.Si.T., M.Kes.

Bunga Rampai: Pelayanan Kebidanan Pada Perempuan Usia Subur Dalam Upaya Menjaga Kesehatan Reproduksi

Penulis:

Dr. Bdn. Eny Retna Ambarwati, S.Si.T., M.Kes.
Syahridayanti, S.ST., M.Kes.
Dwi Ardani Rochmaniah, S.ST., Bdn., M.Keb.
Bdn. Ida Susila, S.ST., M.Kes.
Januar Dwi Christy, S.ST., Bd., M.Kes.
Liana Muslihah, S.Si.T., M.K.M.
Sitti Hadriyanti Hamang, S.ST., M.Keb.

Editor: Dr. Budi Astyandini, S.Si.T., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-47-3

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul *“Bunga Rampai Pelayanan Kebidanan pada Perempuan Usia Subur dalam Upaya Menjaga Kesehatan Reproduksi”* ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini dihadirkan sebagai upaya kontribusi ilmiah dan praktis untuk memperkuat pelayanan kebidanan yang komprehensif, berkesinambungan, serta berorientasi pada pencegahan dan pemberdayaan perempuan usia subur dalam menjaga kesehatan reproduksinya.

Perempuan usia subur memiliki kebutuhan kesehatan yang dinamis, dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan. Pada fase ini, berbagai isu kesehatan reproduksi dapat muncul—mulai dari gangguan menstruasi, infeksi saluran reproduksi, hingga risiko penyakit yang berdampak pada kualitas hidup dan kesiapan reproduksi di masa mendatang. Oleh karena itu, pelayanan kebidanan tidak hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi juga menekankan promotif dan preventif melalui edukasi, konseling, deteksi dini, skrining, serta penguatan perilaku hidup sehat. Bidan berperan penting sebagai tenaga kesehatan terdepan yang mampu menjembatani kebutuhan informasi, layanan, dan pendampingan yang ramah perempuan, menjaga kerahasiaan, dan berbasis bukti.

Buku bunga rampai ini disusun untuk memberikan pemahaman yang terstruktur sekaligus aplikatif serta tenaga kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi.

Secara sistematis, buku ini memuat tujuh bab yang saling berkesinambungan. Bab 1 membahas konsep dasar perempuan usia subur dan kesehatan reproduksi sebagai landasan pemahaman. Bab 2 menguraikan berbagai permasalahan kesehatan reproduksi yang umum terjadi pada perempuan usia subur, termasuk faktor risiko dan dampaknya. Bab 3 memfokuskan pada deteksi dini gangguan menstruasi dan infeksi saluran reproduksi sebagai langkah awal pencegahan komplikasi. Bab 4 menekankan pentingnya perilaku hidup sehat untuk menjaga kesehatan reproduksi melalui kebiasaan sehari-hari yang realistis dan dapat diterapkan. Bab 5 menjelaskan skrining kesehatan reproduksi serta edukasi pencegahan penyakit sebagai upaya promotif-preventif yang terintegrasi. Bab 6 mengangkat peran bidan dalam promosi kesehatan reproduksi perempuan usia subur, termasuk strategi komunikasi, konseling, dan pemberdayaan masyarakat. Terakhir, Bab 7 membahas evaluasi pelayanan kebidanan pada perempuan usia

subur sebagai bagian dari peningkatan mutu layanan, keselamatan pasien, dan perbaikan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi dengan pemikiran, pengalaman, serta kajian ilmiah, sehingga buku ini menjadi lebih kaya dan relevan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para reviewer, editor, dan semua pihak yang mendukung proses penyusunan hingga penerbitan buku ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku bunga rampai ini dapat memberikan manfaat nyata dalam memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam pelayanan kebidanan pada perempuan usia subur, serta turut mendukung terwujudnya kesehatan reproduksi perempuan yang optimal.

Juni, 2026

Penulis



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DASAR PEREMPUAN USIA SUBUR DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Dr. Bdn. Eny Retna Ambarwati, S.Si.T., M.Kes.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi Perempuan Usia Subur	2
C. Karakteristik Perempuan Usia Subur.....	2
D. Konsep Kesehatan Reproduksi.....	4
E. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi	5
F. Determinan Kesehatan Reproduksi.....	7
G. Promosi Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur	9
H. Issue Aktual Kesehatan Reproduksi	10
I. Pendekatan Intervensi Kesehatan Reproduksi.....	12
J. Simpulan	13
Referensi	15
Glosarium	18

CHAPTER 2 PERMASALAHAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA USIA SUBUR

Syahridayanti, S.ST., M.Kes.....	20
A. Pendahuluan.....	20
B. Pembahasan	20
C. Kesimpulan.....	27
Referensi	28
Glosarium	30

CHAPTER 3 DETEKSI DINI GANGGUAN MENSTRUASI DAN INFEKSI SALURAN REPRODUKSI

Dwi Ardani Rochmaniah, SST., Bdn., M.Keb.	31
A. Pendahuluan.....	31
B. KONSEP DASAR MENSTRUASI.....	32
C. GANGGUAN MENSTRUASI.....	35
D. Infeksi Saluran Reproduksi	43

E. Simpulan	49
Referensi	50
Glosarium	51

CHAPTER 4 PERILAKU HIDUP SEHAT UNTUK MENJAGA KESEHATAN REPRODUKSI

Bdn. Ida Susila,. SST,. M. Kes.	52
A. Pendahuluan.....	52
B. Personal Hygiene Organ Reproduksi.....	53
C. Perilaku Seksual Aman dan Bertanggung Jawab	55
D. Nutrisi Seimbang untuk Kesehatan Reproduksi	57
E. Aktivitas Fisik dan Manajemen Stres.....	60
F. Hindari Perilaku Berisiko NAPZA dan Rokok untuk Kesehatan Reproduksi.....	63
G. Skrining dan Pemeriksaan Berkala.....	65
H. Simpulan	68
Referensi	69

CHAPTER 5 SKRINING KESEHATAN REPRODUKSI DAN EDUKASI PENCEGAHAN PENYAKIT

Januar Dwi Christy, SST., Bd., M.Kes.	72
A. Pendahuluan.....	72
B. Manfaat Pemeriksaan Kesehatan Rutin Bagi Wanita	73
C. Masalah Kesehatan Umum Pada Wanita	74
D. Manfaat Deteksi Dini	75
E. Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi	75
F. Penyakit Menular Seksual	77
G. HIV dan AIDS	78
H. Pencegahan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS	80
I. Kapan harus memulai Skrining dan seberapa Sering	80
J. Simpulan	81
Referensi	83
Glosarium	84

CHAPTER 6 PERAN BIDAN DALAM PROMOSI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN USIA SUBUR	85
Liana Muslihah, S. SiT, M.KM.....	85
A. Pendahuluan.....	85
B. Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur.....	88
C. Peran Bidan dalam Promosi Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur	95
D. Ruang Lingkup Materi Promosi Kesehatan Reproduksi oleh Bidan.....	103
E. Strategi Bidan dalam Melaksanakan Promosi Kesehatan Reproduksi	108
F. Prinsip Komunikasi Bidan dalam Promosi Kesehatan Reproduksi.....	113
G. Hambatan dalam Promosi Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur	118
H. Upaya Penguatan Peran Bidan.....	122
I. Penutup.....	126
Referensi	128

CHAPTER 7 EVALUASI PELAYANAN KEBIDANAN PADA PEREMPUAN USIA SUBUR

Sitti Hadriyanti Hamang, S.ST.,M.Keb.....	131
A. Pendahuluan.....	131
B. Konsep Pelayanan Kebidanan pada Perempuan Usia Subur.....	132
C. Tujuan Evaluasi Pelayanan Kebidanan	133
D. Komponen Evaluasi Pelayanan Kebidanan.....	134
E. Indikator Evaluasi Pelayanan Kebidanan.....	135
F. Metode Evaluasi Pelayanan Kebidanan pada Perempuan Usia Subur	136
G. Standar Pelayanan Kebidanan pada Perempuan Usia Subur	138
H. Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Pelayanan Kebidanan	139
I. Evaluasi Pelayanan Skrining Kesehatan Reproduksi	140
J. Peran Evidence-Based Practice dalam Evaluasi Pelayanan Kebidanan	141
K. Tantangan Evaluasi Pelayanan Kebidanan.....	141
L. Strategi Penguatan Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan	142
M. Pendekatan Woman Centered Care dalam Pelayanan Kebidanan	143
N. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Evaluasi Pelayanan Kebidanan.....	144
O. Peran Bidan dalam Pemberdayaan Perempuan Usia Subur.....	145
P. Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kebidanan	146
Q. Kolaborasi Interprofesional dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi	146
R. Penutup.....	147
Referensi	149

PROFIL PENULIS	151
-----------------------------	------------



CHAPTER 1



KONSEP DASAR PEREMPUAN USIA SUBUR DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Dr. Bdn. Eny Retna Ambarwati, S.Si.T., M.Kes.

A. Pendahuluan

Perempuan dalam usia subur, yang disebut PUS, adalah kelompok wanita yang berusia antara 15 hingga 49 tahun dan tengah mengalami fase aktif dalam reproduksi. Secara biologis, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan ovulasi, mengalami pembuahan, dan hamil (Badan Pusat Statistik [BPS], 2022; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Kelompok ini memegang peran signifikan dalam pengembangan sektor kesehatan, karena berhubungan langsung dengan berbagai indikator kesehatan di tingkat nasional, seperti angka kematian ibu, angka kelahiran, serta kualitas dari generasi yang akan datang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Dalam skala global, kesehatan reproduksi kaum perempuan tidak hanya dipahami dari sisi medis, melainkan juga sebagai aspek penting dalam pembangunan manusia terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan kesetaraan gender (Starrs et al., 2018; United Nations Population Fund [UNFPA], 2022). Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan kesehatan reproduksi sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi (World Health Organization [WHO], 2022).

Di Indonesia, kesehatan reproduksi masih menghadapi sejumlah tantangan yang rumit. Beberapa masalah yang ada termasuk tingginya prevalensi anemia di kalangan perempuan dalam usia subur, adanya kebutuhan kontrasepsi yang belum terpenuhi, meningkatnya kejadian kehamilan yang tidak direncanakan, serta tingginya angka pernikahan usia dini di beberapa daerah (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN], 2022; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Permasalahan-permasalahan ini dapat meningkatkan risiko munculnya komplikasi selama proses kehamilan dan persalinan, seperti perdarahan, preeklamsia, dan kelahiran yang prematur (Neal et al., 2021). Pemahaman komprehensif tentang konsep dasar perempuan dalam usia subur dan kesehatan

reproduksi sangat diperlukan sebagai landasan dalam praktik klinis, pendidikan kesehatan, serta penyusunan kebijakan berbasis bukti.

B. Definisi Perempuan Usia Subur

Perempuan yang dikategorikan dalam usia subur adalah mereka yang berusia antara 15 hingga 49 tahun dan telah mencapai tingkat kematangan dalam sistem reproduksi mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk secara biologis mengalami ovulasi, pembuahan, serta kehamilan (Badan Pusat Statistik, 2022; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Secara fisiologis, kondisi ini ditunjukkan oleh fungsi optimal dari hormon reproduksi dan siklus menstruasi yang relatif teratur, yang menjadi indikator kesiapan sistem reproduksi (Reed & Carr, 2020; Bull et al., 2019). Dalam konteks kesehatan masyarakat, wanita dalam kategori usia subur menjadi fokus utama berbagai program terkait kesehatan reproduksi, termasuk layanan keluarga berencana, kesehatan bagi ibu, serta upaya pencegahan terhadap penyakit yang mempengaruhi sistem reproduksi (World Health Organization, 2022). Selain itu, kelompok ini memerlukan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, termasuk pendidikan kesehatan, penyediaan kontrasepsi, sampai dengan pemeriksaan selama kehamilan (United Nations Population Fund, 2022). Dari perspektif epidemiologi, perempuan usia subur termasuk dalam kelompok yang berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan reproduksi, seperti anemia, kehamilan tidak terencana, serta komplikasi yang muncul selama kehamilan dan proses melahirkan. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan layanan kesehatan yang terintegrasi, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif (Black et al., 2020; Neal et al., 2021). Dengan demikian, wanita dalam kategori usia subur merupakan kelompok krusial dalam pembangunan kesehatan yang memerlukan perhatian menyeluruh untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksinya.

C. Karakteristik Perempuan Usia Subur

Perempuan dalam rentang usia subur mempunyai sifat-sifat yang rumit dan memiliki banyak dimensi, mencakup elemen biologis, psikologis, sosial, dan perilaku kesehatan yang saling terkait dalam mempengaruhi keadaan kesehatan reproduktif. Dari perspektif biologis, wanita pada tahap ini berada dalam periode reproduksi aktif yang ditunjukkan oleh fungsi optimal organ reproduksi, termasuk aktivitas ovarium dalam memproduksi hormon estrogen dan progesteron secara teratur dan terjadinya ovulasi yang konsisten sebagai bagian dari siklus menstruasi (Reed & Carr, 2020; Bull et al., 2019). Siklus menstruasi yang normal umumnya berlangsung

antara 21 hingga 35 hari, menjadi indikator crucial keseimbangan hormonal dan kesehatan reproduksi wanita (Bull et al., 2019).

Kondisi biologis wanita dalam usia subur juga dipengaruhi oleh status gizi dan kesehatan secara keseluruhan. Defisiensi nutrisi, khususnya zat besi, dapat meningkatkan risiko anemia yang berpengaruh pada penurunan kualitas kesehatan reproduktif serta memperbesar kemungkinan adanya komplikasi selama masa kehamilan (Black et al., 2020; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Di sisi lain, penyakit yang bersifat kronis seperti obesitas, diabetes, dan gangguan endokrin juga dapat berdampak pada kesuburan dan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi obstetri (Teede et al., 2018).

Dari sudut pandang psikologis, perempuan dalam rentang usia subur berada pada fase perkembangan yang memerlukan kesiapan emosional serta kematangan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, termasuk perencanaan kehamilan dan pemakaian kontrasepsi (Howard et al., 2021). Masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan, diketahui memiliki kaitan dengan hasil kehamilan yang tidak optimal, seperti kelahiran prematur dan bayi yang lahir dengan berat badan rendah (Howard et al., 2021).

Dalam aspek sosial, karakter perempuan usia subur sangat dipengaruhi oleh elemen sosial seperti tingkat pendidikan, situasi ekonomi, jenis pekerjaan, serta nilai dan norma budaya yang ada dalam masyarakat (Marmot et al., 2020). Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi umumnya menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan reproduksi dan mendapatkan akses yang lebih baik pada layanan kesehatan, termasuk penggunaan kontrasepsi modern (BKKB, 2022). Di sisi lain, praktik sosial seperti pernikahan dini masih dianggap sebagai faktor risiko yang signifikan karena dapat meningkatkan kemungkinan munculnya komplikasi saat kehamilan dan melahirkan (UNICEF, 2022).

Berkaitan dengan perilaku kesehatan, perempuan usia subur menunjukkan variasi dalam cara menjaga kesehatan reproduksi, seperti konsistensi dalam melakukan pemeriksaan kesehatan, penggunaan kontrasepsi, serta langkah-langkah pencegahan terhadap infeksi menular seksual. Kebiasaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi kesehatan, akses terhadap informasi, serta kualitas layanan kesehatan yang tersedia (World Health Organization, 2022). Oleh sebab itu, pendekatan yang bersifat promotif dan preventif melalui edukasi tentang kesehatan reproduksi menjadi krusial untuk mendorong perilaku sehat dalam kelompok ini. Dengan demikian, karakteristik perempuan dalam rentang usia subur tidak hanya harus dilihat dari perspektif biologis, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan perilaku yang saling berhubungan dalam membentuk keadaan kesehatan reproduksi secara keseluruhan.

D. Konsep Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah konsep yang mencakup banyak aspek dan tidak terbatas pada sisi biologis saja, melainkan juga meliputi dimensi psikologis, sosial, serta hak-hak asasi manusia. Organisasi Kesehatan Dunia mendeskripsikan kesehatan reproduksi sebagai keadaan sejahtera yang mencakup fisik, mental, dan sosial secara komprehensif dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, dan proses yang terlibat (Organisasi Kesehatan Dunia [WHO], 2022). Penjelasan ini menegaskan bahwa upaya kesehatan reproduksi perlu dilakukan secara total dan terintegrasi, bukan hanya berfokus pada penanganan penyakit tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

1. Pendekatan Biomedis (Klinis)

Pendekatan biomedis menitikberatkan pada keadaan fisiologis dan patologis dari sistem reproduksi, termasuk kinerja organ, keseimbangan hormon, serta upaya pencegahan dan penanganan berbagai penyakit seperti infeksi menular seksual, gangguan kesuburan, dan kanker reproduksi (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit [CDC], 2022). Dalam metode ini, kesehatan reproduksi dievaluasi melalui indikator klinis seperti keteraturan siklus menstruasi, tingkat keberhasilan kehamilan, dan tidak adanya kelainan pada organ reproduksi (Reed & Carr, 2020). Selain itu, pendekatan ini meliputi layanan kesehatan termasuk pemantauan kehamilan (perawatan antenatal), persalinan yang aman, serta penyediaan kontrasepsi (Cleland et al., 2021).

2. Pendekatan Kesehatan Masyarakat (Public Health)

Pendekatan kesehatan masyarakat memandang kesehatan reproduksi sebagai bagian integral dari sistem kesehatan yang lebih luas, dengan penekanan pada pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan peningkatan akses terhadap layanan (WHO, 2022). Intervensi dilakukan di tingkat populasi melalui program-program seperti keluarga berencana, imunisasi, skrining kanker serviks, dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Pendekatan ini juga mengambil dalam pertimbangan faktor sosial seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan ketersediaan akses ke layanan kesehatan (Marmot et al., 2020).

3. Pendekatan Berbasis Hak

Pendekatan berbasis hak menempatkan kesehatan reproduksi dalam kerangka hak asasi manusia yang fundamental. Tiap orang berhak atas akses informasi yang akurat, layanan kesehatan berkualitas tinggi, serta kebebasan untuk membuat pilihan reproduksi tanpa adanya paksaan, diskriminasi, atau kekerasan (Dana Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa [UNFPA], 2022).

Pendekatan ini juga menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender, pemberdayaan wanita, serta perlindungan bagi kelompok yang rentan, termasuk remaja dan perempuan di daerah terpencil (Starrs et al., 2018).

4. Pendekatan Psikososial

Pendekatan ini berfokus pada keterkaitan antara kondisi mental dan faktor sosial dalam memengaruhi kesehatan reproduksi. Kesehatan mental, dukungan dari keluarga dan komunitas, serta kondisi sosial memainkan peran kunci dalam menentukan hasil kehamilan dan kesejahteraan seorang ibu (Howard et al., 2021). Masalah seperti depresi dan kecemasan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi selama kehamilan dan memengaruhi kesehatan bayi.

5. Pendekatan Gender dan Sosial Budaya

Pendekatan ini menekankan bahwa kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang membentuk posisi wanita di masyarakat. Praktik-praktik seperti pernikahan dini dan ketidaksetaraan gender dapat memperbesar risiko masalah kesehatan reproduksi (UNICEF, 2022). Ketidakadilan gender juga dapat membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, informasi, dan layanan kesehatan, yang berdampak negatif pada kesehatan mereka (Marmot et al., 2020).

6. Pendekatan Siklus Hidup

Pendekatan ini melihat kesehatan reproduksi sebagai proses yang berlangsung sepanjang hidup, dimulai dari masa remaja, periode reproduktif, hingga menopause. Setiap fase kehidupan memiliki kebutuhan kesehatan yang unik, sehingga intervensi harus disesuaikan dengan keadaan di masing-masing tahap (WHO, 2023). Pendekatan ini mengedepankan pentingnya kesinambungan dalam pelayanan kesehatan demi meningkatkan kualitas hidup wanita secara keseluruhan.

E. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi

Ruang lingkup kesehatan reproduksi melibatkan beragam elemen yang saling terhubung dan dijalankan melalui usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk memelihara fungsi sistem reproduksi serta meningkatkan kesejahteraan individu secara holistik. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya terfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup pemenuhan hak reproduksi, akses terhadap layanan medis, serta peningkatan kualitas hidup sepanjang rentang kehidupan (World Health Organization [WHO], 2022). Dalam konteks praktik kesehatan masyarakat dan klinis, ruang lingkup kesehatan reproduksi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesehatan Maternal

Kesehatan maternal mencakup layanan selama proses kehamilan, melahirkan, dan masa nifas, yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu serta bayi. Layanan ini termasuk pemeriksaan kehamilan (antenatal care), persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis yang berkualitas, dan pemantauan kondisi ibu pasca melahirkan (WHO, 2023). Penyediaan layanan maternal yang baik terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi kemungkinan komplikasi dan kematian ibu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

2. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi

Aspek ini mencakup penyampaian informasi dan layanan kontrasepsi guna mendukung individu atau pasangan dalam mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak. Penggunaan metode kontrasepsi modern terbukti mampu menurunkan angka kehamilan yang tidak terencana serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak (Cleland et al., 2021). Program keluarga berencana juga memiliki peranan penting dalam mengendalikan pertumbuhan populasi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (BKKBN, 2022).

3. Pencegahan dan Penanganan Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi menular seksual, termasuk HIV, masih menjadi perhatian utama dalam isu kesehatan reproduksi di seluruh dunia. Upaya untuk mencegahnya dilakukan melalui penyuluhan, penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, serta diagnostic dan perawatan awal (Rowley et al., 2019). Penanganan IMS yang tepat sangat krusial untuk menghindari komplikasi jangka panjang seperti infertilitas serta mengurangi kemungkinan penularan penyakit (WHO, 2022).

4. Deteksi Dini dan Penanganan Kanker Reproduksi

Kanker serviks dan kanker payudara adalah penyebab utama yang berkontribusi besar pada angka morbiditas dan mortalitas bagi perempuan yang berada dalam usia subur. Usaha deteksi dini melalui metode skrining seperti Pap smear dan pengecekan HPV menjadi bagian penting untuk menurunkan prioritas kejadian serta kematian akibat kanker (Arbyn et al., 2020). Program skrining yang terintegrasi dalam sistem layanan kesehatan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan perempuan.

5. Kesehatan Seksual dan Hak Reproduksi

Kesehatan seksual berhubungan dengan kapasitas individu untuk memiliki kehidupan seksual yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hak reproduksi mencakup kebebasan individu dalam membuat pilihan berkaitan dengan reproduksi secara bertanggung jawab, termasuk akses terhadap informasi serta layanan kesehatan yang memadai (United Nations Population

Fund [UNFPA], 2022). Pendekatan ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

6. Kesehatan Pemuda dan Pendidikan Seksual

Kelompok remaja adalah segmen yang sangat rentan terhadap isu-isu kesehatan reproduksi, contohnya adalah kehamilan pada usia muda serta infeksi yang ditularkan secara seksual. Oleh karena itu, program pendidikan mengenai kesehatan reproduksi yang menyeluruh sangat penting dalam usaha pencegahan (WHO, 2022). Pengajaran yang baik sejak dini bisa meningkatkan pemahaman dan membangun perilaku sehat yang bermanfaat.

7. Kesehatan Reproduksi pada Usia Dewasa (Perimenopause dan Menopause)

Kesehatan reproduksi juga meliputi periode perimenopause dan menopause yang ditandai dengan perubahan kadar hormon serta kemungkinan meningkatnya risiko penyakit degeneratif. Layanan kesehatan saat fase ini bertujuan untuk membantu perempuan dalam mengatasi gejala yang terjadi dan menjaga kualitas hidup melalui pencegahan serta penanganan penyakit (WHO, 2022).

F. Determinan Kesehatan Reproduksi

Determinan kesehatan reproduksi adalah elemen-elemen yang mempengaruhi kondisi kesehatan reproduksi baik bagi individu maupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendekatan terhadap determinan ini memiliki sifat multidimensi karena melibatkan interaksi antara faktor-faktor biologis, perilaku, sosial, ekonomi, lingkungan, dan sistem layanan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa kesehatan reproduksi tak dapat dipisahkan dari faktor sosial yang mengatur akses, tindakan, dan hasil kesehatan (World Health Organization [WHO], 2022). Oleh karena itu, pemahaman mengenai determinan menjadi sangat krusial dalam merancang intervensi kesehatan reproduksi yang efektif dan berbasis bukti.

1. Determinan Biologis

Faktor biologis adalah determinan utama yang terkait langsung dengan fungsi sistem reproduksi, mencakup usia, status gizi, dan kondisi kesehatan individu. Usia yang terlalu muda atau terlalu tua dalam periode reproduktif diketahui dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, seperti preeklamsia dan kelahiran prematur (Neal et al., 2021). Selain itu, status gizi, terutama kekurangan zat besi, turut berkontribusi pada kejadian anemia di kalangan perempuan usia subur yang berakibat pada meningkatnya risiko morbiditas maternal (Black et al., 2020). Penyakit kronis seperti diabetes, obesitas,

dan gangguan endokrin juga berpotensi mempengaruhi kesuburan dan hasil kehamilan.

2. Determinan Perilaku

Perilaku kesehatan individu memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan kondisi kesehatan reproduksinya. Tindakan seperti penggunaan alat kontrasepsi, praktik hubungan seksual yang aman, dan kepatuhan terhadap pemeriksaan kesehatan (antenatal care) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil reproduksi (Cleland et al., 2021). Rendahnya tingkat pemahaman tentang kesehatan reproduksi sering kali menjadi penyebab perilaku berisiko, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual (WHO, 2022).

3. Determinasi Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya mencakup berbagai elemen seperti pendidikan, posisi ekonomi, norma-norma sosial, serta praktik budaya yang berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Wanita dengan pendidikan yang rendah umumnya mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi serta layanan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi (Marmot et al., 2020). Di samping itu, praktik budaya seperti pernikahan di usia muda masih menjadi isu di banyak negara berkembang, yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko komplikasi selama masa kehamilan serta angka kematian ibu (UNICEF, 2022).

4. Determinan Ekonomi

Situasi ekonomi memengaruhi seberapa mudah individu dapat mengakses layanan kesehatan reproduksi, termasuk akses kepada kontrasepsi dan pemeriksaan kesehatan yang rutin. Kendala ekonomi dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan risiko terkait masalah kesehatan reproduksi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

5. Determinan Lingkungan

Elemen lingkungan, seperti kondisi sanitasi, kualitas air, dan suasana tempat tinggal, juga berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Lingkungan yang tidak bersih dapat menambah kemungkinan terkena infeksi, termasuk infeksi yang memengaruhi sistem reproduksi (WHO, 2022). Paparan terhadap bahan berbahaya seperti zat kimia atau polusi juga bisa memengaruhi fungsi reproduksi secara negatif.

6. Determinan Sistem Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan, akses, dan mutu layanan kesehatan merupakan faktor penting bagi kesehatan reproduksi. Ketidakseimbangan dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil, dapat menyebabkan rendahnya akses

kepada layanan antenatal, persalinan, serta program keluarga berencana (Kruk et al., 2018). Standar pelayanan yang rendah dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang ada.

7. Determinan Kebijakan dan Program Kesehatan

Kebijakan kesehatan yang berlaku secara nasional serta program-program kesehatan reproduksi memiliki peranan kunci dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Intervensi berbasis kebijakan seperti program keluarga berencana, pencegahan anemia, dan layanan kesehatan untuk ibu adalah bagian dari upaya yang berdampak besar pada kesehatan reproduksi (BKKBN, 2022).

G. Promosi Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Promosi kesehatan reproduksi adalah sebuah usaha krusial untuk memperkaya pemahaman, sikap, dan tindakan sehat di kalangan wanita yang berada dalam usia subur melalui pendekatan yang mengutamakan pencegahan dan promosi yang saling terintegrasi di dalam layanan kesehatan (World Health Organization [WHO], 2021). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perubahan tindakan individu, tetapi juga mencakup pemberdayaan komunitas serta penguatan elemen sosial yang berpengaruh terhadap keadaan kesehatan reproduksi. Dalam lingkup kesehatan masyarakat, promosi kesehatan reproduksi memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi angka kematian ibu, menghindari kehamilan yang tidak terencana, serta memperbaiki kualitas hidup perempuan secara keseluruhan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Langkah utama dalam promosi kesehatan reproduksi mencakup pendidikan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan melalui penyampaian informasi yang tepat sasaran, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan komunitas (WHO, 2022). Materi pendidikan melibatkan pemahaman mengenai siklus menstruasi, kesehatan seksual, penggunaan alat kontrasepsi, serta pencegahan infeksi menular seksual, yang telah terbukti efektif dalam mendorong terbentuknya perilaku sehat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi (Bearak et al., 2020). Di samping itu, konseling mengenai perencanaan keluarga memiliki peran penting dalam promosi kesehatan, karena mendukung perempuan dan pasangannya dalam merencanakan kehamilan secara sehat dan bertanggung jawab, termasuk dalam memilih metode kontrasepsi yang tepat (Cleland et al., 2021).

Peningkatan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi adalah faktor yang sangat krusial karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami

informasi kesehatan dan membuat pilihan yang tepat (Nutbeam, 2021). Dengan pengetahuan yang cukup, wanita dalam masa subur akan lebih mudah mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan mengurangi risiko dari perilaku yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi. Di sisi lainnya, memberdayakan perempuan untuk mengambil keputusan terkait kesehatan adalah strategi kunci yang menekankan partisipasi aktif perempuan dalam menentukan opsi terkait reproduksi, termasuk penggunaan alat kontrasepsi dan perencanaan untuk kehamilan (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN], 2022). Pendekatan ini juga mendukung terciptanya kesetaraan gender serta perlindungan hak-hak reproduksi.

Metode yang berfokus pada masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan dan kelompok sosial terbukti efektif dalam meningkatkan penggunaan layanan kesehatan reproduksi, terutama di tingkat pelayanan kesehatan dasar (Perry et al., 2020). Kader kesehatan berperan sebagai penghubung antara tenaga medis dan masyarakat, sehingga dapat memperluas distribusi informasi, memperkuat pendidikan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan intervensi yang lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, sehingga meningkatkan efektivitas program promosi kesehatan (WHO, 2021).

Oleh karena itu, promosi kesehatan reproduksi bagi perempuan dalam usia subur merupakan suatu upaya komprehensif yang termasuk edukasi, pemberdayaan, serta penguatan sistem layanan kesehatan dan peran komunitas. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat dan memberikan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

H. Issue Aktual Kesehatan Reproduksi

Permasalahan kesehatan reproduksi pada wanita yang berada dalam rentang usia subur terus beradaptasi mengikuti perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, dan kemajuan teknologi, sehingga diperlukan pendekatan yang fleksibel dan berbasis data yang akurat. Berbagai studi terbaru memperlihatkan bahwa meskipun layanan kesehatan reproduksi telah menunjukkan beberapa kemajuan, masih terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi mutu kesehatan perempuan baik di tingkat internasional maupun domestik (World Health Organization [WHO], 2023).

Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi modern yang tidak diimbangi dengan berkurangnya kebutuhan

kontrasepsi yang tak terpenuhi. Situasi ini menggambarkan adanya gap antara kebutuhan dan penggunaan layanan kontrasepsi, yang dipengaruhi oleh akses yang terbatas, mutu layanan, serta faktor sosial dan budaya (Bearak et al., 2020). Di Indonesia, kebutuhan yang tidak terpenuhi masih menjadi hambatan dalam program keluarga berencana disebabkan oleh kurangnya informasi, variasi preferensi metode kontrasepsi, dan distribusi layanan kesehatan yang belum merata (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN], 2022). Keadaan ini turut berkontribusi pada meningkatnya angka kehamilan yang tidak direncanakan yang berdampak pada kesehatan ibu dan anak.

Selanjutnya, tingginya angka kejadian anemia pada wanita usia subur juga memerlukan perhatian yang serius. Anemia, khususnya yang disebabkan oleh kekurangan zat besi, merupakan isu kesehatan masyarakat yang dapat mengurangi produktivitas, meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, dan berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Secara global, prevalensi anemia di antara perempuan usia subur sangat berkaitan dengan status gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap intervensi kesehatan seperti suplementasi zat besi (Black et al., 2020).

Perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pemanfaatan media sosial, aplikasi kesehatan, dan platform digital memungkinkan distribusi informasi kesehatan yang lebih cepat dan luas, berpotensi meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi di kalangan generasi muda, menurut WHO pada tahun 2022. Meski begitu, kemajuan ini juga menimbulkan masalah, mengingat adanya banyak informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat merugikan perilaku kesehatan, seperti yang diungkapkan oleh Nutbeam pada tahun 2021. Maka dari itu, perlu ada usaha untuk meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu memilih informasi yang benar dan terpercaya.

Masalah lainnya yang juga sangat penting adalah ketidakmerataan akses pada layanan kesehatan reproduksi di berbagai daerah, terutama antara kota dan desa atau daerah terpencil. Ketidakeimbangan ini meliputi kurangnya tenaga medis, infrastruktur layanan yang memadai, serta distribusi sumber daya kesehatan yang masih tidak seimbang, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023. Dampak dari situasi ini adalah rendahnya penggunaan layanan kesehatan reproduksi, seperti pemeriksaan kehamilan, persalinan yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan, dan akses terhadap alat kontrasepsi modern, sebagaimana dinyatakan oleh Kruk dan rekan-rekannya pada tahun 2018. Kesenjangan ini juga mencerminkan adanya ketimpangan sosial ekonomi yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan terbaru dalam kesehatan reproduksi untuk perempuan yang berada dalam usia subur menggambarkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, masih diperlukan upaya menyeluruh melalui penguatan sistem kesehatan, peningkatan pendidikan, serta pemanfaatan teknologi yang cerdas. Pendekatan berbasis bukti yang melibatkan banyak sektor menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan tersebut untuk meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan secara berkelanjutan.

I. Pendekatan Intervensi Kesehatan Reproduksi

Perempuan dalam rentang usia subur (PUS) mencakup wanita berusia antara 15 hingga 49 tahun yang berada dalam fase reproduksi aktif, sehingga secara biologis mereka mampu mengalami ovulasi, pembuahan, dan kehamilan (Badan Pusat Statistik [BPS], 2022; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Kelompok ini memiliki peranan yang signifikan dalam pembangunan kesehatan, berkaitan erat dengan berbagai indikator nasional, seperti jumlah kematian ibu (AKI), angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR), serta kualitas generasi yang akan datang. Di tingkat global, populasi perempuan usia reproduktif telah mencapai lebih dari 1,9 miliar, dan menjadi target utama untuk berbagai intervensi dalam kesehatan reproduksi (United Nations Population Fund [UNFPA], 2022). Di Indonesia, angka kematian ibu (AKI) masih berada pada angka sekitar 189 setiap 100.000 kelahiran hidup, menunjukkan bahwa peningkatan dalam layanan kesehatan reproduksi masih sangat dibutuhkan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Dari sudut pandang kesehatan global, kesehatan reproduksi perempuan tidak hanya dipandang dari aspek medis, tetapi juga merupakan bagian krusial dari pembangunan manusia, pemenuhan hak atas kesehatan, serta kesetaraan gender (Starrs et al., 2018; UNFPA, 2022). Organisasi Kesehatan Dunia mendeskripsikan kesehatan reproduksi sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh dalam semua hal yang berhubungan dengan berbagai aspek sistem serta fungsi reproduksi (World Health Organization [WHO], 2022). Secara global, sekitar 287.000 perempuan meninggal setiap tahun akibat komplikasi yang terjadi saat kehamilan dan persalinan, dimana sebagian besar kematian tersebut sebenarnya bisa dicegah, menjadikan kesehatan reproduksi sebagai fokus utama dalam pencapaian Sustainable Development Goals (WHO, 2023).

Di tanah air, isu-isu seputar kesehatan reproduksi masih sangat rumit dan melibatkan banyak aspek. Beberapa tantangan yang ada meliputi tingginya prevalensi anemia pada wanita dalam masa subur yang masih di atas 30%, adanya

kebutuhan kontrasepsi yang belum terjawab sekitar 10–12%, ditambah dengan tingginya angka kehamilan yang tidak terencana serta praktik pernikahan di usia muda di beberapa lokasi (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN], 2022; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Di samping itu, perbedaan akses layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta rendahnya tingkat pengetahuan mengenai kesehatan ikut memperburuk situasi kesehatan para wanita di usia subur (Marmot et al., 2020; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Berbagai tantangan tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi saat hamil dan melahirkan, seperti pendarahan, preeklamsia, dan kelahiran prematur, yang merupakan faktor utama penyebab sakit dan kematian pada ibu (Neal et al., 2021). Maka dari itu, pemahaman yang komprehensif tentang konsep dasar wanita dalam masa subur dan kesehatan reproduksi sangat penting sebagai landasan dalam praktik klinis, pendidikan kesehatan, serta pengembangan kebijakan berbasis bukti untuk memperbaiki kesehatan wanita dan kualitas generasi berikutnya.

J. Simpulan

Perempuan dalam rentang usia subur (PUS) merupakan segmen yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan sektor kesehatan karena mereka berada dalam fase reproduktif yang aktif dan berdampak langsung pada indikator-indikator kesehatan seperti tingkat kematian ibu, angka kelahiran, dan kualitas generasi yang akan datang. Kesehatan reproduksi pada individu-individu ini sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek, termasuk dimensi biologis, psikologis, sosial, dan perilaku, yang juga dipengaruhi oleh sistem pelayanan kesehatan dan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan kesehatan reproduksi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan terpisah-pisah, dengan pendekatan yang terpadu yang mencakup aspek klinis, kesehatan publik, hak reproduksi, psikososial, serta pandangan sepanjang siklus kehidupan. Ini mencakup beragam layanan penting seperti kesehatan maternal, program keluarga berencana, pencegahan infeksi menular seksual, deteksi dini kanker reproduksi, kesehatan seksual, pendidikan reproduksi untuk remaja, hingga perawatan kesehatan saat menopause yang memerlukan layanan yang kontinu sepanjang kehidupan perempuan.

Di sisi lain, berbagai faktor mempengaruhi status kesehatan reproduksi perempuan usia subur, seperti keadaan biologis, perilaku, budaya sosial, ekonomi, lingkungan, serta ketersediaan dan mutu pelayanan kesehatan. Berbagai tantangan yang masih ada, seperti tingginya angka anemia, kebutuhan kontrasepsi yang belum

terpenuhi, kehamilan yang tidak direncanakan, perbedaan akses terhadap layanan, dan dampak digitalisasi pada informasi kesehatan, menunjukkan bahwa isu kesehatan reproduksi belum mendapatkan perhatian yang cukup. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui promosi kesehatan yang fokus pada edukasi, peningkatan literasi kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan pendekatan berbasis komunitas. Selain itu, penguatan layanan kesehatan primer, kerjasama antarsektor, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis bukti sangat diperlukan untuk mencapai perbaikan dalam derajat kesehatan perempuan dan membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.

Referensi

- Arbyn, M., Weiderpass, E., Bruni, L., de Sanjosé, S., Saraiya, M., Ferlay, J., & Bray, F. (2020). Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2018. *The Lancet Global Health*, 8(2), e191–e203. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30482-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30482-6)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). Laporan kinerja program Bangga Kencana. <https://www.bkkbn.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2022. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2020). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 395 (10217), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30152-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30152-1)
- Bull, J. R., Rowland, S. P., Scherwitzl, E. B., Scherwitzl, R., Danielsson, K. G., & Harper, J. (2019). Real-world menstrual cycle characteristics of more than 600,000 menstrual cycles. *BMJ Open*, 9 (2), e022895. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022895>
- Bearak, J., Popinchalk, A., Alkema, L., & Sedgh, G. (2020). Unintended pregnancy and outcomes. *The Lancet Global Health*, 8(9), e1152–e1161. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30315-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30315-6)
- Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Reproductive health. <https://www.cdc.gov/reproductivehealth>
- Cleland, J., Conde-Agudelo, A., Peterson, H., Ross, J., & Tsui, A. (2021). Contraception and health. *The Lancet*, 397(10278), 150–166. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30315-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30315-7)
- Howard, L. M., Ryan, E. G., Trevillion, K., Anderson, F., Bick, D., Bye, A., ... & Pickles, A. (2021). Accuracy of the Whooley questions and the Edinburgh Postnatal Depression Scale in identifying depression during pregnancy and the postnatal period. *The Lancet Psychiatry*, 8 (4), 315–325. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30463-2](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30463-2)
- Howard, L. M., Ryan, E. G., Trevillion, K., Anderson, F., Bick, D., Bye, A., & Pickles, A. (2021). Perinatal mental health. *The Lancet Psychiatry*, 8(4), 315–325. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30463-2](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30463-2)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023. Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id>
- Marmot, M., Allen, J., Boyce, T., Goldblatt, P., & Morrison, J. (2020). Health equity in England: The Marmot Review 10 years on. *The Lancet*, 395(10227), 1411–

1413. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30776-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30776-9)

- Neal, S., Channon, A. A., & Chintsanya, J. (2021). The impact of young maternal age at birth on neonatal mortality: Evidence from 45 low and middle income countries. *The Lancet*, 398(10298), 519–520. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00569-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00569-8)
- Nutbeam, D. (2021). Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education. *Health Promotion International*, 36(1), 1–9. <https://doi.org/10.1093/heapro/daaa116>
- Perry, H. B. (2020). Community health workers programs. *Annual Review of Public Health*, 41, 399–421. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040119-094247>
- Reed, B. G., & Carr, B. R. (2020). The normal menstrual cycle and the control of ovulation. In L. J. De Groot et al. (Eds.), *Endotext*. MDText.com, Inc. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279054/>
- Rowley, J., Vander Hoorn, S., Korenromp, E., Low, N., Unemo, M., Abu-Raddad, L. J., ... & Newman, L. (2019). Chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis and syphilis prevalence. *The Lancet Global Health*, 7(8), e981–e991. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30241-8](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30241-8)
- Starrs, A. M., Ezeh, A. C., Barker, G., Basu, A., Bertrand, J. T., Blum, R., & Ashford, L. S. (2018). Accelerate progress—sexual and reproductive health and rights. *The Lancet*, 391(10140), 2642–2692. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30293-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30293-9)
- Teede, H. J., Misso, M. L., Costello, M. F., Dokras, A., Laven, J., Moran, L., ... & Norman, R. J. (2018). Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. *Human Reproduction*, 33 (9), 1602–1618. <https://doi.org/10.1093/humrep/dey256>
- United Nations Population Fund. (2022). State of world population 2022: Seeing the unseen—The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy. UNFPA. <https://www.unfpa.org>
- UNICEF. (2022). Child marriage: Latest trends and future prospects. UNICEF. <https://www.unicef.org>
- UNICEF. (2022). Child marriage: Latest trends and future prospects. <https://www.unicef.org>
- World Health Organization. (2022). Sexual and reproductive health and rights. World Health Organization. <https://www.who.int/health-topics/reproductive-health>
- World Health Organization. (2023). Maternal health. <https://www.who.int>

World Health Organization. (2022). Sexual and reproductive health.
<https://www.who.int/health-topics/reproductive-health>

World Health Organization. (2021). Health promotion. <https://www.who.int>

Glosarium

Perempuan Usia Subur (PUS)	: Kelompok perempuan berusia 15–49 tahun yang berada pada fase reproduksi aktif dan memiliki kemampuan untuk ovulasi, pembuahan, serta kehamilan.
Kesehatan Reproduksi	: Keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan sekadar bebas dari penyakit.
Ovulasi	: Proses pelepasan sel telur (ovum) dari ovarium sebagai bagian dari siklus menstruasi.
Siklus Menstruasi	: Siklus biologis pada perempuan yang berlangsung sekitar 21–35 hari, mencerminkan keseimbangan hormonal dan kesiapan reproduksi.
Hormon Estrogen dan Progesteron	: Hormon reproduksi utama pada perempuan yang mengatur siklus menstruasi dan fungsi reproduksi.
Anemia	: Kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin, sering disebabkan defisiensi zat besi, yang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi.
Kehamilan Tidak Direncanakan	: Kehamilan yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya, sering dikaitkan dengan kurangnya akses atau penggunaan kontrasepsi.
Kontrasepsi	: Metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan.
Keluarga Berencana (KB)	: Program untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Antenatal Care (ANC)	: Pelayanan kesehatan selama kehamilan untuk memantau kondisi ibu dan janin.
Persalinan	: Proses kelahiran bayi dari rahim ibu.
Nifas	: Masa setelah persalinan hingga organ reproduksi kembali seperti semula.
Infeksi Menular Seksual (IMS)	: Infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk HIV.

Kanker Reproduksi	: Kanker yang menyerang organ reproduksi, seperti kanker serviks dan payudara.
Pap Smear	: Metode skrining untuk mendeteksi dini kanker serviks.
Hak Reproduksi	: Hak individu untuk menentukan pilihan terkait reproduksi secara bebas, bertanggung jawab, dan tanpa diskriminasi.
Kesehatan Seksual	: Kondisi sejahtera terkait aktivitas seksual yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
Perimenopause	: Masa transisi sebelum menopause yang ditandai perubahan hormonal.
Menopause	: Berhentinya siklus menstruasi secara permanen akibat penurunan fungsi ovarium.
Determinasi Kesehatan	: Faktor-faktor yang memengaruhi status kesehatan, meliputi biologis, perilaku, sosial, ekonomi, lingkungan, dan layanan kesehatan.
Promosi Kesehatan	: Upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Literasi Kesehatan	: Kemampuan individu dalam memahami informasi kesehatan untuk mengambil keputusan yang tepat.
Preeklamsia	: Komplikasi kehamilan yang ditandai tekanan darah tinggi dan dapat membahayakan ibu serta janin.
Kelahiran Prematur	: Kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu.

CHAPTER 2

PERMASALAHAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA USIA SUBUR

Syahridayanti, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi merupakan kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Wanita usia subur (WUS), yaitu perempuan berusia 15–49 tahun, merupakan kelompok yang memiliki peran strategis dalam pembangunan kesehatan karena berkaitan langsung dengan kehamilan, persalinan, dan kualitas generasi berikutnya.

Secara global, berbagai permasalahan kesehatan reproduksi masih menjadi tantangan utama. *World Health Organization* (WHO) melaporkan bahwa anemia, infeksi menular seksual (IMS), kehamilan tidak diinginkan, serta kanker serviks masih berkontribusi signifikan terhadap morbiditas perempuan usia reproduktif (WHO, 2023). Di negara berkembang, beban masalah ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Di Indonesia, data Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada wanita usia subur masih tinggi, sementara cakupan skrining kanker serviks dan penggunaan kontrasepsi modern belum optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.

B. Pembahasan

1. Anemia pada Wanita Usia Subur

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum terjadi pada wanita usia subur (WUS) dan masih menjadi perhatian utama dalam bidang kesehatan masyarakat, khususnya di negara berkembang. Secara klinis, anemia didefinisikan sebagai kondisi ketika kadar hemoglobin (Hb) dalam darah berada di bawah nilai normal, sehingga kemampuan darah dalam mengangkut oksigen ke jaringan tubuh menjadi menurun. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi fungsi kognitif dan kualitas hidup perempuan secara keseluruhan.

Berdasarkan berbagai penelitian terkini, prevalensi anemia pada WUS masih tergolong tinggi, terutama disebabkan oleh defisiensi zat besi sebagai faktor utama. Kekurangan zat besi umumnya terjadi akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat, rendahnya konsumsi makanan sumber zat besi heme, serta kebiasaan diet yang tidak seimbang. Selain itu, faktor fisiologis seperti kehilangan darah selama menstruasi yang berlangsung setiap bulan turut berkontribusi terhadap penurunan cadangan zat besi dalam tubuh (Nguyen et al., 2021).

Selain faktor gizi, anemia pada WUS juga dipengaruhi oleh berbagai determinan lain, seperti infeksi kronis, penyakit parasit (misalnya kecacingan), kondisi sosial ekonomi, serta rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada kurangnya pengetahuan tentang pola makan sehat. Dampak anemia pada wanita usia subur cukup luas, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks reproduksi. Secara umum, anemia dapat menyebabkan kelelahan, penurunan daya tahan tubuh, gangguan konsentrasi, serta menurunkan produktivitas kerja.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk kualitas hidup perempuan. Lebih lanjut, apabila anemia terjadi pada perempuan yang sedang hamil, risiko komplikasi akan meningkat secara signifikan, seperti persalinan prematur, bayi berat lahir rendah (BBLR), bahkan kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan anemia pada WUS menjadi langkah strategis dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu.

Upaya penanggulangan anemia pada WUS perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan promotif, preventif, dan kuratif. Intervensi yang direkomendasikan meliputi pemberian suplementasi zat besi secara rutin, khususnya pada remaja putri dan WUS, fortifikasi bahan pangan dengan zat besi, serta peningkatan edukasi mengenai gizi seimbang.

2. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)

Kehamilan tidak diinginkan (KTD) merupakan kondisi ketika kehamilan terjadi tanpa perencanaan atau pada waktu yang tidak diharapkan oleh pasangan, baik karena tidak menginginkan anak sama sekali maupun karena waktu kehamilan yang tidak sesuai. Fenomena ini masih menjadi masalah kesehatan reproduksi yang signifikan di berbagai negara, terutama di negara berkembang.

Studi global menunjukkan bahwa sekitar hampir separuh dari seluruh kehamilan yang terjadi setiap tahunnya termasuk dalam kategori tidak diinginkan, yang mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan reproduksi (Bearak et al., 2020). Berbagai faktor berkontribusi terhadap terjadinya KTD, di antaranya adalah rendahnya pengetahuan tentang metode kontrasepsi, keterbatasan akses terhadap layanan

keluarga berencana, serta penggunaan kontrasepsi yang tidak konsisten atau tidak tepat.

Penelitian juga menunjukkan bahwa faktor sosial seperti norma budaya, ketimpangan gender, serta rendahnya tingkat pendidikan perempuan turut memperburuk kondisi ini. Selain itu, kurangnya keterlibatan pasangan dalam pengambilan keputusan terkait reproduksi juga menjadi faktor yang berpengaruh (Sedgh et al., 2019; Brown, 2020).

Dampak kehamilan tidak diinginkan sangat luas dan tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan fisik. Dari sisi medis, KTD meningkatkan risiko praktik aborsi tidak aman yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti perdarahan, infeksi, hingga kematian ibu. Dari aspek psikologis, perempuan dengan KTD lebih rentan mengalami stres, depresi, dan kecemasan. Sementara itu, dari sisi sosial, KTD dapat menyebabkan stigma, putus sekolah, serta beban ekonomi yang meningkat, terutama pada kelompok usia muda dan rentan (Bearak et al., 2020).

Upaya pencegahan KTD perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif menjadi kunci utama dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan wanita usia subur. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan keluarga berencana yang berkualitas, termasuk ketersediaan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang aman dan efektif, sangat diperlukan. Pendekatan berbasis komunitas serta penguatan peran tenaga kesehatan juga terbukti efektif dalam menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan (WHO, 2022).

3. Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan kelompok penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal, maupun oral, dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan secara global. Jenis IMS yang paling umum meliputi klamidia, gonore, sifilis, serta infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Berdasarkan hasil penelitian epidemiologi, IMS seringkali bersifat asimtomatik, terutama pada perempuan, sehingga banyak kasus tidak terdiagnosis dan tidak mendapatkan penanganan yang adekuat (Rowley et al., 2019). Kondisi ini menyebabkan IMS menjadi "silent epidemic" yang berpotensi menimbulkan komplikasi jangka panjang.

Berbagai faktor risiko berkontribusi terhadap tingginya kejadian IMS pada wanita usia subur, di antaranya perilaku seksual berisiko, seperti berganti-ganti pasangan, penggunaan kondom yang tidak konsisten, serta rendahnya

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Selain itu, faktor struktural seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, stigma sosial, dan kurangnya skrining rutin turut memperparah situasi.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa ketimpangan gender dan rendahnya posisi tawar perempuan dalam hubungan seksual dapat meningkatkan kerentanan terhadap IMS (Unemo et al., 2021). Dampak IMS terhadap kesehatan reproduksi sangat signifikan. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan penyakit radang panggul, infertilitas, kehamilan ektopik, serta meningkatkan risiko penularan HIV. Selain itu, infeksi Human Papillomavirus (HPV) diketahui sebagai penyebab utama kanker serviks. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian IMS perlu dilakukan secara komprehensif melalui edukasi perilaku seksual sehat, penggunaan kondom, vaksinasi (seperti HPV), serta peningkatan akses terhadap layanan skrining dan pengobatan yang tepat (WHO, 2021).

4. Kesehatan Menstruasi

Gangguan menstruasi merupakan aspek penting dalam kesehatan reproduksi perempuan yang mencakup kondisi fisik, psikologis, dan sosial selama siklus menstruasi. Menstruasi yang sehat ditandai dengan siklus yang teratur, durasi dan jumlah perdarahan yang normal, serta tidak disertai keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa gangguan menstruasi seperti dismenore, amenore, dan siklus tidak teratur masih sering terjadi pada wanita usia subur dan menjadi salah satu penyebab utama penurunan kualitas hidup perempuan (Critchley et al., 2020).

Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan menstruasi sangat beragam, meliputi aspek hormonal, status gizi, tingkat stres, aktivitas fisik, serta kondisi medis tertentu seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS). Studi terbaru menunjukkan bahwa stres psikologis dan gaya hidup modern, termasuk kurangnya aktivitas fisik dan pola makan tidak seimbang, berkontribusi signifikan terhadap ketidakaturan siklus menstruasi. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan menstruasi dan adanya stigma sosial juga dapat menghambat perempuan dalam mencari pertolongan medis (Hennegan et al., 2021).

Dampak gangguan kesehatan menstruasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis dan sosial. Perempuan dengan gangguan menstruasi sering mengalami keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan menstruasi perlu dilakukan melalui edukasi yang komprehensif, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta penyediaan fasilitas yang mendukung manajemen kebersihan menstruasi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan (Critchley et al., 2020; Hennegan et al., 2021).

5. Kanker Serviks

Kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada perempuan, khususnya di negara berkembang, dan menjadi penyebab utama kematian terkait kanker pada wanita usia subur. Secara etiologi, kanker serviks hampir seluruhnya disebabkan oleh infeksi persisten Human Papilloma Virus (HPV), terutama tipe onkogenik seperti HPV-16 dan HPV-18. Penelitian menunjukkan bahwa infeksi HPV yang tidak terdeteksi dan tidak ditangani sejak dini dapat berkembang menjadi lesi prakanker dan akhirnya menjadi kanker invasif dalam kurun waktu beberapa tahun (Sung et al., 2021).

Tingginya angka kejadian kanker serviks mencerminkan masih rendahnya cakupan pencegahan dan deteksi dini. Berbagai faktor risiko berkontribusi terhadap terjadinya kanker serviks, antara lain aktivitas seksual pada usia dini, memiliki banyak pasangan seksual, merokok, serta sistem imun yang lemah. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan skrining seperti pap smear dan inspeksi visual dengan asam asetat (IVA) menjadi faktor penting yang menyebabkan banyak kasus terdiagnosis pada stadium lanjut. Studi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan perempuan mengenai kanker serviks dan pentingnya skrining juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan (Arbyn et al., 2020).

Upaya pencegahan kanker serviks dapat dilakukan secara primer dan sekunder. Pencegahan primer meliputi vaksinasi HPV yang terbukti efektif dalam mencegah infeksi tipe HPV berisiko tinggi. Sementara itu, pencegahan sekunder dilakukan melalui skrining rutin untuk mendeteksi lesi prakanker sejak dini. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara vaksinasi dan skrining yang terorganisir dapat secara signifikan menurunkan angka kejadian dan kematian akibat kanker serviks. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, akses layanan kesehatan, serta dukungan kebijakan untuk memperluas cakupan program pencegahan kanker serviks (Bruni et al., 2021).

6. Masalah Fertilitas

Infertilitas merupakan kondisi ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi selama minimal 12 bulan. Masalah ini menjadi isu kesehatan reproduksi yang semakin meningkat secara global dan berdampak tidak hanya pada aspek biologis, tetapi juga psikologis dan sosial. Data penelitian menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 6 pasangan di dunia mengalami infertilitas,

dengan prevalensi yang cenderung lebih tinggi di negara berkembang akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi (WHO, 2023).

Penyebab infertilitas bersifat multifaktorial dan dapat berasal dari faktor perempuan, laki-laki, maupun kombinasi keduanya. Pada perempuan, penyebab utama meliputi gangguan ovulasi, sindrom ovarium polikistik (PCOS), endometriosis, serta kelainan pada tuba falopi. Sementara itu, faktor gaya hidup seperti obesitas, merokok, konsumsi alkohol, serta paparan lingkungan juga berkontribusi terhadap penurunan kesuburan. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup modern memiliki korelasi signifikan dengan peningkatan kasus infertilitas dalam beberapa dekade terakhir (Mascarenhas et al., 2020).

Dampak infertilitas tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan sosial pasangan, terutama perempuan. Individu yang mengalami infertilitas seringkali menghadapi tekanan emosional, stigma sosial, serta gangguan hubungan interpersonal. Oleh karena itu, penanganan infertilitas memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup diagnosis yang tepat, intervensi medis, serta dukungan psikologis. Teknologi reproduksi berbantu seperti *in vitro fertilization* (IVF) telah menjadi salah satu solusi efektif, meskipun akses terhadap layanan ini masih terbatas di beberapa negara (Inhorn & Patrizio, 2020).

7. Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang ditujukan kepada individu berdasarkan perbedaan gender, yang sebagian besar dialami oleh perempuan. KBG mencakup kekerasan fisik, seksual, emosional, maupun ekonomi, dan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di berbagai negara. Berdasarkan hasil penelitian global, sekitar satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya, yang menunjukkan tingginya prevalensi masalah ini (WHO, 2021).

Kondisi ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan berbasis gender, di antaranya norma sosial yang mendukung ketimpangan gender, rendahnya tingkat pendidikan, ketergantungan ekonomi, serta lemahnya perlindungan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi lebih rentan mengalami kekerasan. Selain itu, dinamika relasi kekuasaan dalam hubungan interpersonal juga berperan penting dalam meningkatkan risiko terjadinya kekerasan (Devries et al., 2020).

Dampak kekerasan berbasis gender terhadap kesehatan reproduksi sangat signifikan. Perempuan yang mengalami kekerasan memiliki risiko lebih tinggi

mengalami infeksi menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, komplikasi kehamilan, serta gangguan kesehatan mental seperti depresi dan gangguan stres pascatrauma. Oleh karena itu, penanganan KBG memerlukan pendekatan multidisiplin yang mencakup layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta perlindungan hukum. Intervensi berbasis komunitas dan peningkatan kesadaran masyarakat juga terbukti efektif dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender (WHO, 2021; UN Women, 2022).

8. Akses Layanan Kesehatan Reproduksi

Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan wanita usia subur. Layanan ini mencakup berbagai aspek, seperti pelayanan keluarga berencana, pemeriksaan kehamilan, skrining kanker serviks, serta penanganan infeksi menular seksual. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan reproduksi masih belum merata. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, dan ketersediaan fasilitas kesehatan, sehingga banyak perempuan belum mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya (Starrs et al., 2018; WHO, 2021).

Selain faktor struktural, akses layanan kesehatan reproduksi juga dipengaruhi oleh faktor individu dan sosial, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, serta norma budaya yang berkembang di masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki pemanfaatan layanan kesehatan yang lebih rendah. Selain itu, stigma terhadap isu kesehatan reproduksi, khususnya terkait seksualitas dan penggunaan kontrasepsi, seringkali menjadi hambatan dalam mencari layanan kesehatan. Faktor lain seperti kurangnya tenaga kesehatan terlatih dan keterbatasan informasi juga turut memengaruhi rendahnya akses layanan (Ahmed et al., 2020).

Dampak keterbatasan akses layanan kesehatan reproduksi sangat luas, termasuk meningkatnya angka kehamilan tidak diinginkan, tingginya prevalensi infeksi menular seksual, serta rendahnya deteksi dini penyakit seperti kanker serviks. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan akses layanan melalui penguatan sistem kesehatan, peningkatan edukasi masyarakat, serta penyediaan layanan yang ramah dan terjangkau. Pendekatan berbasis komunitas dan integrasi layanan kesehatan reproduksi dalam pelayanan primer terbukti efektif dalam meningkatkan cakupan dan kualitas layanan (WHO, 2021; Ahmed et al., 2020).

C. Kesimpulan

Permasalahan kesehatan reproduksi pada wanita usia subur (WUS) mencakup berbagai kondisi yang saling berkaitan, seperti anemia, kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, gangguan kesehatan menstruasi, kanker serviks, infertilitas, hingga kekerasan berbasis gender. Sebagian besar masalah tersebut dipengaruhi oleh faktor gizi, perilaku, sosial ekonomi, serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap kesehatan reproduksi. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga psikologis dan sosial, serta dapat memengaruhi kualitas hidup perempuan dan generasi yang dilahirkan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi menjadi faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terpadu, diharapkan berbagai permasalahan kesehatan reproduksi pada WUS dapat diminimalkan sehingga derajat kesehatan perempuan dapat meningkat secara optimal.

Referensi

- Ahmed, S., Choi, Y., Rimon, J., et al. (2020). *Trends In Contraceptive Prevalence And Access To Reproductive Health Services. The Lancet Global Health*, 8(9), e-ISSN 1119–1128.
- Arbyn, M., Weiderpass, E., Bruni, L., de Sanjosé, S., Saraiya, M., Ferlay, J., & Bray, F. (2020). *Estimates Of Incidence And Mortality Of Cervical Cancer. The Lancet Global Health*, 8(2), e-ISSN: 191–203
- Bearak, J., Popinchalk, A., Ganatra, B., Moller, A. B., Tunçalp, Ö., Beavin, C., ... & Alkema, L. (2020). *Unintended Pregnancy And Abortion By Income, Region, And The Legal Status Of Abortion: Estimates from a comprehensive model for 1990–2019. The Lancet Global Health*, 8(9), e1152–e1161.
- Brown, L. (2020). *Reproductive Health In Developing Countries. International Journal of Gynecology*, 45(2), 123–130.
- Bruni, L., Albero, G., Serrano, B., Mena, M., Gómez, D., Muñoz, J., ... & Bosch, F. X. (2021). *Human Papillomavirus And Related Diseases Report. ICO/IARC*.
- Critchley, H. O. D., Babayev, E., Bulun, S. E., Clark, S., Garcia-Grau, I., Gregersen, P. K., ... & Fraser, I. S. (2020). *Menstruation: Science And Society. American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 223(5), 624–664.
- Devries, K. M., Mak, J. Y. T., García-Moreno, C., Petzold, M., Child, J. C., Falder, G., ... & Watts, C. H. (2020). *Global Health Burden Of Intimate Partner Violence. The Lancet*, 395(10232), 123–132.
- Hennegan, J., Winkler, I. T., Bobel, C., Keiser, D., Hampton, J., Larsson, G., ... & Mahon, T. (2021). *Menstrual Health: A Definition For Policy, Practice, And Research. Sexual and Reproductive Health Matters*, 29(1), 1911618.
- Inhorn, M. C., & Patrizio, P. (2020). *Infertility Around The Globe. Human Reproduction Update*, 26(1), 1–20.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Nasional Riskesdas 2022*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Mascarenhas, M. N., Flaxman, S. R., Boerma, T., Vanderpoel, S., & Stevens, G. A. (2020). *National, Regional, And Global Trends In Infertility Prevalence. PLoS Medicine*, 17(12), e1003096.
- Rowley, J., Vander Hoorn, S., Korenromp, E., Low, N., Unemo, M., Abu-Raddad, L. J., ... & Taylor, M. M. (2019). *Chlamydia, Gonorrhoea, Trichomoniasis And Syphilis: Global Prevalence And Incidence Estimates. Bulletin of the World Health Organization*, 97(8), 548–562.

- Sedgh, G., Ashford, L. S., & Hussain, R. (2019). *Unmet Need For Contraception In Developing Countries: Examining Women's Reasons For Not Using A Method*. Guttmacher Institute.
- Smith, A., Johnson, R., & Lee, P. (2021). *Women's Reproductive Health Issues*. Journal of Public Health, 39(4), 455–462.
- Starrs, A. M., Ezeh, A. C., Barker, G., et al. (2018). *Accelerate Progress—Sexual And Reproductive Health And Rights*. *The Lancet*, 391(10140), 2642–2692.
- Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). *Global cancer statistics 2020*. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 71(3), 209–249.
- Unemo, M., Bradshaw, C. S., Hocking, J. S., de Vries, H. J. C., Francis, S. C., Mabey, D., ... & Fairley, C. K. (2021). *Sexually transmitted infections: Challenges ahead*. *The Lancet Infectious Diseases*, 21(8), e-ISSN: 235–279.
- UN Women. (2022). *Violence Against Women Report*. New York: UN Women.
- World Health Organization. (2021). *Sexual and reproductive health and rights report*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2023). *Reproductive health report*. Geneva: WHO.

Glosarium

WUS	: Wanita Usia Subur
WHO	: World Health Organization
IMS	: Infeksi Menular Seksual
Hb	: Hemoglobin
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
KTD	: Kehamilan Tidak Diinginkan
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
IVA	: Inspeksi Visual Asam Asetat
HPV	: <i>Human Papillomavirus</i>
PCOS	: <i>Polycystic Ovary Syndrome</i>
IVF	: <i>In Vitro Fertilization</i>
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender



CHAPTER 3



DETEKSI DINI GANGGUAN MENSTRUASI DAN INFEKSI SALURAN REPRODUKSI

Dwi Ardani Rochmaniah, SST., Bdn., M.Keb.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh yang mempengaruhi kualitas hidup perempuan baik secara fisik, mental maupun secara sosial. Salah satu indikator kesehatan reproduksi wanita dapat kita nilai dari kondisi menstruasi dan juga organ reproduksi. Menstruasi yang normal menunjukkan fungsi hormonal dan organ reproduksi yang sehat, sedangkan munculnya gangguan menstruasi dan infeksi saluran reproduksi merupakan tanda adanya masalah kesehatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Gangguan menstruasi sering dianggap sebagai kondisi yang biasa pada masyarakat, sehingga banyak wanita yang mengabaikan kondisi mereka. Padahal gangguan menstruasi dapat menjadi tanda adanya masalah pada kesehatan reproduksi, gangguan hormon, stres, anemia, gangguan nutrisi, bahkan penyakit tertentu, seperti Sindroma Ovarium Polikistik (PCOS), endometriosis dan juga gangguan tiroid. Dengan adanya masalah tersebut, apabila tidak segera mendapatkan perhatian dan penanganan, maka akan berdampak pada kualitas hidup dan juga aktivitas yang dapat berpengaruh pada kesehatan reproduksi dan juga kesuburan dimasa yang akan datang.

Selain gangguan menstruasi, infeksi saluran reproduksi juga menjadi masalah kesehatan yang sering dialami perempuan terutama pada remaja dan wanita usia subur. Infeksi saluran reproduksi dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, virus maupun parasit yang dapat menyerang organ reproduksi. Kondisi ini biasanya ditandai dengan keputihan yang abnormal, gatal, nyeri, berbau tidak sedap, rasa panas/sensasi terbakar saat berkemih, nyeri saat berhubungan seksual, hingga nyeri panggul.

Deteksi dini terhadap gangguan menstruasi dan infeksi saluran reproduksi sangat penting dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanganan awal sebagai media dalam pengawasan pola menstruasi, kebersihan pada organ reproduksi dan mengenali tanda bahaya infeksi saluran reproduksi secara berkala. Dengan adanya

deteksi dini, maka masalah reproduksi dapat segera ditangani lebih dini dan dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat.

Edukasi kesehatan reproduksi merupakan langkah awal yang bisa diberikan pada remaja dan wanita usia subur supaya memiliki pemahaman, pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Pemahaman yang baik tentang deteksi dini gangguan menstruasi dan infeksi saluran reproduksi diharapkan dapat membantu wanita menentukan langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas hidup secara optimal.

B. KONSEP DASAR MENSTRUASI

1. Pengertian menstruasi

Menstruasi adalah proses fisiologis berupa peluruhan lapisan endometrium uterus yang terjadi secara periodik karena tidak terjadi pembuahan (Guyton & Hall, 2016). Menurut herien (2024), menstruasi adalah proses fisiologis pada wanita dimana lapisan endometrium yang menebal sebagai persiapan untuk kemungkinan terjadinya kehamilan luruh dan keluar dari tubuh melalui vagina. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase utama, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi dan fase luteal.

a. Fase Menstruasi

Pada fase menstruasi, lapisan endometrium terlepas dari dinding uterus dan disertai dengan perdarahan. Fase ini terjadipada hari ke-3 hingga hari ke-6 menstruasi. Awal fase menstruasi, kadar hormon esterogen, hormon progesteron dan Lutenizing hormon (LH) menurun, sedangkan kadar Folikel Stimulating Hormon (FSH) meningkat.

b. Fase Folikuler (Praovulasi)

Fase folikuler dimulai sejak hari pertama menstruasi sampai waktu terjadinya ovulasi. Fase ini hormon Folicle stimulating hormone (FSH) dihasilkan oleh kelenjar hipofisis untuk merangsang pertumbuhan folikel di ovarium, kemudian folikel tersebut berkembang menjadi folikel dominan yang mengandung sel telur yang telah matang (Sherword, 2019). Pada fase ini terjadi peningkatan kadar hormon esterogen, sehingga menyebabkan penebalan kembali lapisan endometrium untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya pembuahan.

c. Fase Ovulasi

Fase ovulasi merupakan suatu proses dimana terjadi pelepasan sel telur yang telah matang oleh ovarium menuju ke Tuba Falopii. Ovulasi terjadi dipicu oleh hormon Lutenizing Hormone (LH) yang meningkat tajam. Pada siklus

menstruasi 28 hari, umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14 (Prawirohardjo, 2020). Peluang terjadinya pembuahan pada fase ovulasi adalah yang paling tinggi dibandingkan fase yang lain. Beberapa kejadian, wanita mengalami nyeri ringan pada perut bagian bawah saat mengalami ovulasi.

d. Fase Lutheal

Pada fase Lutheal biasa juga disebut dengan fase Sekresi berlangsung pada saat dimulainya ovulasi hingga hari ketiga sebelum menstruasi pada siklus berikutnya. Endometrium memiliki darah yang berlimpah dan terjadi sekresi kelenjar sehingga pada fase ini biasanya wanita mengalami Pre Menstual Syndrome (PMS). Setelah terjadi PMS, beberapa hari kemudian dinding uterus akan meluruh kembali dan terjadi menstruasi di siklus berikutnya.

2. Hormon yang berperan dalam menstruasi

Pada siklus menstruasi terjadi interaksi kompleks antara hipotalamus, hipofisis dan ovarium. Beberapa hormon berperan penting dalam proses menstruasi, pematangan sel telur, ovulasi serta perubahan pada endometrium. Beberapa hormon tersebut meliputi:

a. Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH)

GnRH merupakan hormon neuropeptida (dekapeptida) yang disintesis dan dilepaskan oleh neuron khusus di hipotalamus dan bertindak sebagai regulator utama poros Hipotalamus – Pituitari – Gonad (HPG), bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan pubertas (Herbison 2024). GnRH juga berfungsi merangsang

Kelenjar hipofisis anterior untuk melepas hormon FSH dan LH secara pulsatif dalam menjaga keteraturan siklus menstruasi (Guyton & Hall, 2021).

b. Follicle Stimulating Hormone (FSH)

FSH diproduksi oleh hipofisis anterior dan berfungsi merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di ovarium, membantu meningkatkan produksi hormon estrogen oleh folikel ovarium (Sherwood, 2019). Kadar FSH akan meningkat pada awal siklus menstruasi (fase folikuler).

c. Luteinizing Hormone (LH)

Luteinizing hormone (LH) merupakan hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis anterior dibawah pengaruh GnRH. Hormon LH memiliki peran penting dalam proses ovulasi dan siklus menstruasi (Guyton & Hall, 2021). LH bersama dengan FSH bersama-sama merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium. Pada saat pertengahan siklus menstruasi, peningkatan estrogen menyebabkan lonjakan LH (*LH surge*)

memicu pecahnya folikel de graaf dan sel telur yang telah matang dari ovarium dan disebut dengan ovulasi (sherwood, 2019).

d. Esterogen

Esterogen adalah hormon yang diproduksi oleh folikel ovarium, yang berfungsi untuk menstimulasi penebalan endometrium selama fase folikuler untuk mempersiapkan implantasi apabila terjadi pembuahan (Prawirohardjo, 2020). Esterogen juga mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder pada perempuan.

e. Progesteron

Progesteron adalah hormon yang diproduksi oleh korpus luteum setelah terjadinya ovulasi. Hormon progesteron berfungsi untuk mempertahankan ketebalan dan kesiapan endometrium untuk menerima hasil konsepsi jika terjadi pembuahan, dan jika tidak terjadi pembuahan maka kadar progesteron menurun dan mengakibatkan peluruhan endometrium sehingga terjadi menstruasi (guyton & Hall, 2021). Hormon progesteron juga berperan dalam membantu mengurangi kontraksi otot uterus selama fase luteal.

f. Prostaglandin

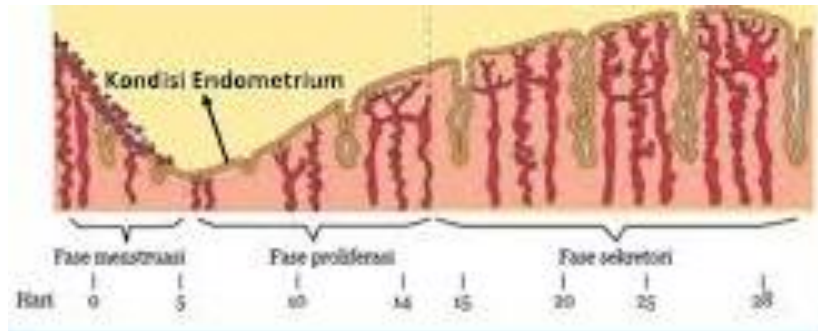
Prostaglandin merupakan senyawa lipid aktif dan termasuk dalam kelompok eikosanoid yang dibentuk dari asam araidonat melalui kerja enzim siklooksigenesis (COX). Prostaglandin diproduksi di beberapa jaringan tubuh, salah satunya endometrium. Endometrium merupakan mediator lokal terjadinya proses fisiologis maupun patologis, seperti inflamasi, kontraksi otot polos, pengaturan aliran darah dan respon nyeri (Guyton & Hall, 2021). Dalam praktik klinis, obat-obatan antiinflamasi non steroid (OAINS) seperti ibuprofen dan asam mefenamat sering digunakan untuk meredakan nyeri menstruasi. Obat tersebut bekerja menghambat enzim COX sehingga menurunkan produksi prostaglandin (sherwood, 2019).

3. Faktor yang mempengaruhi menstruasi

Menstruasi merupakan proses fisiologis yang dipengaruhi oleh kerja hormon, kondisi fisik, psikologis dan lingkungan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi keteraturan siklus menstruasi, lama menstruasi, jumlah perdarahan dan juga keluhan atau masalah yang dihadapi selama siklus menstruasi. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Faktor hormonal
- b. Usia
- c. Status gizi
- d. Stres psikologis
- e. Penyakit dan kondisi medis

- f. Penggunaan obat dan kontrasepsi
- g. Gaya hidup dan lingkungan



Gambar 3. 1 Fase menstruasi

C. GANGGUAN MENSTRUASI

1. Pengertian gangguan menstruasi

Gangguan menstruasi adalah kondisi yang abnormal dan terjadi pada siklus menstruasi, seperti perubahan frekuensi, lama, jumlah perdarahan, maupun keluhan yang menyertai menstruasi. Gangguan menstruasi disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, gangguan organ reproduksi, faktor psikologis, penyakit tertentu serta gaya hidup yang tidak sehat (Prawiroharjo, 2020).

Menstruasi umumnya terjadi dalam waktu 21-35 hari dengan lama perdarahan 3-7 hari dan jumlah darah sekitar 30-80 ml persiklus, sehingga apabila terjadi perubahan diluar batasan normal tersebut, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai gangguan menstruasi (Guyton & Hall, 2021).

2. Macam-macam gangguan menstruasi

a. Amenore

1) Pengertian

Amenore adalah suatu keadaan tidak terjadi menstruasi pada perempuan dalam periode tertentu. Amenore dapat terjadi secara normal pada masa kehamilan, menyusui dan menopause dan dapat menunjukkan adanya gangguan kesehatan diluar kondisi tersebut (Prawirohardjo, 2020). Secara klinis amenore dibedakan menjadi 2 yaitu amenore primer dan sekunder dan dapat dipengaruhi oleh gangguan hormonal, kelainan anatomi, penyakit sistemik, stres maupun gangguan nutrisi (Guyton & Hall, 2021).

2) Jenis amenore

a) Amenore primer

Amenore primer terjadi apabila seorang perempuan belum mengalami menstruasi hingga usia 15-16 tahun

b) Amenore sekunder

Amenore sekunder terjadi apabila enstruasi berhenti selama minimal tiga bulan pada perempuan yang pernah mengalami menstruasi sebelumnya.

3) Tanda gejala amenore sekunder adalah:

- a) Tidak mengalami mentruasi
- b) Perubahan berat badan
- c) Jerawat berlebih
- d) Rambut rontok
- e) Gangguan kesuburan

4) Penanganan

Tujuan penatalaksanaan amenore adalah mengembalikan fungsi menstruasi kembali normal, mencegah komplikasi, dan menjaga kesehatan reproduksi perempuan (Prawirohardjo, 2020).

a) Penanganan non farmakologis

- Perbaiki status gizi (protein, sayur dan buah, zat besi, serta kalsium dan vitamin D)
- Menjaga berat badan ideal
- Mengurangi aktifitas berlebihan
- Manajemen stres
- Edukasi dan support keluarga

b) Penanganan farmakologis

- Terapi hormonal (esterogen & progesteron, pil kombinasi, terapi pengganti hormon tertentu)
- Pengobatan penyakit penyebab amenore (gangguan tiroid, hiperprolaktinemia, PCOS)

c) Tindakan medis

Tindakan medis hanya dilakukan pada kasus tertentu, yaitu tindakan pembedahan pada kasus amenore yang disebabkan oleh kelainan anatomis, seperti: kelainan konginetal organ reproduksi, tumor hipofisis, sumbatan saluran reproduksi (Berek, 2020).

b. Dismenore

1) Pengertian

Dismenore adalah nyeri yang muncul saat menstruasi sedang berlangsung, oleh karena kontraksi uterus yang berlebihan yang diakibatkan oleh peningkatan prostaglandin. Peningkatan prostaglandin mengakibatkan kontraksi miometrium yang hebat sehingga aliran darah ke uterus berkurang dan timbul nyeri (Sherwood, 2019).

2) Jenis-jenis dismenore

- a) Dismenore primer, yaitu dismenore yang muncul bukan karena kelainan organik.
 - b) Dismenore sekunder, yaitu dismenore yang disebabkan oleh penyakit seperti endometriosis atau mioma uteri.
- 3) Tanda dan gejala
- a) Nyeri perut bagian bawah
 - b) Nyeri punggung
 - c) Mual dan muntah
 - d) Diare
 - e) Pusing
- 4) Penanganan
- a) Penanganan farmakologis
 - Obat OAINS (Ibuprofen, Asam mefenamat, Naproksen, dll)
 - Terapi hormonal (Pil kombinasi)
 - Analgesik (pada dismenore ringan bisa menggunakan parasetamol)
 - b) Penanganan non farmakologis
 - Kompres hangat
 - Olahraga teratur
 - Istirahat cukup
 - Teknik relaksasi
 - Pola makan sehat
 - Edukasi dan dukungan keluarga
 - c) Tindakan medis

Tindakan medis pembedahan dilakukan pada fokus kondisi pasien tertentu dimana pada dismenore sekunder yang diakibatkan oleh Endometriosis, mioma uteri, radang panggul/ pelvic inflammatory Diseases (PID), dan adenomiosis (Prawirohardjo, 2020).
- c. Oligimenorhea
- 1) Pengertian

Oligomenore adalah siklus menstruasi yang jarang atau biasa siklus menstruasi > 35 hari. Kondisi ini biasa sering terjadi pada remaja wanita dengan stres tinggi, obesitas dan penderita PCOS (Prawirohardjo, 2020).
 - 2) Penyebab Oligomenore
 - a) Gangguan hormon
 - b) Stres
 - c) Penurunan berat badan ekstrim
 - d) Gangguan tiroid
 - e) Aktivitas fisik yang berlebihan

3) Penanganan

Penanganan oligomenore bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan hormon dan mengembalikan siklus menstruasi normal dan mencegah komplikasi gangguan reproduksi.

a) Penanganan non farmakologis

- Perbaiki pola nutrisi (cukup protein, sayur dan buah, Fe dan vitamin, kurangi makanan tinggi gula dan lemak jenuh)
- Menjaga berat ideal
- Mengelola stres

b) Penanganan farmakologis

- Terapi hormonal (pil kombinasi, progesteron siklik, terapi estrogen dan progesteron)
- Pengobatan penyakit penyebab (PCOS, gangguan tiroid, diabetes melitus (DM))
- Obat pemicu ovulasi (sesuai indikasi medis)

d. Polimenorhea

1) Pengertian

Polimenore adalah menstruasi yang terjadi dengan tempo yang terlalu sering dan interval < 21 hari, disebabkan oleh gangguan hormonal yang mengakibatkan fase luteal lebih pendek (Guyton & Hall, 2021).

2) Tanda dan gejala

- a) Menstruasi lebih sering
- b) Tubuh terasa lemas
- c) Risiko anemia meningkat

3) Penanganan

a) Penanganan non farmakologis

- Menjaga pola makan sehat
- Menjaga berat badan ideal
- Mengelola stres
- Aktivitas fisik teratur
- Edukasi

b) Penanganan farmakologis

- Terapi hormonal
- Obat OAINS
- Suplementasi zat besi / Tablet Fe
- Pengobatan penyakit penyebab

e. Menoragia

1) Pengertian

Menoragia biasa disebut juga dengan hipermenore adalah kondisi perdarahan menstruasi yang berlebihan baik volume darah maupun lama waktu menstruasi. Pada menstruasi normal, umumnya berlangsung 3-7 hari dengan volume darah rata-rata 30-80 ml per siklus, namun pada menoragia berlangsung > 7 hari atau volume darah yang keluar sangat banyak hingga mengganggu aktifitas sehari-hari pada perempuan (Prawirohardjo, 2020).

2) Penyebab

- a) Ketidakseimbangan hormon
- b) Mioma uteri
- c) Endometriosis
- d) Gangguan ovulasi
- e) Gangguan pembekuan darah
- f) Gangguan kontrasepsi
- g) Penyakit sistemik

3) Tanda dan gejala menoragia

- a) Menstruasi lebih sering
- b) Siklus menstruasi pendek < 21 hari
- c) Perdarahan menstruasi berulang
- d) Nyeri menstruasi (dismenore)
- e) Mudah lelah
- f) Pusing dan lemah
- g) Gangguan aktifitas sehari-hari
- h) Perubahan emosional

4) Penanganan

- a) Penanganan farmakologis
 - Obat Antiinflamasi non steroid (OAINS)
 - Terapi hormonal
 - Suplemen Fe
 - Obat antifibrinolitik
- b) Penanganan non farmakologis
 - Istirahat cukup
 - Konsumsi makanan tinggi zat besi
 - Menjaga pola hidup sehat

c) Tindakan medis

Tindakan medis dilakukan pada kasus tertentu, dengan melihat penyebab dan tingkat keparahan, meliputi:

- Kuretase
- Ablasi endometrium
- Miomektomi
- Histerektomi

f. Hipomenore

1) Pengertian

Hipomenore adalah gangguan menstruasi yang ditandai dengan volume darah menstruasi yang sangat sedikit dan lama waktu menstruasi yang lebih singkat dari normal. Pada kondisi tersebut biasanya menstruasi berlangsung < 2 hari atau volume darah yang keluar jauh lebih sedikit dari siklus menstruasi normal (Prawirohardjo, 2020). Hipomenore dapat terjadi akibat penggunaan kontrasepsi hormonal, gangguan hormonal, stres maupun kondisi medis tertentu dan tetap memerlukan perhatian karena dapat menjadi tanda gangguan pada sistem reproduksi wanita (Berek, 2020).

2) Penyebab

- a) Ketidakseimbangan hormon
- b) Penggunaan kontrasepsi hormonal
- c) Stres psikologis
- d) Berat badan rendah dan malnutrisi
- e) Aktivitas fisik berlebihan
- f) Gangguan organ reproduksi
- g) Gangguan endokrin

3) Tanda gejala

- a) Volume Darah menstruasi sangat sedikit
- b) Lama menstruasi singkat
- c) Warna darah menstruasi lebih gelap
- d) Siklus menstruasi bisa normal atau bisa juga tidak teratur.
- e) Kadang disertai nyeri ringan pada perut bagian bawah.

4) Penanganan

- a) Penanganan non farmakologis
 - Memperbaiki pola makan
 - Menjaga berat badan ideal
 - Mengurangi stres
 - Mengatur aktivitas fisik
 - Edukasi

- b) Penanganan farmakologis
 - Terapi hormonal bila diperlukan
 - Pengobatan gangguan tiroid
 - Penanganan penyakit penyebab
- g. Premenstrual syndrome (PMS)
 - 1) Pengertian

Premenstrual syndrome (PMS) adalah sekumpulan gejala fisik, emosional, psikologis dan perilaku yang muncul beberapa hari sebelum menstruasi dan menghilang setelah menstruasi dimulai. PMS biasa muncul pada fase luteal oleh karena akibat dari perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron (Praworohardjo, 2020).
 - 2) Penyebab

Penyebab pasti PMS belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini berkaitan dengan perubahan hormonal selama siklus menstruasi, seperti:

 - a) Perubahan hormon reproduksi
 - b) Perubahan neurotransmitter
 - c) Faktor psikologis
 - d) Faktor gaya hidup
 - 3) Tanda gejala

Tanda dan gejala PMS muncul pada 7 – 14 hari sebelum menstruasi dan menghilang saat menstruasi dimulai. Menurut Berek (2020), tanda gejala PMS meliputi:

 - a) Tanda gejala fisik
 - Nyeri payudara
 - Perut kembung
 - Sakit kepala
 - Nyeri otot dan sendi
 - Mudah lelah
 - Nafsu makan meningkat
 - Muncul jerawat
 - Berat badan meningkat sementara karena retensi cairan
 - b) Tanda gejala emosional dan psikologis
 - Cemas
 - Mudah marah
 - Sedih
 - Gangguan tidur
 - Sensitif secara emosional
 - Konsentrasi menurun

- *Mood swing/ mood* berubah-ubah
- c) Tanda Gejala perilaku
 - Menarik diri dari lingkungan sosial
 - Penurunan produktifitas
 - Mudah tersinggung
- 4) Penanganan
 - a) Penanganan non farmakologis (Shewood, 2019)
 - Jalani pola hidup sehat
 - Olahraga
 - cukup istirahat
 - kurangi stres
 - hindari rokok dan alkohol
 - Pola makan sehat
 - kurangi garam dan kafein
 - konsumsi buah dan sayur
 - makanan kaya vitamin B6, kalsium dan magnesium
 - Teknik relaksasi
 - Yoga
 - Meditasi
 - Latihan pernafasan
 - b) Penanganan farmakologis
 - Obat OAINS
 - Terapi hormonal
 - Antidepresan (sesuai indikasi medis)
- 3. Faktor penyebab gangguan menstruasi

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya gangguan menstruasi, meliputi:

 - a. Ketidakseimbangan hormon
 - b. Status gizi yang buruk atau obesitas
 - c. Stres psikologis
 - d. Aktifitas fisik yang berlebihan
 - e. Gangguan tiroid
 - f. Penggunaan kontrasepsi hormonal
 - g. Penyakit reproduksi
 - h. Gaya hidup tidak sehat (merokok, kurang tidur, dll)

4. Dampak Gangguan Menstruasi

Gangguan menstruasi dapat menimbulkan berbagai dampak, yaitu:

- a. Penurunan kualitas hidup
- b. Gangguan aktifitas sehari-hari
- c. Anemia
- d. Gangguan psikologis
- e. Gangguan kesuburan
- f. Risiko penyakit reproduksi
- g. Gangguan nutrisi dan pertumbuhan pada remaja

5. Pencegahan gangguan menstruasi

Upaya pencegahan gangguan menstruasi dapat dicegah dengan berbagai cara, menurut Prawirohardjo (2020), antara lain:

- a. penerapan pola hidup sehat
- b. menjaga keseimbangan hormonal
- c. meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan reproduksi
- d. mengelola stres

D. Infeksi Saluran Reproduksi

1. Pengertian

Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) adalah infeksi pada organ reproduksi perempuan maupun laki-laki akibat masuk dan berkembangnya mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur atau parasit. Pada perempuan menyerang vulva, vagina, serviks, uterus, tuba falopii hingga ovarium. ISR merupakan salah satu masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi dan dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak ditangani dengan baik (Prawirohardjo, 2020). ISR menjadi salah satu masalah kesehatan reproduksi yang penting karena dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang seperti infertilitas dan kehamilan ektopik apabila tidak ditangani secara tepat (Kemenkes RI, 2022).

ISR menjadi masalah serius yang menyerang saluran reproduksi bagian bawah maupun bagian atas pada wanita usia reproduktif dan dapat menimbulkan komplikasi serius seperti infertilitas, kehamilan ektopik dan penyakit radang panggul (Manuaba, 2018). Menurut World Health Organisation (WHO), ISR mencakup infeksi menular seksual (IMS), infeksi endogen akibat ketidakseimbangan flora normal vagina serta infeksi iatrogenik yang terjadi akibat prosedur medis yang tidak steril. Menurut Berek (2020), ISR disebabkan oleh IMS maupun non seksual akibat kebersihan organ reproduksi yang kurang, perubahan hormonal dan penggunaan alat tertentu pada organ reproduksi.

2. Penyebab Infeksi Saluran Reproduksi

Menurut Guyton & Hall (2021), Infeksi saluran reproduksi disebabkan oleh beragam mikroorganisme, antara lain:

a. Bakteri

Contoh bakteri penyebab ISR meliputi:

- 1) *Neisseria Gonorrhoeae* (gonore)
- 2) *Chlamydia trachomatis*
- 3) *Treponema pallidum* (sifilis)

b. Virus

Contoh virus penyebab ISR , meliputi:

- 1) *Human Papilloma virus* (HPV)
- 2) *Herpes Simplex Virus* (HSV)
- 3) *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)

c. Jamur

Contoh jamur penyebab ISR adalah *candida albicans* (candidiasis vagina)

d. Parasit

Contoh parasit penyebab ISR, yaitu *Trichomonas vaginalis*

3. Jenis-jenis Infeksi Saluran Reproduksi

a. Vaginitis

1) Pengertian

Vaginitis merupakan peradangan vagina dan paling sering dialami oleh wanita yang disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, parasit maupun ketidakseimbangan flora normal vagina (Manuaba, 2018).

2) Penyebab

Vaginitis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Bakteri

- *Gardnerella vaginalis* (vaginosis bakterialis)
- *Candida albicans* (kandidiasis vagina)

b) Vaginitis non Infeksi, yang disebabkan oleh:

- Iritasi bahan kimia
- Sabun atau pewangi
- Reaksi alergi
- Penurunan hormon estrogen

3) Tanda dan gejala

a) Keputihan abnormal

- Berwarna putih (seperti susu), kuning atau kehijauan
- Konsistensi kental dan berbusa
- Jumlah semakin meningkat

- b) Gatal pada vagina
- c) Bau tidak sedap
- d) Nyeri saat berkemih
- e) Tampak Kemerahan dan bengkak
- 4) Penanganan
 - a) Penanganan non farmakologi
 - Menjaga kebersihan organ reproduksi
 - Menghindari bahan iritan (pembersih vagina, parfum, dll)
 - Edukasi
 - b) Penanganan farmakologi
 - Antibiotik
 - Anti jamur
 - Anti parasit

b. Servitis

1) Pengertian

Servitis adalah peradangan pada area serviks atau leher rahim yang sering disebabkan karena faktor infeksi maupun faktor non infeksi pada wanita usia reproduktif serta bersifat akut maupun kronis (Manuaba, 2018).

2) Penyebab

a) Infeksi bakteri

- *Nesseria gonorrhoeae*
- *Chlamydia trachomatis*

b) Infeksi virus

- *Herpes simplex virus* (HSV)
- *Human papilloma virus* (HPV)

c) Infeksi parasit

Servitis juga disebabkan oleh infeksi parasit *trichomonas vaginalis*

d) Faktor non infeksi

- Iritasi bahan kimia
- Alergi lateks atau spermisida
- Trauma akibat pemasangan alat kontrasepsi
- Penggunaan cairan pembersih vagina yang berlebihan

3) Tanda dan gejala

- a) Nyeri panggul
- b) Keputihan abnormal (kuning, hijau atau bercampur nanah)
- c) Perdarahan setelah hubungan seksual atau perdarahan diluar siklus menstruasi.
- d) Nyeri saat berhubungan seksual (dyspareunia)

- e) Nyeri saat berkemih (disuria)
- 4) Penanganan
 - a) Penanganan non farmakologis
 - Menjaga kebersihan organ reproduksi
 - Menghindari penggunaan bahan iritan
 - Edukasi

Edukasi yang diberikan pada pasien servitisitis adalah tentang hubungan seksual aman dan pemeriksaan rutin (saifuddin, 2020).
 - b) Penanganan farmakologis

Penanganan farmakologis diberikan sesuai kondisi pasien dan penyebab, seperti:

 - Antibiotik
 - Antivirus
 - Pengobatan pasangan seksual
- c. Penyakit radang panggul/ *Pelvic Inflammatory Disease* (PID)
 - 1) Pengertian

Pelvic Inflammatory Disease (PID) adalah infeksi yang terjadi pada organ reproduksi perempuan bagian atas yang meliputi uterus, tuba falopii, ovarium dan jaringan sekitarnya, dan umumnya penyebaran infeksi dari vagina atau serviks ke organ reproduksi bagian atas (Manuaba, 2018). Jika tidak ditangani dengan tepat, PID dapat menjadi masalah serius seperti infertilitas, nyeri panggul, dan kehamilan ektopik (varney, 2020). Menurut American College of Obstetricians and Gynecologists (2023), penyakit radang panggul sering berkaitan dengan infeksi menular seksual terutama infeksi gonore dan klamidia.
 - 2) Penyebab
 - a) Infeksi Bakteri
 - *Neisseria gonorrhoeae*
 - *Chlamydia trachomatis*
 - b) Infeksi campuran

Selain disebabkan oleh bakteri penyebab IMS, PID juga dapat disebabkan oleh bakteri anaerob dan flora normal vagina yang berkembang secara berlebihan.
 - c) Tindakan Invasif pada organ reproduksi

Menurut Bobak (2021), risiko PID meningkat setelah dilakukan beberapa tindakan invasif, antara lain:

 - Kuretase
 - Persalinan atau abortus yang tidak steril

- Pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD)
- 3) Tanda dan gejala
 - a) Nyeri perut bagian bawah
 - b) Keputihan abnormal
 - c) Demam
 - d) Nyeri saat berhubungan seksual
 - e) Gangguan menstruasi
 - f) Nyeri saat berkemih
 - 4) Penanganan
 - a) Penanganan non farmakologis
 - Istirahat dan perawatan supportif
 - Hindari berhubungan seksual sementara
 - Konsumsi cairan cukup
 - b) Penanganan farmakologis
 - Antibiotik
 - Pengobatan pasangan seksual sesuai penyebab
 - c) Tindakan medis

Tindakan operatif dilakukan pada komplikasi berat jika terdapat abses (Reeder, 2021).
- d. Kandidiasis vagina
- 1) Pengertian

Kandidiasis vagina atau candidiasis vulvovaginal adalah infeksi pada vagina dan vulva yang disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan jamur candida albicans (Manuaba, 2018).
 - 2) Penyebab

Penyebab utamanya adalah jamur candida albicans.
 - 3) Tanda dan gejala
 - a) Keputihan abnormal berwarna putih kental
 - b) Gatal pada vagina dan vulva
 - c) Rasa terbakar
 - d) Kemerahan dan edema vulva
 - e) Nyeri saat berhubungan seksual
 - 4) Penanganan
 - a) Penanganan non farmakologis
 - menjaga kebersihan organ genital
 - Menghindari sabun mengandung parfum untuk genetalia
 - Mengontrol kadar gula pada penderita diabetes
 - Menghindari penggunaan antibiotik tanpa indikasi

- Edukasi tentang kebersihan genetalia dan mengenali tanda infeksi sejak dini
- b) Penanganan farmakologis
Berikan Terapi anti jamur, seperti:
 - Klotrimazol
 - Mikonazole
 - Nistatin
 - Flukonazole
- e. Trikomoniasis
 - 1) Pengertian
Trikomoniasis adalah infeksi saluran reproduksi yang disebabkan oleh parasit protozoa *tricomoniasis vaginalis* yang dapat terjadi baik pada perempuan maupun laki-laki (Manuaba, 2018). Menurut WHO (2023), *Trikomoniasis* merupakan infeksi menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seksual.
 - 2) Penyebab
Trikomoniasis disebabkan oleh parasit berflagela yang hidup pada saluran genitourinaria manusia, yaitu *Tricomonas vaginalis*.
 - 3) Tanda dan gejala
Beberapa kejadian trikomoniasis tanpa disertai gejala, namun umumnya tanda gejala yang muncul, meliputi:
 - a) Keputihan abnormal, seperti:
 - kuning kehijauan
 - berbusa
 - berbau tidak sedap
 - b) Gatal pada vagina
 - c) Nyeri atau rasa terbakar saat berkemih atau berhubungan seksual
 - d) Tampak kemerahan pada vulva dan vagina
 - e) Serviks strawberry (bercak merah seperti strawberry akibat perdarahan serviks)
 - 4) Penanganan
 - a) Penanganan non farmakologis
 - Menjaga kebersihan organ reproduksi
 - Edukasi tentang hubungan seksual aman dan penggunaan kondom
 - Pengobatan pasangan seksual
 - b) Penanganan farmakologis
 - Terapi antiparasit (metronidazole, tinidazole)

E. Simpulan

Gangguan menstruasi merupakan kondisi abnormal; yang terjadi pada siklus menstruasi yang antara lain meliputi perubahan frekuensi, jumlah perdarahan, maupun keluhan nyeri. Gangguan menstruasi disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor hormonal, penyakit reproduksi, stres, dan gaya hidup. Deteksi dini dan penanganan yang tepat, dapat mencegah terjadinya komplikasi dan menjaga kesehatan reproduksi perempuan.

Infeksi saluran reproduksi merupakan infeksi yang terjadi pada organ reproduksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur dan parasit. Jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, ISR dapat berkembang menjadi komplikasi yang serius seperti infertilitas dan penyakit radang panggul. Pencegahan, deteksi dini dan pengobatan merupakan upaya untuk menjaga kesehatan reproduksi wanita.

Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists. 2023. *Pelvic Inflammatory Disease Guidelines*. Washington DC: ACOG
- Berek, J. S. 2020. *Berek & Novak's Gynecology*. 16th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., & Jensen, M. D. 2021. *Maternity Nursing*. 11th Edition. St. Louis: Mosby Elsevier
- Hall, J. E. (2016). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (13th ed.). Philadelphia, PA: Elsevier, Inc.
- Herien, Y. (2024). *Menstruasi dan Permasalahannya*. Eureka Media Aksara.
- Herbison, A. E. (2024). *Physiology of GnRH and Gonadotrophin Secretion*. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc. Diakses melalui NCBI
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Infeksi Saluran Reproduksi*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Manuaba, I. B. G. 2018. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB*. Jakarta: EGC.
- Prawirohardjo, S. 2020. *Ilmu Kandungan*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Reeder, S. J., Martin, L. L., & Griffin, D. K. 2021. *Maternity Nursing: Family, Newborn, and Women's Health Care*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Sherwood, L. 2019. *Human Physiology: From Cells to System*. Boston: Cengage Learning. Diakses melalui NCBI
- Saifuddin, A. B. 2020. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Varney, H. 2020. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Jakarta: EGC.
- World Health Organization. 2023. *Sexually Transmitted Infections Guidelines*. Geneva: WHO

Glosarium

COX	= <i>Cycloooksigenesis</i>
DM	= <i>Diabetes Melitus</i>
Fe	= Ferous (zat besi)
FSH	= <i>Follicle Stimulating Hormone</i>
GnRH	= <i>Gonadotropin Releasing Hormone</i>
HIV	= <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HPG	= <i>Hipofisis – pituitary –gonadotropin</i>
HPV	= <i>Human Papilloma virus</i>
HSV	= <i>Herpes Simplex Virus</i>
IMS	= Infeksi Menular seksual
ISR	= Infeksi Saluran Reproduksi
IUD	= <i>Intra Uterin Device</i>
LH	= Luteinezing hormone
OAINS	= Obat Antiinflamasi Non Streoid
PCOS	= <i>Policystic Ovarium syndrome</i>
PMS	= <i>Premenstrual Syndrome</i>
PID	= <i>Pelvic Inflammatory Diseas</i>
WHO	= <i>World Health Organisation</i>
WUS	= Wanita Usia Subur



CHAPTER 4



PERILAKU HIDUP SEHAT UNTUK MENJAGA KESEHATAN REPRODUKSI

Bdn. Ida Susila, SST, M. Kes.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Perilaku hidup sehat menjadi determinan utama dalam mencegah gangguan reproduksi seperti IMS, infertilitas, kanker serviks, hingga komplikasi kehamilan. Bidan berperan penting sebagai edukator dan konselor untuk membentuk perilaku sehat pada remaja, WUS, ibu hamil, hingga menopause.(RI. 2023)(Prawirohardjo 2022). Kesehatan reproduksi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, perilaku, dan sosial. Pendekatan holistik melalui personal hygiene, perilaku seksual sehat, nutrisi adekuat, gaya hidup aktif, serta skrining berkala merupakan strategi utama dalam meningkatkan derajat kesehatan reproduksi secara berkelanjutan.

Kebersihan pribadi yang kurang memengaruhi risiko infeksi genital dan gangguan reproduksi pada remaja, dewasa, sehingga intervensi edukasi praktis penting untuk pencegahan. program pendidikan yang diarahkan ke kelompok perempuan dan remaja meningkatkan pengetahuan serta kemampuan pencegahan sehingga dapat mengurangi konsekuensi kesehatan reproduksi.

Temuan dilapangan membuktikan bahwa pendidikan dan intervensi sebaya pada santri putri meningkatkan pengetahuan tentang masalah kebersihan dan kemampuan mengenali tanda-tanda gangguan reproduksi yang umum seperti keputihan dan dismenore serta potensi dampaknya terhadap ketidakhadiran di sekolah dan risiko infertilitas, integrasi keluarga berencana(Susila 2021) dengan program nutrisi dan layanan kesehatan reproduksi lainnya mendukung pendekatan holistik yang memudahkan akses pada tindakan pencegahan dan manajemen seksual reproduktif, pendekatan holistik untuk investigasi fertilitas di layanan primer mendukung pemberian perawatan yang dipersonalisasi dan pengelolaan yang lebih efektif dalam setting klinis umum, penggabungan layanan reproduksi, nutrisi, dan pencegahan dalam satu paket memudahkan rujukan dan tindak lanjut serta mengatasi hambatan akses layanan.(Isfentiani and Komariyah 2025).

B. Personal Hygiene Organ Reproduksi.

1. Definisi

Kebersihan pribadi organ reproduksi merupakan langkah dasar untuk mencegah infeksi dan menjaga kesehatan secara keseluruhan, baik bagi pria maupun wanita.(Handayani, S., & Triani 2025), Kebersihan pribadi organ reproduksi adalah fondasi utama pencegahan infeksi dan menjaga keseimbangan mikrobiota alami, yang krusial bagi semua kelompok usia. Bagi wanita, membersihkan dari depan ke belakang mencegah bakteri dari anus masuk ke vagina, mengurangi risiko infeksi saluran kemih (ISK).(Al-Moghazi, D. M. A., Midan, M. F., & Megahed 2025) Pria juga perlu membersihkan skrotum dan penis dengan lembut untuk hindari iritasi kulit. (Niewozinska, Z. A., Sakaniya, L. R., & Korsunskaya 2024). Personal hygiene organ reproduksi merupakan komponen fundamental dalam pencegahan infeksi serta pemeliharaan keseimbangan mikrobiota genital.(Kaur, P., Patil, R. K., Bansal, R., & Patil 2021a) Secara fisiologis, organ reproduksi khususnya pada perempuan memiliki mekanisme pertahanan alami berupa flora normal seperti *Lactobacillus* yang berperan menjaga pH vagina tetap asam (pH 3,8–4,5).(Adesulu-Dahunsi 2022) Ketidakseimbangan akibat praktik hygiene yang tidak tepat dapat memicu kolonisasi mikroorganisme patogen (Anju, V. T., Busi, S., Mohan, M. S., & Dyavaiah 2023). Personal Hygiene Organ Reproduksi Personal hygiene organ reproduksi adalah upaya menjaga kebersihan organ genital untuk mencegah infeksi dan meningkatkan kenyamanan.(Indra, I., Sartika, S., Maryadi, M., & Purwanto 2025) Definisi yang lain personal hygiene merupakan perilaku menjaga kebersihan alat kelamin luar untuk mencegah infeksi.(Kaur, P., Patil, R. K., Bansal, R., & Patil 2021b). Organ reproduksi perempuan memiliki karakteristik lingkungan yang lembap, hangat, dan tertutup. Kondisi ini sangat mudah menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme seperti bakteri dan jamur apabila kebersihannya tidak dijaga. Oleh karena itu, personal hygiene bukan sekadar kebiasaan membersihkan diri, melainkan bagian penting dari upaya pencegahan penyakit reproduksi

2. Prinsip Personal Hygiene

Prinsip utama personal hygiene genital tidak hanya berfokus pada kebersihan, tetapi juga mempertahankan ekosistem mikrobiologis normal. Cara sederhana membersihkan genital setelah BAK/BAB dengan air bersih penting untuk mencegah kontaminasi bakteri enterik seperti *Escherichia coli* ke uretra dan vagina, arah pembersihan dari organ genitalia *anterior* (arah depan) ke *posterior* (arah belakang) merupakan standar klinis untuk mencegah infeksi saluran kemih (ISK).(Al-Moghazi, D. M. A., Midan, M. F., & Megahed 2025) lalu keringkan dengan

handuk bersih dan kering, pakai sabun lembut tanpa pewangi, ganti pakaian dalam minimal 2x/hari dan menggunakan bahan katun yang menyerap keringat direkomendasikan untuk menjaga sirkulasi udara.(Gandhi, A. B., Madnani, N., Thobbi, V., Vora, P., Seth, S., & Shah 2022). WHO (2022) menegaskan bahwa pembersih intravaginal (*douching*) tidak direkomendasikan karena dapat mengganggu keseimbangan bakteri alami vagina, yang justru meningkatkan risiko infeksi jamur atau bakteri, menyebabkan risiko *pelvic inflammatory disease* (PID), (WHO. 2021) penggunaan sabun antiseptik berlebihan tidak disarankan karena mengganggu flora normal vagina, menghindari celana dalam ketat dapat membantu mencegah iritasi kulit sensitif, lingkungan lembab terbukti meningkatkan risiko kandidiasis vulvovaginal, personal hygiene untuk menghindari infeksi saluran kemih, sementara masyarakat umum diuntungkan dengan mengurangi risiko penyakit menular seksual melalui kebersihan rutin.(Al-Moghazi, D. M. A., Midan, M. F., & Megahed 2025).(Susila et al. 2025)

3. Personal Hygiene pada Masa Menstruasi

Menstruasi merupakan periode rentan karena adanya darah sebagai media pertumbuhan mikroorganisme. Edukasi menstruasi yang adekuat terbukti meningkatkan praktik hygiene remaja putri secara signifikan.(Faturahman, Y., & Aisyah 2025). Untuk anak remaja, ajarkan hygiene sejak dini melalui sekolah atau orang tua untuk membentuk kebiasaan baik, ibu hamil perhatikan hygiene ekstra karena risiko infeksi naik.(Abduraxmonovna 2025) Hasil studi menunjukkan bahwa praktik hygiene menstruasi yang buruk berhubungan signifikan dengan peningkatan infeksi reproduksi, maka kebersihan tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut merupakan bagian dari pencegahan transmisi patogen, mengganti pembalut setiap 4–6 jam bertujuan mencegah proliferasi bakteri dan bau tidak sedap, membersihkan area genitalia dari arah depan ke belakang, membersihkan genital setelah BAK/BAB dengan air bersih, mengganti pakaian dalam secara rutin, menjaga area tetap kering dan tidak lembab, menghindari penggunaan bahan kimia berlebihan, gunakan air hangat dan sabun netral tanpa parfum, karena bahan kimia dapat mengganggu pH alami vagina (3.8-4.5), pakaian dalam katun yang longgar memungkinkan sirkulasi udara, ganti pakaian dalam setiap hari, terutama setelah berolahraga pada saat menstruasi, hindari celana ketat yang menekan aliran darah dan tingkatkan gesekan, untuk cegah *toxic shock syndrome* dari tampon.(GiteAnamika 2025) Praktisi kesehatan dapat melakukan edukasi personal hygiene dalam konseling pra-nikah, masyarakat umum di Indonesia, dengan iklim tropis lembab, rentan infeksi, sehingga hygiene ini sangat vital, penelitian terkini tunjukkan hygiene baik kurangi PMS 20-30%. Integrasikan dengan vaksin *Human Papillomavirus* (HPV) untuk perlindungan

komprehensif, sangat penting untuk diinformasikan kepada masyarakat luas bahwa hygiene bukan beban, tapi investasi kesehatan masa depan, dengan disiplin, semua bisa capai kesehatan optimal.(Eka, R. A., Wahyuni, R. T. E., & Munawaroh 2025)

4. Dampak Personal Hygiene Buruk

Dampak Buruk yang dapat ditimbulkan apabila kurang peduli dalam personal hygiene antara lain keputihan patologis akibat disbiosis vagina, penelitian dalam The Lancet Global Health (2021) menegaskan bahwa hygiene genital yang buruk berkontribusi pada tingginya beban penyakit infeksi reproduksi di negara berkembang, infeksi saluran kemih (ISK) akibat kontaminasi bakteri, infeksi menular seksual (IMS) akibat kerusakan barrier alami, *pelvic inflammatory disease* (PID), hingga infertilitas. Kurangnya personal hygiene dapat meningkatkan risiko infeksi saluran reproduksi, termasuk infeksi jamur dan bakteri, personal hygiene genital merupakan faktor penting dalam pencegahan gangguan kesehatan reproduksi.(İşbay Aydemir, B., Kuru Aktürk, N. B., Düzkar Gözlü, S., & Dişsiz n.d.)

C. Perilaku Seksual Aman dan Bertanggung Jawab

1. Definisi

Perilaku seksual sehat adalah aktivitas seksual yang dilakukan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan memperhatikan aspek kesehatan serta norma sosial. Perilaku seksual yang tidak berisiko menularkan IMS/HIV dan dilakukan atas dasar kesadaran serta kesepakatan. Perilaku seksual sehat tidak hanya dilihat dari aspek biologis, tetapi juga psikologis, sosial, dan moral. Pendekatan ini dikenal sebagai *comprehensive sexuality education* (CSE).

Perilaku seksual aman dimulai dengan pemahaman ABC: Abstinence (pantang), Be faithful (setia), Condom use (pakai kondom). Kondom lateks cegah HIV, gonore, dan kehamilan tidak diinginkan hingga 98% jika benar, komunikasi terbuka soal status kesehatan dan tes PMS rutin bangun tanggung jawab bersama, tanggung jawab berarti hormati konsensus (consent) yang sadar dan bebas paksaan.

Perilaku seksual aman melibatkan penggunaan kondom secara konsisten, vaksinasi HPV, dan membatasi pasangan seksual untuk mengurangi risiko PMS seperti HIV dan sifilis. Tanggung jawab berarti komunikasi terbuka dengan pasangan tentang riwayat kesehatan dan persetujuan sadar sebelum aktivitas intim.(Khatimah, H., Astuti, I., Puspita, E., & Fitria 2025)

Perilaku seksual aman dan bertanggung jawab adalah sikap dan tindakan dalam aktivitas seksual yang dilakukan secara sadar, berdasarkan persetujuan kedua pihak (consent), mempertimbangkan aspek kesehatan fisik, psikologis, sosial, serta menjauhkan diri dari risiko penularan infeksi menular seksual (IMS) dan kehamilan yang tidak direncanakan. Konsep ini tidak hanya berbicara tentang “aman dari penyakit”, tetapi juga tentang kematangan mengambil keputusan, menghargai diri sendiri dan pasangan, serta memahami konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang dari aktivitas seksual.

Pada konteks kesehatan reproduksi, perilaku seksual yang bertanggung jawab menjadi pilar penting pencegahan IMS seperti HIV, sifilis, gonore, klamidia, trikomoniasis, hingga infeksi Human Papillomavirus (HPV) yang berhubungan erat dengan kanker serviks.

2. Prinsip Perilaku Seksual Aman

Prinsip perilaku seksual aman meliputi persetujuan (consent) karena aktivitas seksual harus didasari persetujuan yang jelas tanpa paksaan, tekanan, atau manipulasi. Consent adalah bentuk penghargaan terhadap tubuh dan hak individu. menghindari seks pranikah, setia pada satu pasangan (monogami) dan kesetiaan pasangan menurunkan risiko paparan patogen. Selain itu, skrining IMS secara berkala direkomendasikan terutama pada populasi berisiko, penggunaan kontrasepsi, khususnya kondom, merupakan metode efektif dalam mencegah IMS dan HIV. WHO(2023) melaporkan bahwa penggunaan kondom secara konsisten dapat menurunkan risiko penularan HIV hingga 85%. WHO menekankan pentingnya edukasi seksual komprehensif untuk mencegah risiko penyakit dan kehamilan tidak diinginkan, risiko perilaku seksual tidak aman infeksi menular seksual (HIV, sifilis, gonore), kehamilan tidak direncanakan dapat berdampak pada psikososial, edukasi seksual terbukti meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih sehat pada remaja. menunda usia pertama hubungan seksual, karena Usia <20 tahun dapat meningkatkan risiko kanker serviks 2,3x, Skrining IMS dan vaksin HPV bagi remaja putri usia 9–14 tahun.(Lestari P 2022)(Yuliani F 2023). Peran bidan yang dapat dilakukan antara lain : konseling pranikah, konseling IMS, dan deteksi dini pada kunjungan ANC/KB. Pemeriksaan berkala penting bagi individu yang memiliki faktor risiko, sehingga infeksi dapat terdeteksi dan diobati lebih dini.

3. Risiko Perilaku Seksual Tidak Aman

Perilaku seksual berisiko berkaitan erat dengan penyakit serta kehamilan tidak diinginkan. Beberapa IMS yang umum seperti HIV/AIDS menyerang sistem kekebalan tubuh, sifilis yang ditandai luka pada genital, gonore dan Klamidia dapat menyebabkan nyeri BAK dan keputihan abnormal, HPV berisiko

menyebabkan kanker serviks, herpes genital ditandai dengan lepuhan nyeri di area genital, banyak IMS tidak menunjukkan gejala pada awalnya, sehingga perilaku pencegahan sangat penting. Selain dampak fisik, terdapat konsekuensi psikososial seperti depresi dan stigma sosial. Hasil penelitian menegaskan bahwa intervensi edukasi seksual komprehensif mampu menurunkan perilaku berisiko secara signifikan pada remaja. (Ningsih, Susila, and Safitri 2021) yang rentan terhadap hubungan pranikah, bagi seorang bidan dapat melakukan konseling pasien, dan masyarakat untuk membangun hubungan sehat, buat kesepakatan verbal (konsensus) tentang batasan hubungan seksual, pendidikan komprehensif tentang kontrasepsi dan pencegahan kehamilan tidak diinginkan mendukung kesejahteraan reproduksi jangka panjang, menghindari seks di bawah pengaruh alkohol/NAPZA yang dapat meningkatkan risiko, rentan peer pressure, edukasi komprehensif dapat diberikan agar masalah dapat dikurangi, bidan dapat menggunakan model ini untuk konseling remaja. Bagi pasangan mendiskusikan kontrasepsi seperti pil, IUD, atau implan, Vaksin HPV melindungi dari kutil kelamin dan kanker serviks, sedangkan masyarakat umum diberikan pemahaman bahwa seks aman bukan tabu, tapi hak kesehatan. Di Indonesia, program KPAI promosikan ini. Kelola emosi seks yang bertanggung jawab dan menghindari hubungan sesaat yang sebabkan trauma. Tes PMS gratis di puskesmas dukung deteksi dini, sehingga hubungan harmonis dan keluarga bahagia. Studi 2021-2026 menunjukkan edukasi seksual kurangi PMS 40% di kalangan muda dapat diterapkan untuk generasi sehat.(Guna, S. D., & Rustam 2025)(Susila et al. 2023).

Perilaku seksual aman dan bertanggung jawab adalah bentuk perlindungan diri yang sangat penting dalam menjaga kesehatan reproduksi. Dengan memahami risiko, menerapkan prinsip pencegahan, serta didukung edukasi yang tepat, individu dapat terhindar dari berbagai penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, serta dampak psikososial yang merugikan. Sikap ini mencerminkan penghargaan terhadap diri sendiri, pasangan, dan masa depan.

D. Nutrisi Seimbang untuk Kesehatan Reproduksi

1. Definisi

Asupan gizi yang mendukung fungsi hormonal dan perkembangan organ reproduksi. Nutrisi Seimbang untuk kesehatan reproduksi Nutrisi memegang peranan penting dalam fungsi hormonal dan kesehatan organ reproduksi, nutrisi berperan langsung dalam regulasi hormonal melalui sumbu hipotalamus–hipofisis–gonad. Nutrisi seimbang kaya antioksidan, folat, zat besi, dan omega-3 mendukung fertilitas, mengurangi infertilitas, dan meningkatkan kualitas ovulasi

serta sperma. Nutrisi seimbang kaya folat (bayam, kacang), zat besi (daging merah, tahu), dan vitamin D (ikan salmon) dukung ovulasi reguler dan kualitas sperma. Diet seimbang cegah PCOS dan endometriosis dengan indeks glikemik rendah. Wanita hamil butuh 600 mcg folat harian cegah cacat tabung saraf.

Nutrisi seimbang kaya antioksidan, folat, zat besi, dan omega-3 mendukung fertilitas, mengurangi infertilitas, dan meningkatkan kualitas ovulasi serta sperma. Diet Mediterania dengan buah, sayur, ikan, dan biji-bijian direkomendasikan, Hindari defisiensi zinc yang dapat menurunkan testosteron pria. Sertakan omega-3 dari chia seed untuk kurangi inflamasi ovarium.

Nutrisi seimbang adalah pola makan yang mengandung zat gizi lengkap dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk mempertahankan fungsi organ, termasuk organ reproduksi. Asupan gizi yang baik berperan penting dalam pembentukan hormon, pematangan sel telur, keteraturan siklus menstruasi, serta persiapan kehamilan yang sehat. Kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu dapat mengganggu keseimbangan hormon reproduksi dan menurunkan kualitas kesehatan reproduksi secara keseluruhan.

Tubuh manusia, khususnya pada perempuan usia remaja hingga usia subur, sangat bergantung pada ketersediaan zat gizi untuk mendukung proses biologis seperti ovulasi, menstruasi, dan kesuburan

2. Zat Gizi Penting

Tujuan pemenuhan gizi untuk menjaga keseimbangan hormon reproduksi, membantu keteraturan siklus menstruasi, mencegah anemia akibat kehilangan darah saat haid, menunjang kesuburan dan kesehatan sel telur, mempersiapkan kehamilan yang sehat, menjaga daya tahan tubuh terhadap infeksi, IMT <18,5 atau >25 berkorelasi dengan gangguan ovulasi. Batasi kafein <200 mg/hari dan hindari alkohol/rokok karena menurunkan fertilitas. (Skoracka K 2021) (Silvestris E 2023) Contoh Kasus : Anemia (Siti Fatimah, SST., M.M., M.Keb. Ida Susila, S.ST. et al. 2023) pada remaja putri meningkatkan risiko perdarahan postpartum 3x lipat.

Diet Mediterania dengan buah, sayur, ikan, dan biji-bijian direkomendasikan untuk wanita hamil dan pria, ini melalui menu harian, praktisi gunakan untuk saran pasien, dan umum hindari defisiensi yang memengaruhi hormon reproduksi, Konsumsi gizi seimbang selama siklus hidup, seperti selama kehamilan dan laktasi, mencegah anemia dan mendukung pertumbuhan janin. Hindari makanan olahan tinggi gula yang mengganggu ovarium, Protein sebagai pembentukan hormon Zat besi untuk mencegah anemia Asam folat berperan dalam sintesis DNA dan sangat krusial pada periode perikonsepsi untuk mencegah neural tube defects (NTDs), yang penting untuk kehamilan, Vitamin A, C, E sebagai antioksidan, sedangkan Zinc dapat mendukung fungsi reproduksi,

ovarium dan kualitas oosit. Studi dalam *Human Reproduction Update* (2022) menunjukkan bahwa stres oksidatif berperan dalam infertilitas.

Zat gizi makro didapat dari karbohidrat yaitu sumber energi utama tubuh, kekurangan energi dapat mengganggu kerja hormon hipotalamus yang mengatur siklus haid, Sumber: nasi, jagung, kentang, roti gandum. Protein yang berperan dalam pembentukan hormon reproduksi dan perbaikan sel tubuh, sumber: telur, ikan, ayam, tempe, tahu, kacang-kacangan, lemak Sehat diperlukan untuk produksi hormon estrogen dan progesteron, sumber: alpukat, kacang, ikan berlemak. Sedangkan zat gizi mikro yang sangat penting adalah zat besi (Fe) menggantikan darah yang hilang pada wanita usia subur saat menstruasi dan zat besi sangat penting untuk mencegah anemia, anemia diketahui berhubungan dengan gangguan ovulasi (WHO, 2021). zat besi, asam folat, kalsium, vit D, dan zink esensial untuk siklus haid teratur dan persiapan kehamilan. Hindari junk food dan diet ekstrem, sumber: bayam, hati ayam, daging merah, kacang-kacangan, asam folat penting dalam pembentukan sel baru dan persiapan kehamilan, sumber: sayur hijau, jeruk, alpukat, kalsium dan vitamin D dapat menjaga kesehatan tulang dan mendukung kerja hormon, sumber: susu, ikan, sinar matahari pagi, zinc berperan dalam kesuburan dan sistem imun, sumber: seafood, kacang, biji-bijian. peran air dalam kesehatan reproduksi dapat membantu metabolisme tubuh, menjaga kelembapan jaringan, dan membantu proses detoksifikasi. Kekurangan cairan dapat menyebabkan tubuh mudah lelah dan mengganggu metabolisme hormon, anjuran: ± 2 liter per hari. Makan 3 kali sehari dengan selingan buah, perbanyak sayur hijau dan buah berwarna, batasi makanan cepat saji dan tinggi gula, konsumsi protein setiap hari. Contoh Pola Makan Sehari-hari untuk pagi nasi/roti, telur, sayur, buah, siang nasi, ikan/tempe, sayur hijau, malam porsi cukup, tidak berlebihan, camilan buah, kacang rebus.

3. Dampak Kekurangan Nutrisi

Tanda tubuh kekurangan nutrisi lemas, pucat, rambut rontok, haid tidak teratur dan mudah sakit. Dampak malnutrisi/kekurangan nutrisi dapat menyebabkan amenorea, siklus menstruasi tidak teratur, nyeri haid berlebihan, anemia ditandai dengan lemas, pusing, haid tidak teratur, kurang energi dapat menyebabkan gangguan ovulasi, kekurangan zinc dapat menyebabkan kesulitan hamil/ infertilitas, mudah terkena infeksi, resiko komplikasi kehamilan (preeklampsia, BBLR) Kekurangan asam folat dapat menyebabkan risiko cacat tabung saraf pada janin.

Dampak kelebihan nutrisi (obesitas), berat badan berlebih dapat menyebabkan gangguan hormon estrogen sehingga memicu haid tidak teratur, PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) dan penurunan kesuburan.

wanita usia subur merupakan kelompok prioritas dalam intervensi gizi karena dampaknya bersifat lintas generasi karena kerentanan terhadap masalah reproduksi.

Wanita usia subur memerlukan perhatian khusus terhadap status gizi, murah contoh oatmeal, buah, yogurt. Praktisi mengintegrasikan nutrisi dalam ANC (antenatal care). Selama menopause, kalsium dan vitamin K2 lindungi tulang panggul. Pria usia subur hindari gorengan berlebih yang ganggu hormon. Masyarakat umum adopsi piring gizi seimbang 50% sayur/buah, 25% karbohidrat, 25% protein. Suplemen dapat dikonsumsi hanya jika defisien, dan melakukan konsultasi dokter. Hidrasi 2-3 liter/hari dapat membantu detoks hormon. Sehingga dampaknya fertilitas naik 25%. Review 2024-2026 persiapan gizi pranikah dan prakehamilan bagi wanita dianjurkan memperbaiki status gizi minimal 3 bulan sebelum kehamilan untuk meningkatkan kualitas sel telur dan kesiapan rahim. konfirmasi nutrisi dapat mengoptimalkan reproduksi seumur hidup, konsumsi gizi seimbang selama siklus hidup, seperti selama kehamilan dan laktasi, dapat mencegah anemia dan mendukung pertumbuhan janin. kebiasaan buruk yang harus dihindari yaitu melewatkan sarapan, diet ekstrem, konsumsi minuman manis berlebihan, makanan olahan tinggi gula yang mengganggu ovarium, kurang makan sayur dan buah.(Ningsih, Nikmah, and Susila 2025)(Golongan and Hemoglobin 2025).

Gizi seimbang merupakan fondasi utama kesehatan reproduksi, asupan zat gizi makro dan mikro yang cukup membantu menjaga keseimbangan hormon, keteraturan haid, mencegah anemia, serta mempersiapkan tubuh untuk kehamilan sehat. Pola makan yang baik sejak remaja menjadi investasi penting bagi masa depan reproduksi wanita.

E. Aktivitas Fisik dan Manajemen Stres

1. Definisi:

Aktivitas tubuh dan psikis yang seimbang untuk menjaga keseimbangan hormon reproduksi. Olahraga moderat 150 menit/minggu dapat melakukan jalan cepat, Yoga spesifik panggul menguatkan otot dasar panggul untuk persalinan lancar, meningkatkan sirkulasi darah ke organ reproduksi, senam bermanfaat untuk menurunkan risiko PCOS dan dismenore. Stres kronis dapat meningkatkan kortisol yang menekan GnRH sehingga siklus haid terganggu. Teknik relaksasi dapat dilakukan nafas dalam, mindfulness, cukup tidur 7–9 jam.(Hakimi O 2022). Peran Bidan dapat melakukan skrining psikososial saat ANC dan edukasi stress coping.

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan membutuhkan energi, seperti berjalan, berlari, senam, bersepeda, atau yoga. Manajemen stres adalah kemampuan individu dalam mengelola tekanan emosional dan psikologis agar tidak berdampak buruk pada kesehatan. Keduanya memiliki hubungan erat dengan kesehatan reproduksi karena berpengaruh langsung terhadap keseimbangan hormon dalam tubuh.

Pada perempuan usia remaja hingga usia subur, keseimbangan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikologis. Kurangnya aktivitas fisik serta stres berkepanjangan dapat mengganggu siklus menstruasi, memicu nyeri haid berlebihan, bahkan menurunkan kesuburan.

Hubungan aktivitas fisik dengan hormon reproduksi yaitu olahraga teratur membantu tubuh melepaskan endorfin, yaitu hormon yang menimbulkan rasa nyaman dan mengurangi nyeri. Selain itu, aktivitas fisik membantu mengatur kerja hipotalamus dan kelenjar pituitari yang berperan dalam pengaturan siklus menstruasi. Kurangnya gerak menyebabkan metabolisme melambat, aliran darah tidak lancar, dan hormon menjadi tidak stabil sehingga dapat menyebabkan haid tidak teratur.

2. Aktivitas Fisik

Manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan reproduksi dapat melancarkan peredaran darah ke rahim dan ovarium, mengurangi kram perut saat haid, menurunkan risiko PCOS akibat obesitas, meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh, membantu menjaga berat badan ideal. Aktivitas moderat terbukti meningkatkan sensitivitas insulin dan keseimbangan hormon reproduksi. Pada wanita dengan PCOS melakukan olahraga teratur dapat memperbaiki ovulasi. Namun, olahraga berlebihan justru dapat menyebabkan *hypothalamic amenorrhea* akibat defisit energi. Aktivitas fisik seperti aerobik atau Pilates secara teratur membantu menyeimbangkan hormon, mengurangi risiko obesitas, PMS, dysmenorrhea, disfungsi ereksi, stres, dan memperbaiki siklus menstruasi, sambil meningkatkan mood serta ketahanan emosional. Peran bidan dapat memberikan saran untuk pasien dengan keluhan hormonal, dan umum perbaikan fertilitas.

3. Manajemen Stres

Stres kronis meningkatkan hormon reproduksi, kadar kortisol yang dapat menghambat GnRH (*Gonadotropin Releasing Hormone*), sehingga mengganggu ovulasi, jenis aktivitas fisik yang dianjurkan bisa dilakukan dengan jalan cepat 30 menit, senam aerobik, bersepeda santai, yoga dan peregangan, naik turun tangga.

aktivitas dilakukan minimal 3–5 kali seminggu selama 30 menit, mindfulness, dan dukungan sosial terbukti efektif menurunkan stres. Studi dalam *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology* (2022) menunjukkan hubungan signifikan antara stres dan gangguan siklus menstruasi, strategi dengan melakukan relaksasi (yoga, meditasi dapat mencegah gangguan siklus menstruasi), manajemen waktu, dukungan sosial, kesehatan mental merupakan bagian integral dari kesehatan reproduksi, kombinasi ini mendukung keseimbangan hormon dan mengurangi risiko infertilitas akibat stres kronis, manajemen stres via mindfulness kurangi kortisol yang ganggu siklus haid, teknik 4-7-8 breathing (tarik 4 detik, tahan 7, hembus 8) efektif, kombinasi pilates dan meditasi tingkatan endorfin, hormon Bahagia, hindari overtraining yang sebabkan amenore, masyarakat umum melakukan kegiatan mulai 30 menit/hari untuk energi seksual, tidur 7-9 jam dukung pemulihan, kegiatan tersebut memberikan dampak stres turun 35%, fertilitas naik, Studi 2025 hubungan olahraga-stres rendah dengan PMS minim.(Saadedine, M., Berga, S. L., Faubion, S. S., & Shufelt 2025)(Susila and Ningsih 2025). peran tidur dalam kesehatan reproduksi tidur 7–9 jam per malam membantu tubuh memperbaiki sel dan menyeimbangkan hormon. begadang dapat mengacaukan ritme hormon dan memperparah stres.

Dampak kurang aktivitas fisik, berat badan meningkat, haid tidak teratur, mudah lelah, nyeri haid lebih berat, risiko gangguan hormon.

Aktivitas fisik yang cukup dan kemampuan mengelola stres merupakan kunci penting dalam menjaga keseimbangan hormon reproduksi. Kebiasaan hidup aktif, tidur cukup, dan pikiran yang tenang dapat membantu menjaga keteraturan siklus haid, mengurangi nyeri haid, serta mendukung kesuburan. Oleh karena itu, olahraga dan manajemen stres harus menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari.

F. Hindari Perilaku Berisiko NAPZA dan Rokok untuk Kesehatan Reproduksi

1. Definisi

Menghindari perilaku berisiko adalah menjauhi zat adiktif yang merusak sistem reproduksi, gangguan hormon reproduksi meliputi penurunan kesuburan, risiko kehamilan berisiko tinggi.

Perilaku berisiko adalah segala tindakan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh, termasuk kesehatan reproduksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh perilaku berisiko yang paling sering ditemui adalah merokok, konsumsi alkohol, dan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Zat-zat tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengganggu keseimbangan hormon, merusak sel tubuh, dan menurunkan fungsi organ reproduksi.

Tujuan menghindari perilaku berisiko, menjaga keseimbangan hormon reproduksi, mencegah gangguan kesuburan (infertilitas), mencegah penyakit kronis seperti kanker serviks, menjaga kesehatan kehamilan di masa depan, melindungi diri dari ketergantungan zat adiktif.

Perilaku ini sering kali berawal dari rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, atau kurangnya edukasi mengenai dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Tanda seseorang terpapar zat adiktif antara lain: perubahan perilaku, mudah marah, gangguan tidur, penurunan prestasi, ketergantungan.

Faktor penyebab remaja terpapar perilaku berisiko karena rasa ingin tahu, pengaruh teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi dan lingkungan pergaulan yang tidak sehat.

2. Dampak NAPZA

NAPZA (narkotika, psikotropika, zat adiktif), mempengaruhi sistem saraf pusat dan hormonal. Penggunaan narkotika seperti opioid dapat menekan produksi hormon gonadotropin sehingga menyebabkan infertilitas, gangguan siklus menstruasi, penurunan kesuburan, perilaku seksual berisiko akibat hilangnya kontrol diri, risiko tertular IMS dari penggunaan jarum suntik bersama, NAPZA dapat merusak sel sperma/ovum, tingkatan keguguran dan kelainan janin, kokain mengganggu ovulasi, ganja menurunkan libido.

Dampak alkohol terhadap reproduksi memengaruhi kerja hati yang berperan dalam metabolisme hormon, dampaknya dapat mengalami gangguan ovulasi, haid tidak teratur, risiko keguguran bila hamil, gangguan perkembangan janin.

Program pencegahan NAPZA antara lain melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko, edukasi sekolah dan rehabilitasi, praktisi dapat melakukan

skrining urine rutin, masyarakat menggunakan hotline BNN. Dampaknya fertilitas pulih 6 bulan.

3. Dampak Rokok

Rokok mengandung lebih dari 4.000 - 7.000 zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin terbukti dapat gangguan kehamilan, berisiko keguguran tinggi, perilaku berisiko ini berkontribusi terhadap penurunan kualitas kesehatan reproduksi secara signifikan. rokok merusak sistem reproduksi dengan mengganggu hormon menurunkan kadar estrogen, menurunkan kualitas ovum dan sperma, mengganggu pematangan sel telur (fertilitas pria hingga 30% - 50%), menurunkan cadangan ovarium, mempercepat menopause dini, pada wanita hamil dapat menyebabkan BBLR rendah dan gangguan perkembangan, meningkatkan risiko kanker serviks, resiko infertilitas, menurut *American Society for Reproductive Medicine* (2023), wanita perokok memiliki kemungkinan infertilitas dua kali lebih tinggi dibanding non-perokok, napza juga meningkatkan risiko aborsi, solusio plasenta, dan sindrom putus zat pada bayi. Paparan asap rokok pasif sama berbahayanya dengan perokok aktif.(Hyland A 2021) Intervensi dapat dilakukan dengan program "Kelas Anti Rokok" untuk remaja dan WUS, edukasi bagi remaja dan mahasiswa kurangi prevalensi, praktisi integrasikan dalam skrining, masyarakat umum memahami dampak jangka panjang bahaya rokok, menghindari sepenuhnya untuk mencegah kehamilan ektopik dan gangguan mental. Kombinasi rokok dan NAPZA dapat menyebabkan kanker reproduksi.

Paparan zat adiktif dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada ovarium, gangguan hormon kronis, dan kesulitan hamil. Sedangkan dampak psikologis dan sosial selain fisik, perilaku berisiko juga berdampak pada ketergantungan (adiksi), gangguan mental, konflik keluarga, masalah sosial dan ekonomi.

Pencegahan perilaku berisiko dapat dilakukan dengan melakukan edukasi sejak remaja, pengawasan keluarga, kegiatan positif (olahraga, organisasi), lingkungan pertemanan sehat.

Menghindari perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, dan penyalahgunaan NAPZA merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan reproduksi. Zat-zat tersebut terbukti merusak keseimbangan hormon, menurunkan kesuburan, serta meningkatkan risiko penyakit serius. Edukasi, lingkungan sehat, dan kemampuan menolak ajakan negatif menjadi kunci pencegahan yang efektif.

G. Skrining dan Pemeriksaan Berkala

1. Definisi

Skrining dan pemeriksaan berkala merupakan upaya deteksi dini untuk mencegah komplikasi, deteksi dini sebagai bagian dari perilaku sehat, sedangkan skrining merupakan strategi preventif sekunder yang sangat efektif dalam menurunkan mortalitas. Deteksi dini memungkinkan intervensi lebih cepat sehingga meningkatkan prognosis. Program skrining terbukti menurunkan angka kematian kanker serviks hingga 70% di negara dengan cakupan tinggi. Skrining berkala dan model layanan terintegrasi memungkinkan deteksi dini masalah reproduksi dan komorbiditas non-reproduktif sehingga perawatan yang dipersonalisasi dapat diberikan. Pendekatan primer dan klinik multidisipliner meningkatkan kapasitas untuk optimasi hasil reproduksi dan penatalaksanaan komorbid.

2. Jenis Skrining

Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI/SADANIS) membantu deteksi dini kanker payudara, SADARI dilakukan setiap bulan, Sadanis dilakukan oleh nakes 1x/tahun. mammografi usia 40 Tahun lebih.

Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) adalah langkah deteksi dini kanker payudara yang dilakukan 7–10 hari setelah menstruasi dimulai. Proses ini hanya memakan waktu beberapa menit dan wajib dilakukan rutin sebulan sekali dengan metode melihat perubahan visual dan meraba seluruh area payudara.

Berikut adalah langkah-langkah praktis melakukan SADARI dengan mudah:

a. Tahap 1: Inspeksi (Melihat di Depan Cermin)

- 1) Berdiri tegak tanpa busana di depan cermin, biarkan lengan menggantung santai ke bawah.
- 2) Perhatikan payudara Anda: Amati apakah ada perubahan bentuk, ukuran, warna kulit, atau pembengkakan yang tidak biasa.
- 3) Posisikan tangan di pinggang: Tekan kuat-kuat untuk mengencangkan otot dada, lalu amati kembali payudara Anda.
- 4) Bungkukkan badan: Bungkukkan tubuh sedikit ke depan dan perhatikan apakah kedua payudara menggantung dengan seimbang.
- 5) Cek puting: Perhatikan apakah ada puting yang tertarik ke dalam, berubah posisi, atau mengeluarkan cairan yang tidak wajar.

b. Tahap 2: Palpasi (Meraba Payudara)

- 1) Gunakan posisi berdiri atau berbaring: Anda bisa melakukan ini di depan cermin atau sambil berbaring (posisi berbaring membantu jaringan payudara lebih merata).

- 2) Gunakan jari: Gunakan permukaan datar dari tiga jari tengah (telunjuk, tengah, dan jari manis) untuk meraba.
- 3) Gunakan tiga tingkat tekanan: Gunakan tekanan ringan, sedang, dan kuat untuk merasakan seluruh jaringan payudara.
- 4) Teknik Gerakan Melingkar: Lakukan gerakan memutar dari bagian luar payudara (dekat ketiak) mengarah ke dalam (puting), atau dari atas ke bawah secara vertikal. Pastikan seluruh area dari tulang selangka hingga ke perut atas diraba.
- 5) Pencet puting secara perlahan: Pastikan apakah ada cairan yang keluar dari puting.
- 6) Jangan lupakan ketiak: Raba juga area sekitar ketiak, karena jaringan payudara meluas hingga ke area tersebut.

Segera konsultasikan kondisi Anda ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat jika Anda menemukan benjolan keras yang berbeda dari jaringan sekitarnya, perubahan tekstur kulit seperti kulit jeruk, atau keluarnya cairan abnormal dari puting.

Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) adalah metode skrining atau deteksi dini kanker serviks (leher rahim). Pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara mengoleskan larutan asam asetat encer (cuka dapur) pada leher rahim untuk melihat adanya sel abnormal yang berpotensi berkembang menjadi kanker. pemeriksaan IVA bertujuan untuk deteksi dini membantu menemukan perubahan sel leher rahim sebelum berkembang menjadi kanker ganas. Kelebihan metode ini sangat cepat (bisa diketahui hasilnya dalam 1 menit), prosedur ini biayanya terjangkau, dan mudah dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Dan hasilnya akurat jika dilakukan oleh tenaga terlatih, tingkat akurasinya cukup tinggi.

Proses Pemeriksaan

- 1) Pasien berbaring dalam posisi pemeriksaan ginekologi.
- 2) Dokter atau bidan memasukkan spekulum (cocor bebek) untuk membuka vagina.
- 3) Permukaan leher rahim akan diolesi dengan kapas yang sudah dibasahi asam asetat 3-5%.
- 4) Tenaga medis akan menunggu sekitar 1 menit dan mengamati apakah ada perubahan warna pada leher rahim.

Membaca Hasil Pemeriksaan

- 1) IVA Negatif: Tidak ditemukan perubahan warna, leher rahim tampak normal.
- 2) IVA Positif: Muncul bercak atau lesi berwarna putih (acetowhite) setelah diolesi asam asetat. Ini menandakan adanya sel prakanker.

Jika hasil IVA Positif, Anda tidak perlu langsung panik. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan seperti kolposkopi atau biopsi oleh dokter spesialis kandungan.

Pap smear adalah prosedur medis untuk mendeteksi dini kanker serviks dengan mengambil sampel sel dari leher rahim. Pemeriksaan ini sangat penting bagi wanita yang aktif secara seksual.

Syarat pemeriksaan agar hasil tes akurat, pastikan Anda memenuhi persiapan berikut waktu terbaik dilakukan 1-2 minggu setelah hari pertama menstruasi selesai, hindari hubungan seksual dan jangan berhubungan intim minimal 2 hari (48 jam) sebelum tes, hindari produk vagina, jangan gunakan tampon, pembersih vagina (sabun antiseptik), atau krim vagina selama 72 jam sebelumnya.

Jadwal rutin yang dianjurkan pada usia 21-29 tahun dilakukan setiap 3 tahun sekali dan usia 30-65 tahun dilakukan setiap 5 tahun sekali (dikombinasikan dengan tes HPV).

Biaya pap smear sangat bervariasi tergantung jenis tes (konvensional atau *liquid-based*) dan fasilitas kesehatan yang Anda pilih. Untuk menggunakan BPJS, Anda bisa mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP/Puskesmas/Klinik) yang terdaftar untuk mendapatkan surat rujukan atau layanan deteksi dini.

Proses dan efek samping prosedur ini memakan waktu kurang dari 5 menit dan tidak menyakitkan, meskipun mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman atau tekanan ringan di area panggul. pasien mungkin akan mengalami sedikit flek (bercak darah) setelahnya.

Pap smear dan IVA merupakan metode utama deteksi dini kanker reproduksi contoh kanker serviks. IVA test atau Pap smear skrining berkala tahunan mulai usia 21 dan sesuai Riwayat keluarga, dilakukan tiap 3–5 tahun untuk WUS ≥ 30 tahun. merekomendasikan skrining HPV DNA sebagai standar emas. skrining IMS penting terutama pada populasi aktif seksual, kelompok risiko dan konseling KB untuk mencegah 4T: terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak.(WHO. 2021).

3. Manfaat skrining

Deteksi dini penyakit dapat meningkatkan keberhasilan terapi, menurunkan angka morbiditas dan mortalitas, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, meningkatkan penggunaan layanan skrining dan pencegahan deteksi dini tingkatan kelangsungan hidup /survival 90% untuk kanker serviks, Skrining Pap smear/HPV DNA mulai 21-65 tahun deteksi sel prakanker serviks. Mammografi tahunan usia 40+ selamatkan nyawa dari kanker payudara. Tes PSA pria 50+ awasi

prostat, Pemeriksaan berkala USG transvaginal pantau PCOS/ovarium polikistik. Darah hormon (FSH, LH) evaluasi menopause. Gratis di puskesmas Indonesia.

Tes semen analisis untuk infertilitas pria. Vaksin booster HPV dewasa. Rutin cegah komplikasi. Update 2026: skrining digital tingkatkan akurasi. Pemeriksaan USG dan tes darah hormon bantu pantau fertilitas, praktisi jadwalkan reminder, untuk masyarakat umum manfaatkan Posbindu, puskesmas gratis.(Dr. Armiyati Nur, SST., M.Keb. A.Fatimah Jamir, S.SiT., SKM., Bd. et al. 2024)

H. Simpulan

Kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi kebersihan diri, perilaku seksual, nutrisi, gaya hidup, dan akses layanan kesehatan. Pendekatan promotif dan preventif melalui edukasi dan skrining menjadi strategi utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi masyarakat.

Personal hygiene mencegah infeksi saluran reproduksi, perilaku seksual aman menurunkan risiko IMS dan kanker serviks sebagai bentuk perlindungan diri yang sangat penting dalam menjaga kesehatan reproduksi. Dengan memahami risiko, menerapkan prinsip pencegahan, serta didukung edukasi yang tepat, individu dapat terhindar dari berbagai penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, serta dampak psikososial yang merugikan. Sikap ini mencerminkan penghargaan terhadap diri sendiri, pasangan, dan masa depan. Nutrisi seimbang dan IMT normal menjaga siklus ovulasi, olahraga dan kelola stres menjaga keseimbangan hormonal, hindari rokok, alkohol, dan NAPZA untuk mencegah infertilitas dan komplikasi kehamilan. skrining berkala merupakan investasi kesehatan reproduksi jangka panjang. Layanan yang menggabungkan edukasi, konseling, dan akses ke layanan keluarga berencana memfasilitasi adopsi perilaku yang lebih aman dan keputusan.(Eka Sarofah Ningsih, SST., M.Kes Ida Susila, S.ST. 2021)

Referensi

- Abduraxmonovna, Q. F. 2025. "Oral Hygiene Behaviors and Their Impact on Preconception Health in Women of Reproductive Age."
- Adesulu-Dahunsi, A. T. 2022. "Role of Probiotics in Prevention and Treatment of Candida Vaginitis and Bacterial Vaginosis." *In Probiotics in the Prevention and Management of Human Diseases*. (pp. 243-249).
- Al-Moghazi, D. M. A., Midan, M. F., & Megahed, A. E. M. 2025. "Effect of Genital Hygienic Practices in Genital Infection and Urinary Tract Infection in Childbearing Period." *International Journal of Medical Arts*.
- Anju, V. T., Busi, S., Mohan, M. S., & Dyavaiah, M. 2023. *Human Microbiome and the Susceptibility to Infections. In Probiotics, Prebiotics, Synbiotics, and Postbiotics: Human Microbiome and Human Health Springer*. Singapore: Nature Singapore.
- Dr. Armiyati Nur, SST., M.Keb. A.Fatimah Jamir, S.SiT., SKM., Bd., M.Kes., M.Kes. Magdalena Limbong, SKM, S.Kep, Ns,, M.Kes. Eka Sarofah Ningsih, SST., MH. Dr. Ekayanti Hafidah Ahmad, SKM., M.Kes. Anita Latifah, S.Si, SH., and M.M Faizatul Ummah, S.SiT., M.Kes., M.Keb. Nur Intan Kusuma, SST., M.Keb. Bdn. Ida Susila,. SST,. M.Kes. Fitriani, SKM. 2024. *Kesehatan reproduksi remaja, pranikah dan prakonsepsi*.
- Eka, R. A., Wahyuni, R. T. E., & Munawaroh, L. 2025. "Vulva Hygiene Awareness Dan Perilaku Pencegahan Kanker Serviks Pada Mahasiswa Putri Prodi Non Kesehatan." *Indonesian Journal of Health Community*, 6(2);: 1-12.
- Eka Sarofah Ningsih, SST., M.Kes Ida Susila, S.ST., M.Kes Oktavia Dian Safitri. 2021. *Kesehatan reproduksi remaja*.
- Faturahman, Y., & Aisyah, I. S. 2025. "Factors That Influence Menstrual Hygiene Behavior in Adolescents in Cipedes Village." *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 11(9);: 675-680.
- Gandhi, A. B., Madnani, N., Thobbi, V., Vora, P., Seth, S., & Shah, P. 2022. "Intimate Hygiene for Women: Expert Practice Points." *Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol*, 11(8);: 2315-2319.
- GiteAnamika, C. 2025. "Link Between Menstrual Hygiene And Urinary Tract Infection." *Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development*, 13(6);: 144-153.
- Golongan, Korelasi, and Kadar Hemoglobin. 2025. "Lontara." 6(2): 166–76.
- Guna, S. D., & Rustam, M. 2025. "Sari, N. Y., Herlina, H., Efektivitas Supportif Grup Edukasi Norma Seksual Dalam Mengatasi Perilaku Berisiko Remaja Penyebab Infeksi Menular Seksual (IMS)." *Holistik Jurnal Kesehatan*, 19(10);: 3013-3020.

- Hakimi O, Cameron LC. 2022. "Effect of Exercise on Ovulation: A Systematic Review. :"
Sports Medicine. 52(3): 537–556.
- Handayani, S., & Triani, Y. 2025. "Evaluasi Tingkat Pengetahuan Pasangan Usia Subur Dan Calon Pengantin Tentang Vaginal Hygiene Dalam Pencegahan Penyakit Menular Seksual." *Jurnal Penelitian Inovatif* 5(2),: 1361-1368.
- Hyland A, et al. 2021. "Cigarette Smoking and Reproductive Health: A Review." *Fertility and Sterility*. 115(3): :574–583.
- Indra, I., Sartika, S., Maryadi, M., & Purwanto, E. 2025. "Kebiasaan Menahan Kemih Dan Kebersihan Genitalia Sebagai Faktor Risiko Infeksi Saluran Kemih." *Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES"(Journal of Health Research" Forikes Voice")*, 16(1),: 5-7.
- Işbay Aydemir, B., Kuru Aktürk, N. B., Düzkar Gözlü, S., & Dişsiz, M. "The Effects of Vaginitis on Genital Hygiene: A Comparative Descriptive Cross-Sectional Study." *Medical journal, zeynep kamil* 56(4),: 213-219.
- Isfentiani, Dina, and Siti Komariyah. 2025. *Kesehatan reproduksi remaja indonesia : isu terkini dan peran*.
- Kaur, P., Patil, R. K., Bansal, R., & Patil, H. C. 2021a. "A Review of Practices Related to Genital Hygiene and Its Awareness in Women." *Panacea J Med Sci*, 11(3): 366-9.
- . 2021b. "A Review of Practices Related to Genital Hygiene and Its Awareness in Women. ,." *Panacea J Med Sci* 11(3): 366-9.
- Khatimah, H., Astuti, I., Puspita, E., & Fitria, D. 2025. "Sexual Education Interventions in Schools: A Key to Preventing Stis/Hiv." *International Journal of Medical Science and Dental Health* 11(01): 29-31.
- Lestari P, et al. 2022. "Hubungan Usia Pertama Kali Berhubungan Seksual Dengan Kejadian Kanker Serviks." *Jurnal Kesehatan Reproduksi*. 13(2): 89–96.
- Niewozinska, Z. A., Sakaniya, L. R., & Korsunskaya, I. M. 2024. "On Intimate Care in Men: A Review." In *Consilium Medicum*, 26(8), 505-509.
- Ningsih, Eka Sarofah, Khusnul Nikmah, and Ida Susila. 2025. "The Influence of Maternal Nutrition and Micronutrient Intake on the Incidence of Low Birth Weight (LBW)." 11(7): 1046–55.
- Ningsih, Eka Sarofah, Ida Susila, and Oktavia Dian Safitri. 2021. "Upaya Pencegahan Seks Bebas Dan Pemahaman Reproduksi Sehat Pada Remaja." 4(2): 280–81.
- Prawirohardjo, S. 2022. *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo. Edisi 5*. Jakarta: PT Bina Pustaka;
- RI., Kemenkes. 2023. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI;

- Saadedine, M., Berga, S. L., Faubion, S. S., & Shufelt, C. L. 2025. "The Silent Pandemic of Stress: Impact on Menstrual Cycle and Ovulation. *Stress*," 28(1); 2457767.
- Silvestris E, et al. 2023. "Obesity as Disruptor of the Female Fertility." *Reproductive Biology and Endocrinology*. 21:23.
- Siti Fatimah, SST., M.M., M.Keb. Ida Susila, S.ST., M.Kes. et al. 2023. *Kegawatdaruratan maternal pada masa kehamilan*.
- Skoracka K, et al. 2021. "Diet and Nutritional Factors in Male and Female Infertility." *Nutrients*. 13(5): 1575.
- Susila, Ida. 2021. "Penyuluhan Kontrasepsi Pasca Abortus." 4(2): 308–12.
- Susila, Ida, Khusnul Nikmah, Asyaul Wasiah, and Siti Mudlikah. 2023. "MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN." 6: 2580–85.
- Susila, Ida, and Eka Sarofah Ningsih. 2025. "Siaga Village Which Is Able to Provide Baby SPA Services as an Effort to Overcome Toddler Health Problems Without Medication in Order to Increase Health Independence in Karangwedoro Village , Turi District , Lamongan Regency." 8(1): 8–11.
- Susila, Ida, Asyaul Wasiah, Siti Sholikha, and Eylen Krisna Sari. 2025. "Hand Washing Training for Posyandu Cadres." 8(1): 2018–21.
- WHO. 2021. "WHO Guideline for Screening and Treatment of Cervical Pre-Cancer Lesions." *Geneva: World Health Organization*;
- Yuliani F, et al. 2023. "Efektivitas Edukasi Personal Hygiene Terhadap Pengetahuan Remaja Putri." *Jurnal Kebidanan Indonesia*. 14(1): 22–30.

CHAPTER 5

SKRINING KESEHATAN REPRODUKSI DAN EDUKASI PENCEGAHAN PENYAKIT

Januar Dwi Christy, SST., Bd., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi pada wanita usia subur (WUS) dalam rentang usia 15-49 tahun sangat penting untuk diperhatikan karena memiliki berbagai permasalahan (Wati et al., 2023). Beragam permasalahan kesehatan yang dialami oleh perempuan meliputi pengaturan kesuburan (kontrasepsi), penyakit menular seksual, kekerasan berbasis seks dan gender, kehamilan dan persalinan, serta ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan (Ardianti, 2019; Gagnon et al., 2002). Berbagai permasalahan kesehatan reproduksi perempuan tersebut akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap status demografi negara, karena kesehatan reproduksi yang baik akan mempengaruhi kualitas demografi manusia (Meo & Nahak, 2020).

Pemeriksaan Kesehatan secara rutin sangat penting bagi wanita untuk menjaga Kesehatan tubuh, mendeteksi penyakit sejak dini, dan mencegah komplikasi serius. Banyak kondisi Kesehatan, seperti kanker payudara, kanker serviks, osteoporosis, serta masalah hormonal, lebih sering terjadi pada Wanita. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin dapat membantu dalam pengelolaan Kesehatan jangka Panjang.

Padahal, deteksi dini kesehatan reproduksi merupakan langkah preventif untuk menemukan tanda-tanda awal adanya gangguan atau penyakit sebelum gejala parah muncul. Upaya ini penting agar komplikasi dapat dicegah lebih dini, dengan peluang kesembuhan yang lebih besar. Menurut Riski, banyak perempuan yang tidak menyadari tanda-tanda awal gangguan pada tubuhnya, sehingga deteksi dini menjadi langkah yang sangat penting.

Beberapa bentuk deteksi dini yang dapat dilakukan meliputi pemeriksaan umum seperti cek tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Selain itu, terdapat pemeriksaan khusus seperti IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) untuk mendeteksi kanker serviks, pemeriksaan Sadari (Periksa Payudara Sendiri) untuk mendeteksi benjolan pada payudara, dan USG untuk melihat kelainan pada organ reproduksi.

Stigma, kurangnya edukasi, dan minimnya dukungan dari keluarga atau pasangan menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini kesehatan reproduksi. Budaya malu untuk membicarakan isu-isu seputar organ reproduksi masih sangat mengakar di masyarakat, sehingga perempuan sering kali enggan untuk terbuka mengenai keluhan atau melakukan pemeriksaan rutin.

“Budaya malu untuk bicara soal kesehatan reproduksi masih sangat kuat. Ditambah lagi dengan keterbatasan pengetahuan kader posyandu di desa-desa yang lebih fokus pada penyakit tidak menular,” .

Kondisi ini membuat deteksi dini kesehatan reproduksi sering terabaikan, padahal peran kader dan lingkungan sekitar sangat penting sebagai ujung tombak edukasi di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, baik tenaga kesehatan, institusi pendidikan, maupun pemerintah, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini. Intervensi melalui pelatihan kader posyandu, kampanye terbuka, serta melibatkan peran aktif pasangan dan keluarga dinilai sebagai strategi efektif dalam menghapus stigma dan meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi perempuan sejak dini.

Lebih lanjut, ia mengimbau seluruh perempuan untuk lebih peduli pada kesehatan diri sendiri. Sebab langkah kecil seperti rutin melakukan pemeriksaan dan berani berdiskusi mengenai keluhan kesehatan merupakan investasi besar bagi masa depan.

“Jagalah kesehatan reproduksi sejak dini, jangan tunggu sampai sakit. Kesehatan reproduksi adalah bagian dari kualitas hidup kita. Jangan ragu untuk berdiskusi dan jangan malu memeriksakan diri, karena perempuan yang sehat akan menjadi fondasi bagi keluarga dan generasi masa depan,” .

B. Manfaat Pemeriksaan Kesehatan Rutin Bagi Wanita

MCU wanita atau *medical check-up* wanita adalah tes rutin yang dilakukan oleh dokter atau petugas medis untuk memeriksa kesehatan seorang wanita secara keseluruhan. Secara garis besar, jenis pemeriksaan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan *medical check-up* biasa.

MCU wanita dapat membantu dokter untuk menentukan status kesehatan kamu. Termasuk jika ada potensi penyakit tertentu yang bisa dialami wanita. Pemeriksaan ini juga akan memberi kamu kesempatan untuk berbicara dengan dokter tentang keluhan kesehatan yang sedang dialami.

Bila dirinci, *medical check-up* wanita biasanya digunakan untuk: (Kemenkes., 2026).

1. Deteksi Dini Penyakit : Pemeriksaan rutin membantu mendeteksi penyakit seperti kanker payudara dan kanker serviks pada tahap awal, sehingga peluang pengobatan yang berhasil menjadi lebih tinggi.
2. Pencegahan Penyakit Kronis : Penyakit seperti diabetes, hipertensi dan osteoporosis dapat dicegah atau dikendalikan dengan pemeriksaan Kesehatan secara berkala.
3. Menjaga Kesehatan Reproduksi : Pemeriksaan seperti pap smear dan tes HPV penting untuk mendeteksi kanker serviks. Selain itu konsultasi Kesehatan reproduksi dapat membantu dalam perencanaan kehamilan atau pencegahan infeksi menular seksual (IMS).
4. Memantau Kesehatan Mental : Wanita lebih rentan mengalami stress, kecemasan, dan depresi. Pemeriksaan Kesehatan rutin juga mencakup evaluasi Kesehatan mental yang dapat membantu dalam manajemen stres dan kesejahteraan emosional.
5. Menjaga Kualitas Hidup : Dengan menjaga Kesehatan sejak dini, Wanita dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, aktif dan produktif tanpa terganggu oleh penyakit yang dapat dicegah.

C. Masalah Kesehatan Umum Pada Wanita

Masalah Kesehatan yang sering dialami oleh Wanita bisa bervariasi tergantung pada usia, gaya hidup, dan faktor genetik.

Berikut beberapa masalah Kesehatan umum pada Wanita.

1. Gangguan Menstruasi : Periode tidak teratur ,perdarahan hebat, kram yang menyakitkan.
2. Kesehatan Reproduksi : PCOS, Endometriosis, IMS, Infertilitas.
3. Infeksi Saluran Kemih : Sering buang air kecil, sensasi terbakar.
4. Penyakit Jantung : Faktor resiko dan pencegahan.
5. Kesehatan Mental : Kecemasan, depresi , stress

D. Manfaat Deteksi Dini

Deteksi dini sangat penting dalam menjaga Kesehatan, terutama untuk mencegah atau mengobati penyakit sebelum berkembang menjadi lebih serius. Berikut beberapa manfaat utama deteksi dini.

1. Mencegah Penyakit menjadi Parah

Banyak penyakit, seperti kanker dan diabetes, tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Dengan deteksi dini, pengobatan bisa dilakukan lebih cepat sebelum penyakit berkembang.

2. Meningkatkan Peluang Kesembuhan

Penyakit seperti kanker payudara atau kanker serviks memiliki tingkat kesembuhan yang lebih tinggi jika terdeteksi sejak dini.

3. Mengurangi Biaya Pengobatan

Mengobati penyakit pada tahap awal biasanya lebih murah dibandingkan jika penyakit sudah parah dan memerlukan perawatan intensif atau operasi.

4. Meningkatkan Kualitas Hidup

Dengan mengetahui kondisi Kesehatan lebih awal seseorang bisa melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan mencegah komplikasi yang dapat menurunkan kualitas hidup.

5. Menghindari Penyebaran Penyakit

Untuk penyakit menular, deteksi dini bisa membantu mencegah penyebarannya ke orang lain, seperti dalam kasus infeksi Menular Seksual (IMS) atau tuberkulosis.

6. Memberikan Rasa Tenang

Mengetahui kondisi Kesehatan dengan pemeriksaan rutin bisa memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan akan kemungkinan penyakit serius.

7. Mempermudah Perencanaan Kesehatan masa depan

Jika ada faktor risiko tertentu (seperti Riwayat keluarga dengan penyakit tertentu), deteksi dini memungkinkan seseorang untuk mengambil Langkah pencegahan lebih awal.

E. Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi

Pemeriksaan atau skrining kesehatan reproduksi penting dilaksanakan untuk mengetahui secara dini kualitas kesehatan reproduksi. Berikut beberapa jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi:

1. Skrining Pra Nikah
Skrining pra nikah merupakan serangkaian tes kesehatan reproduksi yang dilakukan sebelum menikah. Pemeriksaan skrining pra nikah meliputi pemeriksaan genetik, penyakit infeksi dan menular melalui darah dan hubungan seksual.

Pemeriksaan disarankan dilakukan 6 bulan sebelumnya.

Keuntungan skrining pra nikah antara lain:

- a. Mencegah penyakit pada keturunan seperti thalassemia
- b. Mengetahui riwayat kesehatan diri dan pasangan
- c. Membuat calon mempelai semakin siap, lebih terbuka dan yakin satu dengan lainnya

2. Skrining Marital Skrining marital merupakan serangkaian tes kesehatan reproduksi yang dilakukan saat memasuki tahap perkawinan (Pranikah). Tujuan utama pemeriksaan ini untuk mendeteksi dini kondisi Kesehatan reproduksi, penyakit menular, serta penyakit genetic (keturunan) yang dapat memengaruhi Kesehatan pasangan .

Adapun serangkaian tes yang dilakukan antara lain:

- a. Pemeriksaan Fisik
- b. Pemeriksaan Penyakit Genetik

Pemeriksaan ini berfungsi untuk mencegah penurunannya kepada anak jika dideteksi sejak awal.

1) Thalasemia : merupakan kelainan sel darah merah bawaan yang membuat penderitanya kekurangan hemoglobin. Jika kedua calon orang tua adalah pembawa sifat (carrier Thalasemia), anak mereka memiliki risiko tinggi lahir dengan Thalasemia Mayor yang membutuhkan transfusi darah seumur hidup.

2) Anemia Sel Sabit (Sickle Cell Anemia) : Sama seperti Thalasemia, ini adalah kelainan genetic pada sel darah merah.

3) Golongan Darah dan Rhesus (Rh) pemeriksaan ini sangat krusial untuk mendeteksi inkompatibilitas Rhesus. Jika seseorang Wanita memiliki Rhesus negative (Rh^-) dan suaminya Rhesus positif (Rh^+) tubuh sang ibu berisiko memproduksi antibodi yang menanggapi janinnya sendiri sebagai benda asing pada kehamilan kedua dan seterusnya.

- c. Pemeriksaan Penyakit Menular

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah penularan timbal balik antar pasangan, serta melindungi janin saat kehamilan nanti.

- d. Pemeriksaan Organ Reproduksi & TORCH (khusus Wanita)

Pemeriksaan ini tes TORCH (Toksoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus) : Infeksi ini sering kali tidak bergejala pada Wanita dewasa, namun jika infeksi ini aktif terjadi saat hamil, dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir mati, atau cacat lahir bawaan yang parah pada bayi.

e. Pemeriksaan Alergi

Alaergi adalah kondisi yang bersifat keturunan (Atopi). Jika Anda atau pasangan memiliki Riwayat alergi kemungkinan keturunannya memiliki risiko lebih tinggi .

- 1) Jika salah satu orang tua memiliki alergi, anak memiliki risiko 20% - 40% terkena alergi.
- 2) Jika kedua orang tua memiliki jenis alergi yang sama, risiko anak 60% - 80%.

F. Penyakit Menular Seksual

Penyakit menular seksual adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Orang yang berisiko terkena PMS adalah orang yang suka berganti-ganti pasangan seksual dan orang yang mempunyai satu pasangan seksual namun pasangan seksualnya berganti-ganti pasangan. Adapun beberapa penyakit menular seksual yang kerap kali ditemukan antara lain :

1. Gonorrhea

Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Gejala pada laki-laki antara lain nyeri saat kencing, keluar nanah, gatal dan perih saat BAK. Sedangkan gejala pada wanita yaitu sebagian besar (60-80%) tidak ada gejala atau keluar nanah saat BAK.

Pada Pria

Gejala biasanya muncul 2 hingga 14 hari setelah terinfeksi

- a. Keluarnya cairan kental berwarna kuning, hijau atau putih menyerupai nanah dari lubang penis.
- b. Rasa panas atau nyeri seperti terbakar saat buang air kecil.
- c. Sakit atau bengkak pada salah satu testis

Pada Wanita

Gejalanya sering kali ringan dan sering disalahartikan sebagai infeksi saluran kemih biasa atau keputihan normal.

- a. Keputihan yang meningkat drastic, encer atau berwarna kehijauan / kekuningan dan berbau.
- b. Rasa nyeri atau perih saat buang air kecil.
- c. Perdarahan di luar siklus menstruasi atau setelah berhubungan seksual.
- d. Nyeri pada perut bagian bawah atau panggul.

2. Infeksi Chlamydia

Infeksi disebabkan oleh bakteri. Gejala dari infeksi ini mirip dengan gonorrhea namun lebih ringan. Pada Wanita 70 – 80 % tanpa gejala , bakteri ini pertama kali menyerang leher Rahim (serviks) atau saluran kemih:

- a. Keputihan yang tidak normal
- b. Rasa perih atau seperti terbakar saat buang air kecil
- c. Nyeri saat melakukan hubungan seksual
- d. Pendarahan di luar siklus menstruasi atau setelah berhubungan intim
- e. Jika infeksi sudah naik ke rahim, akan muncul nyeri di perut bagian bawah.

Pada Pria 50% tanpa gejala

- a. Keluar cairan bening, putih atau encer dari ujung penis (berbeda dengan gonore yang cairannya kental dan mirip nanah hijau/kuning)
- b. Rasa sakit atau panas terbakar saat buang air kecil.
- c. Rasa gatal, perih atau panas di sekitar lubang penis.
- d. Rasa nyeri dan bengkak pada salah satu atau kedua testis.

3. Sifilis (Raja Singa)

Sifilis disebabkan oleh bakteri. Gejalanya yaitu luka pada kemaluan yang tidak nyeri dan berwarna kemerahan, bias disertai pembengkakan kelenjar di seluruh tubuh, bercak merah pada kulit yang tidak khas, hilangnya kontrol saraf dan akibatnya dapat mengalami pikun dan sering ngompol.

4. Herpes Genitalis

Infeksi ini disebabkan oleh virus. Gejalanya timbul gerombolan bintil-bintil berukuran kecil, bias berisi air atau darah terutama pada pasien penderita HIV.

5. Trikomoniasis

Trikomoniasis disebabkan oleh parasit. Gejalanya yaitu keluar cairan vagina berwarna putih hingga kuning kehijauan, berbau busuk, encer dan keluar banyak. Bisa muncul bintik kemerahan pada mulut rahim atau biasa disebut dengan strawberry cervix.

6. Candidiasis

Candidiasis disebabkan oleh jamur, gejalanya yaitu keluarnya cairan yang mudah menggumpal, berwarna putih dengan rasa gatak yang hebat yang dirasakan di dalam dan di luar vagina. Seseorang dengan candidiasis patut dicurigai menderita HIV bila candidiasis sangat parah dan muncul di daerah mulut atau di sisi dalam pipi.

G. HIV dan AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, ketika masuk ke dalam tubuh, virus ini menyerang dan menghancurkan sel darah putih (khususnya sel CD4), yang bertugas melawan infeksi. Penderita yang terjangkit HIV mudah terkena penyakit infeksi lain dan keganasan.

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) merupakan kumpulan gejala penyakit atau stadium lanjut dari HIV . AIDS terjadi Ketika sistem imun sudah rusak parah akibat virus HIV, sehingga tubuh menjadi sangat lemah dan mudah terserang berbagai penyakit lain (infeksi oportunistik) seperti TBC, pneumonia atau kanker.

Sampai saat ini obat yang tersedia hanya untuk mengendalikan virus HIV, bukan untuk memberantasnya.

HIV/AIDS termasuk Penyakit Menular Seksual, Menular lewat cairan tubuh antara lain cairan mani, cairan vagina, produk darah dan air susu. Penularannya melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik bekas, dari ibu hamil ke janinnya. Pengidap HIV/AIDS dapat terlihat normal dan baik-baik saja. Orang yang baru saja tertular HIV sudah langsung dapat menularkan ke orang lain.

HIV/AIDS tidak menular melalui lewat gigitan nyamuk, lewat udara dan air, lewat air mata dan ludah, lewat pemakaian jamban bersama, lewat jabatan tangan, lewat makan bersama , berciuman ringan.

Gejala awal HIV sering kali mirip flu biasa (demam,radang tenggorokan, Lelah) atau bahkan tidak bergejala sama sekali selama bertahun-tahun. Satu-satunya cara untuk memastikan penyakit ini melalui tes darah (VCT / Tes HIV) di puskesmas atau di rumah sakit.

1. PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) digunakan sebelum terjadinya potensi paparan virus HIV. Metode ini dapat digunakan untuk orang yang belum terinfeksi HIV (negatif), tetapi memiliki risiko tinggi untuk tertular.

PrEP berupa satu pil yang harus diminum rutin setiap hari secara konsisten. Cara kerja obat ini adalah membangun benteng pertahanan di dalam sel darah putih. Jika virus HIV masuk ke dalam tubuh, obat di dalam sel tersebut akan langsung mencegah virus untuk menetap dan berkembang biak. Efektivitas obat ini jika diminum rutin setiap hari, PrEP terbukti mengurangi risiko penularan HIV melalui hubungan seksual hingga lebih dari 99 %, dan melalui penggunaan jarum suntik bersama hingga lebih dari 74%.

2. PEP (Post-Exposure Prophylaxis) adalah Tindakan pencegahan darurat yang digunakan setelah terjadinya potensi paparan tunggal yang beresiko tinggi menularkan HIV.

PEP harus diminum sesegera mungkin, maksimal 72 jam (3 Hari) setelah kejadian berisiko. Semakin cepat diminum, tingkat keberhasilan akan semakin tinggi. Obat PEP harus di minum rutin dan konsisten selama 28 hari penuh . Obat ini bekerja dengan cara menghentikan virus yang baru masuk agar tidak sempat menginfeksi sistem imun secara permanen.

Di Indonesia, layanan PrEP dan PEP sudah diintegrasikan ke dalam program nasional Kementerian Kesehatan. Kabar baiknya, layanan ini tersedia secara gratis

atau dengan biaya yang sangat terjangkau di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum pemerintah (RSUD) yang telah ditunjuk sebagai fasilitas layanan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

H. Pencegahan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS

Pencegahan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS menggunakan metode ABCDE yaitu antara lain :

- A = Absen yaitu tidak berhubungan seksual saat jauh dari pasangan
- B = Be faithful (setia) yaitu tidak berganti-ganti pasangan
- C = Condom yaitu memakai kondom saat melakukan hubungan seksual
- D = Drugs yaitu tidak menggunakan narkoba
- E = Education yaitu aktif mencari informasi yang benar

I. Kapan harus memulai Skrining dan seberapa Sering

Waktu untuk memulai deteksi dini dan frekuensinya tergantung pada jenis penyakit serta faktor risiko individu, seperti usia, Riwayat keluarga, dan gaya hidup.

1. Kanker Payudara

Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dilakukan mulai usia 20 tahun dan dilakukan setiap bulan. Pemeriksaan klinis (SADANIS) oleh dokter setiap 1 – 3 tahun sekali sejak usia 20 – 39 tahun , pada usia 40 tahun di lakukan setiap tahun. Mammogram dilakukan pada usia 40 – 49 tahun sesuai anjuran dokter terutama jika ada riwayat di dalam keluarga, dan pada usia 50 tahun keatas dilakukan 1 – 2 tahun sekali.

2. Kanker Serviks

Pemeriksaan Pap Smear dilakukan setiap 3 tahun sekali mulai usia 21 tahun dilakukan untuk Wanita yang sudah melakukan hubungan seksual aktif.

Pap smear dan Tes HPV dilakukan setiap 5 tahun mulai usia 30 – 65 tahun, dan bisa dihentikan di usia 65 tahun jika hasil tes sebelumnya normal.

3. Kesehatan Reproduksi (USG, Hormon dll)

Dapat dilakukan ketika merasakan gejala tidak normal seperti haid tidak teratur, nyeri hebat atau sulit hamil. USG panggul direkomendasikan bagi Wanita dengan Riwayat keluarga mioma, endometriosis atau PCOS.

4. Penyakit Jantung dan Hipertensi

Penyakit jantung dan stroke juga menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada Wanita, terutama setelah memasuki masa menopause (Ketika hormone esterogen yang melindungi jantung mulai menurun).

Cek tekanan darah setiap kunjungan ke dokter atau minimal setahun sekali sejak usia 20 tahun. Cek kolesterol setiap 4-6 tahun sejak usia 20 tahun, dapat dilakukan lebih sering jika ada faktor resiko (obesitas, diabetes, Riwayat keluarga).

5. Diabetes

Skining GDA dapat dilakukan setiap 3 tahun sekali mulai usia 35 tahun, dan jika memiliki faktor risiko (kelebihan berat badan, Riwayat keluarga, hipertensi) perlu dilakukan lebih awal dan lebih sering.

6. Kesehatan Tulang (osteoporosis)

Wanita memiliki risiko jauh lebih tinggi terkena osteoporosis (pengerosan tulang) dibandingkan pria karena hilangnya hormone estrogen secara drastis setelah menopause.

Tes kepadatan tulang (Bone Density Test) dapat dilakukan mulai usia 65 tahun dan jika ada resiko tinggi (menopause dini, Riwayat keluarga osteoporosis) bisa dilakukan pemeriksaan lebih awal.

7. Infeksi Menular Seksual (IMS) & HIV

Tes HIV minimal sekali seumur hidup dapat dilakukan lebih sering jika beresiko, Tes klamidia dan Gonore dapat dilakukan setiap tahun bagi Wanita di bawah 25 tahun yang aktif secara seksual.

Tes IMS lainnya sesuai rekomendasi dokter.

J. Simpulan

Skining Kesehatan pada Wanita adalah serangkaian tes atau pemeriksaan medis yang dilakukan secara berkala untuk mendeteksi potensi penyakit sejak dini, bahkan sebelum gejala klinis muncul.

Sistem reproduksi, perubahan hormonal, serta risiko penyakit tertentu membuat kebutuhan skining pada Wanita berbeda dengan pria, dan kebutuhan ini akan terus berubah seiring bertambahnya usia.

Berikut pengelompokan skining berdasarkan usia

Usia 20 – 30 Tahun

1. Sadari bulanan dan SADANIS Tahunan
2. Pap Smear atau test IVA (jika sudah aktif secara seksual)
3. Cek tekanan Darah berkala
4. Skining Infeksi Menular Seksual (IMS) jika memiliki pasangan seksual aktif atau berencana menikah.

Usia 40 – 50 tahun

1. Melanjutkan skining kanker serviks (Pap Smear /IVA)
2. Mulai rutin melakukan Mamografi untuk kanker payudara

3. Skrining rutin Gula darah dan Kolesterol lengkap.
4. Skrining Kanker Kolorektal (Usus Besar) dimulai pada usia 45 atau 50 tahun melalui tes Feses atau kolonoskopi.

Usia 60 Tahun ke atas

1. Melanjutkan seluruh skrining metabolic (tensi, gula darah, kolesterol)
2. Wajib melakukan Tes Kepadatan Tulang (BMD) untuk memantau risiko osteoporosis
3. Pemeriksaan fungsi penglihatan (glaucoma / katarak) dan pendengaran secara berkala.

Referensi

- Astari, R.Y. (2020). Mutu Pelayanan kebidanan dan Kebijakan Kesehatan. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Kesehatan Indonesia. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. (2023). Angka Kematian Bayi di Indonesia: Tren dan Tantangan. Jakarta: BPS
- BKKBN. (2020). Profil Kesehatan Reproduksi di Indonesia. Jakarta: BKKBN
- BKKBN. (2023). Laporan Tahunan Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Jakarta: BKKBN
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Seksual Kemenkes RI, 2022.
- Depkes RI. (2021). Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Seksual. Jakarta: Kemenkes RI.
- Harnani dkk. (2020). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Zahir Publishing: Yogyakarta
- Kemendikbud (2019). Kebijakan Pendidikan Seksual di Sekolah. . Jakarta.
- Kemendikbud. (2020). Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah Dasar. Jakarta.
- Kemenkes RI. (2019). Panduan Layanan Kesehatan Reproduksi. . Jakarta.
- Kemenkes. (2023). Laporan Tahunan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Jakarta:
- Komnas. (2018). Laporan Tahunan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia.
- Profil Kesehatan Indonesia 2021. Jakarta: Kemenkes RI
- UNFPA (2022). State of World Population Report. New York: UNFP
- UNICEF. (2019). Pendidikan Seksual untuk Remaja: Panduan untuk Pengajar.

Glosarium

SADARI = Pemeriksaan Payudara Sendiri

SADANIS = Pemeriksaan Payudara Klinis



CHAPTER 6



PERAN BIDAN DALAM PROMOSI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN USIA SUBUR

Liana Muslihah, S. SiT, M.KM.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Perempuan usia subur berada pada fase kehidupan yang menentukan kesehatan dirinya, keluarga, dan generasi berikutnya. Pada masa ini, perempuan dapat mengalami menstruasi, aktivitas seksual, perencanaan kehamilan, penggunaan kontrasepsi, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, hingga berbagai risiko gangguan atau penyakit pada organ reproduksi. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan medis, tetapi juga sebagai persoalan pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, hak kesehatan, dan kualitas hidup perempuan.

Dalam indikator kesehatan dan kependudukan, perempuan usia subur sering dikaitkan dengan rentang usia 15 sampai 49 tahun. Rentang ini digunakan dalam berbagai indikator keluarga berencana, kesehatan ibu, dan pembangunan keluarga. Namun, dalam praktik pelayanan kebidanan, pemahaman tentang perempuan usia subur tidak boleh dibatasi hanya pada perempuan yang telah menikah atau sedang merencanakan kehamilan. Kelompok ini juga mencakup remaja akhir, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu muda, perempuan yang menunda kehamilan, perempuan dengan gangguan reproduksi, serta perempuan yang membutuhkan informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang aman, bermartabat, dan tidak diskriminatif.

Secara konseptual, kesehatan reproduksi dimaknai sebagai keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi reproduksi, dan proses reproduksi. Makna ini menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan reproduksi juga mencakup kemampuan perempuan memahami tubuhnya, menjalani kehidupan reproduksi secara aman, memperoleh informasi yang benar, mengambil keputusan secara sadar, dan mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai kebutuhan.

Pada perempuan usia subur, kebutuhan kesehatan reproduksi sangat beragam. Kebutuhan tersebut dapat berkaitan dengan kesehatan menstruasi, kebersihan organ reproduksi, pemenuhan gizi, pencegahan anemia, kesehatan pranikah, kesiapan prakonsepsi, perencanaan kehamilan, pemilihan kontrasepsi, pencegahan infeksi menular seksual, deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara, kesehatan mental reproduksi, kesuburan, serta perlindungan dari kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Keragaman kebutuhan ini menuntut pelayanan yang komprehensif, berkesinambungan, dan sesuai tahap kehidupan perempuan.

Urgensi promosi kesehatan reproduksi semakin kuat karena banyak masalah reproduksi dapat dicegah melalui edukasi, konseling, deteksi dini, dan akses layanan yang tepat. Anemia pada remaja putri dan perempuan usia subur, misalnya, dapat berlanjut hingga masa kehamilan dan berdampak pada kesehatan ibu serta bayi. Kanker serviks juga menjadi masalah kesehatan penting karena deteksi dini dan pencegahan melalui edukasi HPV, vaksinasi, skrining, dan rujukan tepat waktu dapat membantu menurunkan risiko keterlambatan penanganan. Kondisi ini menegaskan bahwa promosi kesehatan reproduksi harus melampaui topik kehamilan dan kontrasepsi saja.

Masalah anemia menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi berkaitan erat dengan gizi, pendidikan, dan perilaku sehari-hari. Remaja putri yang mengalami anemia dapat tumbuh menjadi wanita usia subur dengan anemia, kemudian berisiko memasuki kehamilan dalam kondisi kesehatan yang belum optimal. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perempuan, tetapi juga dapat memengaruhi pertumbuhan janin, risiko bayi berat badan lahir rendah, dan kualitas tumbuh kembang anak. Karena itu, promosi kesehatan reproduksi perlu memuat pesan gizi seimbang, konsumsi sumber zat besi, kepatuhan tablet tambah darah sesuai program, serta pemeriksaan bila terdapat tanda anemia.

Kanker serviks juga memperlihatkan pentingnya pendekatan promotif dan preventif. Edukasi mengenai HPV, vaksinasi, skrining, dan rujukan hasil abnormal perlu disampaikan dengan cara yang menenangkan. Banyak perempuan enggan melakukan pemeriksaan karena malu, takut, atau merasa tidak berisiko ketika belum ada gejala. Bidan perlu menjelaskan bahwa tujuan skrining adalah menemukan perubahan awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Penjelasan sederhana semacam ini dapat membantu mengurangi rasa takut dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam deteksi dini.

Dalam konteks pelayanan kebidanan, bidan memiliki posisi yang sangat strategis. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang dekat dengan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Kedekatan ini membuat bidan tidak hanya berperan

sebagai pemberi asuhan pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, tetapi juga sebagai pendidik kesehatan, konselor, advokat, fasilitator layanan, pelaksana deteksi dini, penggerak masyarakat, dan mitra perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksinya. Banyak perempuan lebih mudah mengakses dan mempercayai bidan, terutama di pelayanan primer, praktik mandiri bidan, Posyandu, Puskesmas, kelas ibu, kegiatan calon pengantin, dan pelayanan berbasis komunitas.

Promosi kesehatan reproduksi oleh bidan perlu dipahami sebagai proses pemberdayaan. Promosi kesehatan tidak hanya bermakna menyampaikan informasi, tetapi juga membantu perempuan dan keluarga agar mampu mengambil keputusan sehat, mengubah perilaku berisiko, mengakses layanan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Dalam konteks kesehatan reproduksi, promosi kesehatan berarti membantu perempuan memahami tubuhnya, mengenali tanda bahaya, mencegah penyakit, merencanakan kehamilan secara sehat, memilih kontrasepsi sesuai kebutuhan, dan memperoleh layanan tanpa stigma.

Pelaksanaan promosi kesehatan reproduksi perlu memperhatikan faktor sosial dan budaya. Tidak semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi kesehatan reproduksi yang benar. Sebagian perempuan menghadapi rasa malu, tabu membicarakan organ reproduksi, mitos seputar menstruasi dan kontrasepsi, keterbatasan dukungan pasangan, rendahnya literasi kesehatan, keterbatasan ekonomi, atau jarak geografis menuju fasilitas kesehatan. Selain itu, arus informasi digital yang sangat cepat membuat perempuan mudah menerima informasi yang belum tentu benar. Dalam situasi ini, bidan perlu hadir sebagai sumber informasi yang tepercaya, ramah, komunikatif, dan berbasis bukti.

Di Indonesia, penyelenggaraan kesehatan reproduksi memiliki dasar hukum yang semakin kuat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi menjadi landasan penting bagi penguatan pelayanan kesehatan reproduksi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kesehatan reproduksi perlu diberikan secara komprehensif, terencana, berkesinambungan, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai peran bidan dalam promosi kesehatan reproduksi perempuan usia subur menjadi sangat relevan. Chapter ini membahas konsep kesehatan reproduksi perempuan usia subur, peran bidan, ruang lingkup materi promosi, strategi pelaksanaan, prinsip komunikasi, hambatan yang sering dihadapi, serta upaya penguatan peran bidan. Alur pembahasan disusun agar setiap subbab memiliki fungsi yang berbeda dan saling

melengkapi, sehingga materi tidak terasa berulang dan tetap mempertahankan kelengkapan substansi.

B. Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur merupakan dasar penting dalam pelayanan kebidanan. Subbab ini berfokus pada konsep, bukan pada teknik pelaksanaan promosi. Pemahaman konsep diperlukan agar bidan mampu melihat perempuan secara utuh, mengenali kebutuhan yang berubah sepanjang siklus kehidupan, dan menempatkan pelayanan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari hak kesehatan.

1. Hakikat Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur bersifat dinamis. Kebutuhan perempuan dapat berubah sesuai usia, status perkawinan, pengalaman menstruasi, aktivitas seksual, riwayat kehamilan, penggunaan kontrasepsi, riwayat penyakit, kondisi psikologis, dukungan pasangan, budaya, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Seorang remaja putri yang baru memahami siklus haid memiliki kebutuhan yang berbeda dengan calon pengantin, perempuan yang menunda kehamilan, ibu muda, atau perempuan yang mengalami infertilitas.

Hakikat kesehatan reproduksi juga terkait dengan kemampuan perempuan untuk memahami tubuhnya. Perempuan perlu mengetahui proses biologis yang normal, perubahan yang perlu diwaspadai, dan kapan harus mencari pertolongan tenaga kesehatan. Pengetahuan tersebut penting karena banyak masalah reproduksi pada tahap awal tidak selalu menimbulkan gejala berat. Bila perempuan tidak mengetahui tanda bahaya, pemeriksaan dapat terlambat dilakukan.

Kesehatan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari hak kesehatan. Hak tersebut mencakup hak memperoleh informasi yang benar, hak mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu, hak atas privasi dan kerahasiaan, hak mengambil keputusan secara sadar, serta hak terbebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pemaksaan. Dalam pelayanan kebidanan, hak ini tercermin dalam prinsip informed choice dan informed consent. Perempuan perlu memperoleh informasi yang cukup sebelum memilih tindakan, metode kontrasepsi, pemeriksaan, atau rujukan.

Bagi bidan, pemahaman hakikat ini penting agar pelayanan tidak hanya berpusat pada tindakan klinis. Bidan perlu melihat perempuan sebagai individu yang memiliki tubuh, pikiran, pengalaman, nilai, pilihan, dan kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, promosi kesehatan reproduksi harus dilakukan secara

empatik, menghargai martabat perempuan, tidak menghakimi, dan mendukung pengambilan keputusan yang sadar.

2. Dimensi Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur mencakup beberapa dimensi yang saling berkaitan. Dimensi-dimensi tersebut membantu bidan memahami bahwa keluhan reproduksi tidak selalu berdiri sendiri. Nyeri haid, keputihan, kecemasan menggunakan kontrasepsi, atau keterlambatan melakukan skrining dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan hak kesehatan.

Tabel 6. 1 Dimensi Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Dimensi	Makna	Implikasi bagi Bidan
Biologis	Berkaitan dengan struktur dan fungsi organ reproduksi, siklus menstruasi, ovulasi, kesuburan, kehamilan, kontrasepsi, serta risiko penyakit reproduksi.	Bidan perlu membantu perempuan mengenali kondisi normal dan tanda bahaya, seperti perdarahan berlebihan, nyeri haid berat, keputihan berbau, nyeri panggul, atau benjolan payudara.
Psikologis	Berkaitan dengan perasaan, kecemasan, citra tubuh, kesiapan mental, pengalaman kekerasan, tekanan untuk hamil, atau stres akibat infertilitas.	Bidan perlu menyediakan ruang konsultasi yang aman, mendengarkan aktif, memberi dukungan emosional dasar, dan merujuk bila ditemukan masalah psikologis yang memerlukan penanganan lanjut.
Sosial	Dipengaruhi oleh pasangan, keluarga, pekerjaan, pendidikan, ekonomi, transportasi, dan dukungan lingkungan.	Bidan perlu menilai hambatan sosial, melibatkan keluarga secara proporsional, serta membantu klien mengakses layanan yang sesuai.

Budaya	Berkaitan dengan nilai, adat, agama, tabu, dan mitos tentang menstruasi, seksualitas, kontrasepsi, atau pemeriksaan organ reproduksi.	Bidan perlu menyampaikan edukasi dengan bahasa yang sopan dan sensitif budaya, tetapi tetap meluruskan mitos yang membahayakan kesehatan.
Hak kesehatan	Menempatkan perempuan sebagai subjek yang berhak memperoleh informasi, pelayanan, privasi, keamanan, dan keputusan tanpa paksaan.	Bidan perlu menerapkan informed choice, informed consent, menjaga kerahasiaan, dan memastikan pelayanan bebas diskriminasi.

3. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Ruang lingkup kesehatan reproduksi perempuan usia subur sangat luas. Pada bagian ini, ruang lingkup dibahas sebagai dasar konseptual. Uraian praktis mengenai materi promosi yang dapat diberikan bidan disajikan lebih lanjut pada Subbab D agar tidak terjadi pengulangan pembahasan.

Pertama, kesehatan menstruasi. Menstruasi merupakan proses fisiologis yang dialami perempuan usia subur. Meskipun normal, menstruasi sering menimbulkan kecemasan karena kurangnya pengetahuan, mitos, rasa malu, atau pengalaman nyeri haid. Perempuan perlu memahami siklus haid, lama haid normal, jumlah perdarahan, perubahan emosi, kebersihan saat menstruasi, serta tanda yang memerlukan pemeriksaan.

Kedua, kebersihan organ reproduksi. Kebersihan area genital perlu dijaga dalam kehidupan sehari-hari dan pada saat menstruasi. Praktik kebersihan yang keliru, seperti membersihkan dari arah yang salah, menggunakan bahan iritan, jarang mengganti pembalut, atau memakai pakaian dalam yang tidak menyerap keringat dapat meningkatkan risiko iritasi dan infeksi. Bidan perlu menekankan bahwa menjaga kebersihan organ reproduksi bukan karena organ tersebut kotor, tetapi karena area tersebut sensitif dan memerlukan perawatan yang tepat.

Ketiga, pemenuhan gizi dan pencegahan anemia. Gizi merupakan fondasi kesehatan reproduksi. Perempuan usia subur membutuhkan asupan zat gizi yang cukup untuk mendukung fungsi hormonal, menjaga daya tahan tubuh, mempertahankan status energi, mempersiapkan kehamilan sehat, dan mencegah

komplikasi. Anemia pada remaja putri dan perempuan usia subur perlu dicegah karena dapat berdampak pada produktivitas, kesiapan kehamilan, kesehatan ibu, dan pertumbuhan janin bila perempuan kemudian hamil.

Keempat, kesehatan pranikah dan prakonsepsi. Pemeriksaan pranikah bertujuan mengenali kondisi kesehatan calon pasangan, mendeteksi risiko penyakit menular atau penyakit keturunan, dan mempersiapkan keluarga sehat. Pelayanan prakonsepsi memiliki cakupan yang lebih luas karena bertujuan memastikan perempuan berada dalam kondisi optimal sebelum hamil. Kehamilan sehat tidak dimulai ketika hasil test pack positif, tetapi sejak sebelum pembuahan.

Kelima, perencanaan kehamilan dan kontrasepsi. Tidak semua perempuan usia subur ingin segera hamil. Sebagian ingin menunda kehamilan karena pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, kesehatan, atau kesiapan psikologis. Sebagian lainnya ingin mengatur jarak kelahiran agar ibu dan anak tetap sehat. Kontrasepsi dan keluarga berencana membantu perempuan dan pasangan mengambil keputusan yang terinformasi tentang jumlah anak dan jarak kehamilan.

Keenam, pencegahan infeksi menular seksual dan HIV. Infeksi menular seksual dapat berdampak pada kesehatan reproduksi, kesuburan, kehamilan, dan kesehatan bayi. Sebagian infeksi tidak selalu menimbulkan gejala jelas, sehingga edukasi, pemeriksaan, dan pengobatan yang tepat sangat penting. Informasi tentang IMS harus disampaikan secara rahasia dan tidak menghakimi agar perempuan tidak takut mencari pertolongan.

Ketujuh, deteksi dini penyakit reproduksi. Penyakit reproduksi dapat berupa infeksi, gangguan hormonal, gangguan menstruasi, mioma, kista, endometriosis, gangguan kesuburan, hingga kanker organ reproduksi. Kanker serviks menjadi salah satu perhatian besar karena dapat dicegah dan dideteksi lebih awal melalui edukasi HPV, vaksinasi, skrining, dan rujukan tepat waktu. Deteksi dini bertujuan menemukan masalah sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat.

Kedelapan, kesehatan seksual, relasi sehat, dan perlindungan dari kekerasan. Kesehatan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari relasi yang aman dan setara. Kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual, perkawinan anak, dan relasi yang tidak seimbang dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan reproduksi perempuan. Bidan perlu peka terhadap tanda kekerasan dan mampu memberikan dukungan awal serta rujukan yang aman.

Kesembilan, kesuburan dan infertilitas. Sebagian perempuan ingin menunda kehamilan, tetapi sebagian lain mengalami kesulitan hamil. Infertilitas dapat menimbulkan tekanan psikologis, konflik pasangan, stigma keluarga, dan rasa bersalah pada perempuan. Bidan dapat memberikan edukasi dasar tentang masa

subur, pola hidup sehat, pentingnya pemeriksaan pasangan, serta waktu yang tepat untuk berkonsultasi ke fasilitas kesehatan.

Tabel 6. 2 Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Aspek	Kebutuhan Utama	Masalah yang Sering Muncul	Arah Promosi oleh Bidan
Menstruasi	Memahami siklus haid, kebersihan menstruasi, dan tanda bahaya.	Nyeri haid, perdarahan banyak, mitos menstruasi, malu bertanya.	Edukasi siklus normal, kebersihan diri, tanda bahaya, dan rujukan bila perlu.
Kebersihan organ reproduksi	Menjaga kebersihan area genital sehari-hari.	Keputihan, iritasi, infeksi, praktik kebersihan keliru.	Edukasi cara membersihkan organ reproduksi dan memilih pakaian dalam yang tepat.
Gizi dan anemia	Status gizi baik, cukup zat besi, bebas anemia.	Lelah, kurang konsentrasi, anemia, KEK, risiko kehamilan bermasalah.	Edukasi gizi, pemantauan tanda anemia, motivasi konsumsi tablet tambah darah, kolaborasi gizi.
Pranikah dan prakonsepsi	Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan sebelum hamil.	Penyakit tidak terdeteksi, kesiapan fisik dan mental kurang.	Konseling pranikah, edukasi prakonsepsi, fasilitasi pemeriksaan.
Perencanaan kehamilan	Menentukan waktu dan jarak kehamilan secara sehat.	Kehamilan tidak direncanakan, jarak kehamilan terlalu dekat.	Konseling kehamilan sehat, edukasi jarak kehamilan, pelayanan KB.
Kontrasepsi	Memilih metode sesuai kondisi dan kebutuhan.	Mitos kontrasepsi, efek samping, putus pakai.	Konseling objektif, informed choice, tindak lanjut.

IMS dan HIV	Informasi pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan.	Stigma, malu periksa, gejala tidak dikenali.	Edukasi rahasia, deteksi awal, konseling pasangan, rujukan.
Deteksi kanker serviks dan payudara	Akses skrining dan informasi pencegahan.	Takut, malu, tidak merasa berisiko, terlambat skrining.	Edukasi, motivasi skrining, fasilitasi layanan, rujukan hasil abnormal.
Relasi sehat dan perlindungan dari kekerasan	Hubungan aman, setara, dan bebas kekerasan.	Kekerasan, pemaksaan keputusan reproduksi, keterlambatan pertolongan.	Identifikasi awal, dukungan psikologis dasar, menjaga rahasia, rujukan aman.
Kesuburan	Informasi masa subur dan pemeriksaan infertilitas.	Stigma infertilitas, tekanan keluarga, pemeriksaan terlambat.	Edukasi kesuburan, konseling pasangan, rujukan bila diperlukan.

4. Implikasi Konsep Kesehatan Reproduksi bagi Praktik Bidan

Pemahaman konsep kesehatan reproduksi perempuan usia subur memiliki beberapa implikasi penting bagi praktik bidan. Pertama, bidan perlu memandang perempuan secara holistik. Keluhan reproduksi tidak boleh hanya dilihat sebagai gangguan fisik, tetapi juga dikaji dari aspek psikologis, hubungan pasangan, dukungan keluarga, pekerjaan, budaya, dan akses layanan.

Kedua, promosi kesehatan reproduksi harus dilakukan sepanjang siklus kehidupan. Edukasi tidak hanya diberikan saat perempuan hamil, tetapi juga sejak remaja, pranikah, masa menunda kehamilan, masa merencanakan kehamilan, masa antara kehamilan, hingga masa menjelang menopause. Pendekatan sepanjang siklus hidup membantu bidan menyesuaikan pesan kesehatan dengan kebutuhan aktual perempuan.

Ketiga, bidan perlu menggunakan komunikasi yang ramah perempuan. Banyak isu reproduksi bersifat sensitif, sehingga bidan harus menjaga privasi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak menakut-nakuti, tidak menyalahkan, dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk bertanya. Komunikasi yang baik meningkatkan kepercayaan dan mendorong perempuan mengakses layanan lebih dini.

Keempat, bidan perlu memperkuat kolaborasi. Tidak semua masalah kesehatan reproduksi dapat diselesaikan di tingkat pelayanan kebidanan dasar. Beberapa kondisi membutuhkan pemeriksaan dokter, laboratorium, psikolog, ahli gizi, petugas HIV/IMS, atau layanan perlindungan perempuan. Oleh karena itu, bidan perlu memahami jejaring rujukan dan bekerja sama dengan tenaga serta sektor lain.

Kelima, bidan perlu menjadi pelurus informasi. Di era digital, perempuan usia subur banyak memperoleh informasi dari media sosial. Sebagian informasi bermanfaat, tetapi sebagian lainnya keliru atau menyesatkan. Bidan perlu membantu perempuan memilah informasi, mengenali sumber yang dapat dipercaya, dan tidak mengambil keputusan kesehatan hanya berdasarkan cerita orang lain.

5. Contoh Aplikasi Konsep dalam Pelayanan Kebidanan

Sebagai ilustrasi, seorang perempuan usia 24 tahun datang ke praktik bidan dengan keluhan haid tidak teratur dan mudah lelah. Ia sedang merencanakan pernikahan dalam empat bulan ke depan. Dalam situasi ini, bidan tidak cukup hanya menanyakan keluhan haid, tetapi perlu melakukan pendekatan menyeluruh. Bidan dapat menggali riwayat menstruasi, pola makan, aktivitas fisik, riwayat anemia, berat badan, stres, penggunaan obat, riwayat penyakit, serta kesiapan pranikah.

Setelah pengkajian awal, bidan dapat memberikan edukasi tentang siklus haid, tanda bahaya gangguan menstruasi, pentingnya pemeriksaan hemoglobin bila dicurigai anemia, konsumsi makanan bergizi, tablet tambah darah sesuai anjuran, serta pentingnya pemeriksaan pranikah bersama pasangan. Jika ditemukan tanda risiko, bidan dapat merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa satu keluhan dapat berkaitan dengan aspek gizi, hormonal, psikologis, kesiapan pernikahan, dan perencanaan kehamilan.

6. Ringkasan Subbab

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Konsep ini mencakup kesehatan menstruasi, kebersihan organ reproduksi, gizi dan pencegahan anemia, kesehatan pranikah dan prakonsepsi, perencanaan kehamilan, kontrasepsi, pencegahan infeksi menular seksual, deteksi dini penyakit reproduksi, kesehatan seksual, perlindungan dari kekerasan, serta kesuburan. Bagi bidan, pemahaman konsep ini menjadi dasar untuk melakukan promosi kesehatan reproduksi yang komprehensif, berbasis hak, dan berpusat pada kebutuhan perempuan.

C. Peran Bidan dalam Promosi Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Setelah konsep kesehatan reproduksi dipahami, bagian ini membahas fungsi bidan dalam promosi kesehatan reproduksi. Fokus subbab ini bukan lagi menjelaskan ruang lingkup kesehatan reproduksi, melainkan menegaskan bagaimana bidan menjalankan peran profesionalnya agar perempuan usia subur mampu memperoleh informasi, mengambil keputusan, mengakses layanan, dan mendapatkan dukungan lingkungan.

Secara global, bidan diakui memiliki kontribusi penting dalam pelayanan kesehatan seksual, reproduksi, maternal, neonatal, dan remaja. International Confederation of Midwives menempatkan kesehatan seksual dan reproduksi, kontrasepsi, keluarga berencana, dan perawatan prakonsepsi sebagai bagian dari kompetensi penting bidan. Dalam konteks Indonesia, peran tersebut sejalan dengan arah penguatan pelayanan kesehatan reproduksi yang menekankan upaya promotif, preventif, pelayanan sesuai siklus hidup, partisipasi masyarakat, pencatatan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan.

1. Bidan sebagai Edukator

Sebagai edukator, bidan bertanggung jawab memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang benar, jelas, mudah dipahami, berbasis bukti, dan sesuai kebutuhan perempuan usia subur. Peran edukator penting karena banyak perempuan memperoleh informasi dari sumber yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan, seperti mitos keluarga, percakapan teman sebaya, media sosial, atau iklan yang tidak berbasis ilmiah.

Edukasi yang diberikan bidan tidak boleh bersifat menggurui atau sekadar menyampaikan pesan satu arah. Edukasi yang efektif dilakukan melalui komunikasi interaktif, diskusi, tanya jawab, penggunaan media visual, demonstrasi, simulasi, dan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bidan perlu menyesuaikan bahasa, media, dan metode edukasi dengan usia, tingkat pendidikan, budaya, nilai agama, status perkawinan, kondisi psikologis, dan pengalaman reproduksi klien.

Dalam menjalankan peran edukator, bidan juga perlu menjadi pelurus informasi yang keliru. Misalnya, sebagian perempuan masih percaya bahwa semua kontrasepsi menyebabkan infertilitas, pemeriksaan kanker serviks hanya perlu dilakukan bila ada keluhan, nyeri menstruasi berat selalu normal, atau keputihan tidak perlu diperiksa. Edukasi bidan harus membantu perempuan membedakan kondisi normal, kondisi yang perlu dipantau, dan kondisi yang membutuhkan rujukan.

Pada edukasi menstruasi, bidan dapat menjelaskan bahwa menstruasi adalah proses biologis normal, tetapi perlu dikelola dengan kebersihan yang baik. Pesan praktis yang dapat diberikan antara lain mengganti pembalut secara teratur, mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut, membersihkan area genital dengan arah yang benar, menggunakan pakaian dalam yang bersih dan menyerap keringat, serta berkonsultasi bila nyeri haid sangat berat, perdarahan sangat banyak, atau terjadi perdarahan di luar siklus.

Pada edukasi kontrasepsi, bidan perlu menjelaskan pilihan metode secara seimbang. Penjelasan tidak hanya berisi cara kerja dan efektivitas, tetapi juga manfaat, keterbatasan, efek samping yang mungkin muncul, tanda bahaya, jadwal kontrol, dan kemungkinan pergantian metode bila tidak sesuai. Konseling harus menghindari pemaksaan metode tertentu. Klien perlu memahami bahwa metode terbaik adalah metode yang aman secara medis, sesuai kebutuhan, dapat diterima oleh klien, dan memungkinkan tindak lanjut yang baik.

Pada edukasi pranikah dan prakonsepsi, bidan dapat menekankan bahwa persiapan pernikahan tidak hanya menyangkut acara, ekonomi, atau kesiapan sosial, tetapi juga kesiapan kesehatan. Pemeriksaan pranikah dan prakonsepsi membantu calon pasangan mengetahui kondisi kesehatan, riwayat penyakit, risiko penyakit menular, status gizi, anemia, imunisasi, serta kesiapan fisik dan mental sebelum kehamilan terjadi.

Agar edukasi menarik, bidan dapat menggunakan kartu mitos dan fakta, poster siklus menstruasi, lembar balik kontrasepsi, model anatomi organ reproduksi, video edukasi singkat, kuis interaktif, buku saku calon pengantin, dan pesan edukatif melalui media digital. Edukasi juga dapat dikembangkan dalam bentuk kelas perempuan usia subur, kelas calon pengantin, kelas prakonsepsi, kelas pasangan usia subur, penyuluhan di Posyandu, atau kunjungan rumah.

Tabel 6. 3 Contoh Pesan Edukasi yang Dapat Disampaikan Bidan

Tema	Pesan Kunci	Tujuan
Menstruasi sehat	Menstruasi adalah proses normal, tetapi kebersihan diri harus dijaga dan nyeri berat perlu dikonsultasikan.	Meningkatkan pemahaman dan mencegah keterlambatan mencari pertolongan.
Kebersihan organ reproduksi	Bersihkan organ intim dengan benar, gunakan pakaian dalam yang	Mencegah infeksi dan meningkatkan perilaku hidup bersih.

	menyerap keringat, dan hindari praktik yang dapat menyebabkan iritasi.	
Anemia	Perempuan perlu mengenali tanda anemia dan memahami pentingnya asupan zat besi serta tablet tambah darah sesuai anjuran.	Mencegah anemia pada remaja putri dan perempuan usia subur.
Kontrasepsi	Setiap metode memiliki manfaat, efek samping, dan kesesuaian yang berbeda; pemilihan harus berdasarkan kebutuhan dan kondisi kesehatan.	Mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Prakonsepsi	Kehamilan sehat perlu dipersiapkan sebelum hamil melalui gizi, pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan pengendalian penyakit.	Mengurangi risiko komplikasi pada ibu dan bayi.
Deteksi kanker serviks	Skrining penting dilakukan meskipun belum ada gejala.	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam deteksi dini.

2. Bidan sebagai Konselor

Konseling merupakan inti dari promosi kesehatan reproduksi karena banyak keputusan reproduksi bersifat personal dan sensitif. Berbeda dengan penyuluhan yang umumnya ditujukan kepada kelompok, konseling lebih bersifat individual, personal, dan berpusat pada kebutuhan klien. Dalam konseling, bidan tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membantu perempuan memahami masalahnya, mengenali pilihan, menimbang manfaat dan risiko, mengidentifikasi hambatan, serta mengambil keputusan sesuai kondisi kesehatan, nilai pribadi, rencana hidup, dan dukungan sosialnya.

Konseling kesehatan reproduksi harus dilakukan dengan prinsip kerahasiaan, penghargaan terhadap otonomi, persetujuan berdasarkan informasi, tidak menghakimi, tidak memaksa, dan menghargai pilihan perempuan. Pada

perempuan yang ingin menunda kehamilan, konseling berfokus pada pemilihan kontrasepsi yang sesuai. Bidan perlu menggali usia, status menyusui, jumlah anak, rencana kehamilan berikutnya, riwayat penyakit, pengalaman menggunakan kontrasepsi, efek samping yang dikhawatirkan, dukungan pasangan, dan akses untuk kontrol ulang.

Pada perempuan yang merencanakan kehamilan, konseling prakonsepsi mencakup status gizi, riwayat anemia, penyakit kronis, penggunaan obat, imunisasi, paparan asap rokok, kesehatan mental, kesiapan pasangan, dan jarak kehamilan. Pada perempuan dengan keluhan sensitif, seperti gangguan menstruasi, keputihan, nyeri saat berhubungan seksual, infertilitas, dugaan IMS, atau pengalaman kekerasan, konseling harus dilakukan dengan kehati-hatian. Bidan perlu memberi ruang aman agar klien dapat bercerita tanpa takut disalahkan.

Konseling dapat melibatkan pasangan atau keluarga bila diperlukan, tetapi tetap harus menjaga hak dan privasi perempuan. Pelibatan pasangan bermanfaat pada penggunaan kontrasepsi, pemeriksaan pranikah, pengobatan IMS, dan persiapan kehamilan. Namun, keterlibatan pasangan tidak boleh menghilangkan hak perempuan untuk mengambil keputusan atas tubuh dan kesehatannya.

3. Bidan sebagai Fasilitator Akses Layanan

Bidan berperan sebagai fasilitator yang membantu perempuan usia subur memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang tepat, aman, dan sesuai kebutuhan. Peran ini penting karena banyak perempuan membutuhkan layanan, tetapi tidak mengetahui harus datang ke mana, pemeriksaan apa yang perlu dilakukan, berapa biaya yang diperlukan, kapan jadwal pelayanan tersedia, atau bagaimana alur rujukan.

Fasilitasi akses tidak hanya berarti mengarahkan klien ke fasilitas kesehatan. Bidan juga membantu mengurangi hambatan yang membuat perempuan sulit menggunakan layanan, seperti keterbatasan biaya, jarak, waktu, rasa malu, takut diperiksa, kurang dukungan pasangan, stigma masyarakat, pengalaman buruk di fasilitas kesehatan, atau kurangnya informasi tentang manfaat layanan.

Dalam praktik sehari-hari, bidan dapat memfasilitasi akses melalui pemberian informasi tentang jadwal pelayanan Puskesmas, praktik mandiri bidan, layanan KB, layanan skrining kanker serviks, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan pranikah, pelayanan IMS, layanan psikologi, layanan gizi, serta layanan perlindungan perempuan dan anak. Bidan juga dapat membantu menyiapkan rujukan, menjelaskan alasan rujukan, memastikan klien memahami prosedur, dan melakukan tindak lanjut setelah klien dirujuk.

4. Bidan sebagai Advokat Kesehatan Perempuan

Sebagai advokat, bidan berperan memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, terjangkau, ramah, dan bebas diskriminasi. Advokasi tidak selalu berarti berbicara dalam forum besar atau membuat kebijakan. Dalam pelayanan sehari-hari, advokasi dapat dilakukan dengan memastikan klien diperlakukan dengan hormat, mendapat penjelasan yang cukup, memiliki kesempatan bertanya, dan tidak dipaksa mengambil keputusan.

Advokasi penting karena isu kesehatan reproduksi sering dipengaruhi relasi kuasa dalam keluarga dan masyarakat. Sebagian perempuan tidak bebas memilih kontrasepsi karena tekanan pasangan atau keluarga. Sebagian takut melakukan pemeriksaan organ reproduksi karena malu, khawatir dianggap buruk, atau takut informasi pribadinya tersebar. Ada pula perempuan yang menunda mencari pertolongan karena keluhan reproduksi dianggap tabu. Dalam situasi tersebut, bidan perlu menjadi figur yang aman, dipercaya, dan berpihak pada kesehatan serta martabat perempuan.

Advokasi dapat dilakukan pada tingkat individu, keluarga, komunitas, dan institusi. Pada tingkat individu, bidan membantu perempuan memahami haknya atas informasi, persetujuan tindakan, kerahasiaan, dan pilihan pelayanan. Pada tingkat keluarga, bidan mengedukasi pasangan atau anggota keluarga agar mendukung kesehatan reproduksi perempuan. Pada tingkat komunitas, bidan melibatkan kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, guru, dan organisasi perempuan untuk mengurangi stigma. Pada tingkat institusi, bidan mendorong adanya ruang konseling yang menjaga privasi, media edukasi yang mudah dipahami, jadwal pelayanan yang mudah diakses, dan alur rujukan yang jelas.

5. Bidan sebagai Pelaksana Deteksi Dini dan Pencegahan

Promosi kesehatan reproduksi harus terintegrasi dengan deteksi dini dan pencegahan. Edukasi yang baik akan lebih bermakna bila diikuti kemampuan bidan mengenali faktor risiko, menemukan tanda awal masalah, melakukan pemeriksaan dasar sesuai kewenangan, dan merujuk klien secara tepat waktu. Dengan demikian, bidan tidak hanya menunggu perempuan datang saat sakit, tetapi aktif membantu perempuan mengenali risiko sejak awal.

Deteksi dini dapat dilakukan melalui anamnesis, observasi, pemeriksaan dasar, pengukuran tekanan darah, pengukuran berat badan dan tinggi badan, penilaian status gizi, penapisan riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, riwayat kontrasepsi, riwayat penyakit kronis, riwayat penggunaan obat, riwayat infeksi, riwayat kekerasan, serta penilaian kebutuhan psikososial. Pada kondisi tertentu,

bidan dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan atau merujuk klien ke tenaga kesehatan lain.

Masalah yang perlu diperhatikan antara lain anemia, kurang energi kronis, gangguan menstruasi, hipertensi, infeksi menular seksual, risiko kehamilan tidak direncanakan, infertilitas, kanker serviks, kanker payudara, kekerasan berbasis gender, dan masalah kesehatan mental. Pencegahan dilakukan melalui edukasi, imunisasi sesuai program, kontrasepsi, gizi seimbang, aktivitas fisik, perilaku seksual aman, kebersihan organ reproduksi, skrining, dan rujukan tepat waktu.

Alur sederhana deteksi dini dan pencegahan oleh bidan mencakup: menggali keluhan dan riwayat kesehatan reproduksi; menilai faktor risiko berdasarkan usia, riwayat menstruasi, kehamilan, kontrasepsi, penyakit, perilaku, dan dukungan sosial; melakukan pemeriksaan dasar sesuai kewenangan; memberikan edukasi dan konseling; menentukan kebutuhan rujukan; memberikan informasi tanda bahaya dan jadwal tindak lanjut; serta mencatat hasil pelayanan.

6. Bidan sebagai Kolaborator

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur tidak dapat ditangani oleh bidan seorang diri. Masalah kesehatan reproduksi sering berkaitan dengan faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, bidan perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik lintas profesi maupun lintas sektor.

Kolaborasi lintas profesi dapat dilakukan dengan dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, analis laboratorium, apoteker, petugas promosi kesehatan, petugas KB, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan agar pelayanan yang diberikan kepada perempuan lebih komprehensif. Misalnya, perempuan dengan anemia membutuhkan edukasi bidan, pemeriksaan laboratorium, intervensi gizi, tablet tambah darah, pemantauan kepatuhan, dan dukungan keluarga.

Kolaborasi lintas sektor dapat dilakukan dengan kader Posyandu, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi perempuan, perangkat desa, tempat kerja, dan lembaga perlindungan perempuan. Kolaborasi ini penting karena promosi kesehatan reproduksi tidak cukup dilakukan di ruang pelayanan. Banyak perilaku kesehatan dipengaruhi oleh norma sosial, dukungan keluarga, akses ekonomi, pendidikan, dan lingkungan tempat perempuan tinggal.

Tabel 6. 4 Contoh Kolaborasi dalam Promosi Kesehatan Reproduksi

Masalah/Kebutuhan	Mitra Kolaborasi	Bentuk Kolaborasi
Anemia pada perempuan usia subur	Ahli gizi, laboratorium, kader, keluarga	Edukasi gizi, pemeriksaan Hb, pemberian tablet tambah darah, pemantauan konsumsi.
Pemeriksaan pranikah	Dokter, laboratorium, petugas KUA, konselor	Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penyakit menular, edukasi pasangan.
Kontrasepsi	Dokter, petugas KB, apoteker	Konseling metode, pelayanan kontrasepsi, pemantauan efek samping.
Skrining kanker serviks	Puskesmas, dokter, laboratorium, kader	Edukasi, mobilisasi sasaran, skrining, rujukan hasil abnormal.
Kekerasan terhadap perempuan	Psikolog, pekerja sosial, unit perlindungan perempuan dan anak	Dukungan awal, rujukan aman, pendampingan psikososial.
Edukasi remaja dan calon pengantin	Guru, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama	Kelas edukasi, kampanye kesehatan reproduksi, diskusi kelompok.

7. Bidan sebagai Penggerak Pemberdayaan Masyarakat

Promosi kesehatan reproduksi akan lebih berhasil bila masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dilibatkan sebagai pelaku perubahan. Dalam hal ini, bidan berperan sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan, keluarga, dan komunitas untuk mengenali masalah kesehatan reproduksi, mengambil keputusan sehat, menggunakan layanan yang tersedia, serta membangun lingkungan yang mendukung kesehatan perempuan.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kelas perempuan usia subur, kelas calon pengantin, kelas pasangan usia subur, diskusi kelompok remaja putri, Posyandu remaja, Posyandu keluarga, kunjungan rumah, kampanye kesehatan reproduksi, edukasi sekolah, edukasi di tempat kerja, dan pemanfaatan media sosial. Dalam kegiatan pemberdayaan, perempuan diberi ruang untuk

bertanya, menyampaikan pengalaman, mengungkapkan hambatan, dan mencari solusi bersama.

Kader kesehatan dapat menjadi mitra utama bidan dalam pemberdayaan masyarakat. Bidan dapat melatih kader untuk menyampaikan pesan dasar kesehatan reproduksi, mengenali tanda bahaya, mengajak perempuan mengikuti skrining, mengingatkan konsumsi tablet tambah darah, dan menghubungkan masyarakat dengan layanan kesehatan. Namun, kader tetap perlu memahami batas perannya agar tidak memberikan diagnosis atau terapi di luar kewenangan.

Tabel 6. 5 Sintesis Peran Bidan dalam Promosi Kesehatan Reproduksi

Peran Bidan	Fokus Utama	Contoh Kegiatan	Dampak yang Diharapkan
Edukator	Meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan.	Penyuluhan menstruasi sehat, edukasi kontrasepsi, kelas prakonsepsi.	Perempuan memahami tubuh dan kebutuhan kesehatannya.
Konselor	Membantu pengambilan keputusan individual.	Konseling KB, konseling pranikah, konseling prakonsepsi.	Klien mampu memilih tindakan sesuai kebutuhan dan kondisi.
Fasilitator	Membuka akses layanan.	Informasi jadwal layanan, rujukan, pendampingan akses skrining.	Perempuan lebih mudah memperoleh pelayanan.
Advokat	Membela hak perempuan atas layanan aman dan bermartabat.	Menjaga informed consent, melawan stigma, melibatkan keluarga secara tepat.	Layanan lebih ramah perempuan dan bebas diskriminasi.
Pelaksana deteksi dini	Mengenali risiko dan mencegah komplikasi.	Penapisan anemia, gangguan menstruasi, risiko IMS, kanker serviks.	Masalah ditemukan lebih awal dan ditangani lebih cepat.

Kolaborator	Menghubungkan berbagai profesi dan sektor.	Kerja sama dengan dokter, ahli gizi, psikolog, kader, guru.	Pelayanan menjadi lebih komprehensif.
Penggerak masyarakat	Membangun partisipasi dan norma sehat.	Kelas WUS, Posyandu, kampanye, pelatihan kader.	Masyarakat aktif mendukung kesehatan reproduksi perempuan.

D. Ruang Lingkup Materi Promosi Kesehatan Reproduksi oleh Bidan

Subbab ini menyajikan ruang lingkup materi promosi dalam bentuk praktis agar tidak mengulang pembahasan konseptual pada Subbab B atau uraian peran bidan pada Subbab C. Fokusnya adalah menjawab pertanyaan: materi apa yang perlu disampaikan bidan, kepada siapa, dengan pesan kunci apa, dan tindak lanjut apa yang perlu disiapkan.

1. Prinsip Penyusunan Materi Promosi

Materi promosi kesehatan reproduksi perlu disusun secara terencana, sistematis, dan sesuai kebutuhan sasaran. Materi tidak cukup disampaikan sebagai informasi umum, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif, memperkuat keterampilan mengambil keputusan, dan mendorong perempuan mengakses pelayanan kesehatan secara tepat waktu.

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, materi harus berbasis bukti dan sesuai pedoman yang berlaku. Kedua, materi harus menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak menimbulkan rasa takut. Ketiga, materi harus berpusat pada kebutuhan perempuan dan menghormati pilihan klien. Keempat, materi perlu mempertimbangkan budaya, agama, usia, status perkawinan, pendidikan, dan pengalaman reproduksi. Kelima, setiap materi sebaiknya diakhiri dengan pesan tindakan, misalnya kapan harus Periksa, ke mana harus mencari layanan, atau apa yang perlu dilakukan di rumah.

Materi juga perlu dipilah berdasarkan sasaran. Edukasi untuk remaja putri lebih menekankan pubertas, menstruasi, anemia, kebersihan diri, dan perlindungan dari kekerasan. Edukasi untuk calon pengantin menekankan pemeriksaan pranikah, kesiapan fisik dan mental, prakonsepsi, serta komunikasi pasangan. Edukasi untuk pasangan usia subur menekankan kontrasepsi, perencanaan kehamilan, deteksi dini penyakit reproduksi, dan relasi sehat.

Edukasi untuk ibu pascapersalinan menekankan pemulihan reproduksi, KB pascapersalinan, menyusui, kesehatan mental, dan jarak kehamilan.

2. Paket Materi Inti Promosi Kesehatan Reproduksi

Tabel 6. 6 Paket Materi Inti Promosi Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Topik Materi	Tujuan Edukasi	Pesan Kunci	Tindak Lanjut
Pengenalan organ reproduksi dan siklus menstruasi	Membantu perempuan memahami proses biologis tubuhnya.	Siklus haid dapat bervariasi, tetapi perdarahan sangat banyak, nyeri berat, atau perdarahan di luar siklus perlu dikonsultasikan.	Anamnesis siklus haid, edukasi tanda bahaya, rujukan bila keluhan berat atau berulang.
Kebersihan organ reproduksi	Meningkatkan perilaku menjaga kebersihan area genital dan mencegah iritasi/infeksi.	Bersihkan area genital dengan benar, ganti pembalut secara teratur, gunakan pakaian dalam bersih dan menyerap keringat.	Evaluasi praktik kebersihan, koreksi kebiasaan keliru, rujuk bila ada gejala infeksi.
Gizi dan anemia	Mencegah anemia dan mendukung kesiapan reproduksi.	Perempuan perlu asupan gizi seimbang, zat besi, protein, asam folat, dan tablet tambah darah sesuai program/anjuran.	Penapisan tanda anemia, pemantauan konsumsi TTD, kolaborasi dengan ahli gizi/laboratorium.
Pranikah dan prakonsepsi	Mempersiapkan kesehatan sebelum menikah dan sebelum hamil.	Kehamilan sehat dipersiapkan sebelum pembuahan melalui pemeriksaan	Fasilitasi pemeriksaan pranikah/prakonsepsi, konseling pasangan, rujukan bila ditemukan risiko.

		kesehatan, status gizi baik, imunisasi, dan pengendalian penyakit.	
Perencanaan kehamilan	Membantu perempuan dan pasangan menentukan waktu dan jarak kehamilan yang sehat.	Kehamilan yang direncanakan lebih memungkinkan ibu dan bayi memperoleh persiapan kesehatan yang baik.	Konseling rencana kehamilan, penilaian faktor risiko, edukasi jarak kehamilan.
Kontrasepsi dan keluarga berencana	Membantu klien memilih metode yang sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatan.	Setiap metode memiliki manfaat, keterbatasan, efek samping, dan syarat penggunaan yang berbeda.	Konseling pilihan metode, informed choice, kontrol ulang, penanganan efek samping.
Pencegahan IMS dan HIV	Mencegah penularan dan keterlambatan pengobatan.	IMS dapat terjadi tanpa gejala jelas; pemeriksaan dan pengobatan pasangan penting bila ada indikasi.	Konseling rahasia, penapisan gejala, rujukan pemeriksaan/pengobatan.
Deteksi dini kanker serviks dan payudara	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi skrining.	Skrining dapat dilakukan meskipun belum ada gejala; deteksi dini membantu mencegah keterlambatan penanganan.	Informasi jadwal skrining, edukasi prosedur, rujukan bila hasil abnormal.

Kesehatan mental reproduksi	Mengenali dampak psikologis dari masalah reproduksi.	Cemas, takut, atau sedih terkait masalah reproduksi perlu didengarkan dan tidak dianggap remeh.	Dukungan emosional dasar, pemantauan, rujukan psikolog/layanan terkait bila perlu.
Relasi sehat dan perlindungan dari kekerasan	Meningkatkan kesadaran tentang hak, keselamatan, dan dukungan layanan.	Tidak ada perempuan yang pantas mengalami kekerasan; keselamatan dan kerahasiaan klien harus diutamakan.	Identifikasi tanda kekerasan, dukungan awal, rujukan aman.
Kesuburan dan infertilitas	Memberi pemahaman bahwa masalah kesuburan perlu dikaji pada kedua pasangan.	Infertilitas bukan semata-mata masalah perempuan; pemeriksaan perlu melibatkan pasangan.	Edukasi masa subur, pola hidup sehat, rujukan pemeriksaan pasangan.

3. Contoh Pengemasan Materi agar Menarik

Agar materi tidak terasa kaku, bidan dapat mengemas promosi kesehatan reproduksi dengan metode kreatif. Materi menstruasi dapat menggunakan kalender siklus haid atau kartu tanda bahaya. Materi anemia dapat menggunakan piring gizi seimbang dan contoh menu lokal. Materi kontrasepsi dapat menggunakan lembar balik pilihan metode dan kartu mitos-fakta. Materi skrining kanker serviks dapat menggunakan alur sederhana "apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana". Materi kekerasan dapat disampaikan melalui pesan keselamatan dan daftar layanan bantuan tanpa memaksa klien membuka cerita di depan umum.

Pengemasan materi juga dapat disesuaikan dengan tempat. Di Posyandu, materi sebaiknya singkat dan disertai contoh tindakan praktis. Di kelas calon pengantin, materi dapat berbentuk diskusi pasangan. Di sekolah atau kampus, materi dapat menggunakan kuis interaktif dan pertanyaan anonim. Di media

digital, materi sebaiknya berupa infografik singkat, video pendek, atau pesan pengingat yang tetap menekankan bahwa keluhan tertentu memerlukan pemeriksaan langsung.

4. Penyesuaian Materi Berdasarkan Sasaran

Tabel 6. 7 Penyesuaian Materi Berdasarkan Kelompok Sasaran

Sasaran	Kebutuhan Utama	Materi Prioritas	Metode yang Disarankan
Remaja putri akhir	Memahami pubertas, menstruasi, anemia, kebersihan diri, dan perlindungan diri.	Menstruasi sehat, tablet tambah darah, kebersihan organ reproduksi, pencegahan kekerasan.	Diskusi kelompok, kuis, kartu mitos-fakta, pertanyaan anonim.
Calon pengantin	Mempersiapkan kesehatan sebelum menikah dan sebelum hamil.	Pemeriksaan pranikah, prakonsepsi, gizi, imunisasi, komunikasi pasangan.	Kelas calon pengantin, konseling pasangan, lembar rencana kesehatan.
Pasangan usia subur	Merencanakan kehamilan dan memilih kontrasepsi sesuai kebutuhan.	KB, jarak kehamilan, tanda bahaya, deteksi kanker serviks, relasi sehat.	Konseling individual/pasangan, lembar balik kontrasepsi, rujukan skrining.
Ibu muda/pascapersalinan	Memulihkan kesehatan reproduksi dan mencegah kehamilan terlalu dekat.	KB pascapersalinan, pemulihan reproduksi, menyusui, kesehatan mental.	Kelas ibu, kunjungan rumah, konseling KB, pemantauan nifas.
Perempuan dengan keluhan reproduksi	Mendapat penjelasan,	Tanda bahaya, kebersihan, IMS,	Konseling rahasia, anamnesis,

	pemeriksaan awal, dan rujukan tepat.	gangguan haid, deteksi dini penyakit.	pemeriksaan dasar, rujukan.
--	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

5. Contoh Rancangan Kegiatan Edukasi

Agar materi promosi dapat digunakan langsung dalam pelayanan, bidan dapat menyusunnya dalam bentuk rancangan kegiatan edukasi. Rancangan ini membantu kegiatan lebih terarah, tidak melebar, dan tidak mengulang materi yang sama pada pertemuan berikutnya. Setiap rancangan perlu memuat tujuan, sasaran, pesan inti, metode, media, durasi, indikator keberhasilan, dan tindak lanjut.

6. Prinsip Tindak Lanjut setelah Edukasi

Tindak lanjut perlu direncanakan sejak awal karena promosi kesehatan yang baik tidak berhenti pada sesi edukasi. Setelah penyuluhan atau konseling, bidan dapat menyiapkan jadwal kontrol, membuka kesempatan konsultasi individual, menghubungkan peserta dengan layanan skrining, memantau konsumsi tablet tambah darah, atau mencatat peserta yang memerlukan rujukan. Dengan tindak lanjut yang jelas, edukasi berubah menjadi tindakan nyata.

Tindak lanjut juga dapat dilakukan melalui kader atau grup komunikasi yang terkelola dengan baik. Kader dapat membantu mengingatkan jadwal Posyandu, kegiatan skrining, atau konsumsi tablet tambah darah. Namun, informasi pribadi klien tidak boleh dibagikan dalam grup. Bila ada pertanyaan yang bersifat personal, bidan perlu mengarahkannya ke konsultasi individual agar privasi tetap terjaga.

E. Strategi Bidan dalam Melaksanakan Promosi Kesehatan Reproduksi

Subbab ini membahas cara bidan melaksanakan promosi kesehatan reproduksi. Jika Subbab D menjelaskan isi materi, maka Subbab E menjelaskan pendekatan pelaksanaan. Strategi yang baik membuat materi kesehatan reproduksi lebih mudah diterima, lebih sesuai dengan kebutuhan sasaran, dan lebih mungkin menghasilkan perubahan perilaku.

Strategi bidan dapat dilakukan melalui pendekatan individual, kelompok, keluarga, komunitas, dan media digital. Kelima pendekatan ini saling melengkapi. Pendekatan individual memberi ruang aman untuk masalah sensitif. Pendekatan kelompok memperluas jangkauan dan membangun dukungan sosial. Pendekatan keluarga memperkuat dukungan pasangan dan anggota keluarga. Pendekatan

komunitas membantu mengubah norma sosial. Media digital memperluas akses informasi dan memperkuat pesan edukasi.

1. Pendekatan Individual

Pendekatan individual dilakukan secara personal antara bidan dan klien. Pendekatan ini dapat berlangsung di ruang pelayanan kebidanan, Puskesmas, praktik mandiri bidan, kunjungan rumah, pelayanan kontrasepsi, pemeriksaan pranikah, konseling prakonsepsi, atau konsultasi terkait keluhan kesehatan reproduksi. Pendekatan individual sangat penting karena banyak masalah reproduksi bersifat pribadi, sensitif, dan sulit dibicarakan di depan orang lain.

Tujuan pendekatan individual adalah mengidentifikasi kebutuhan, keluhan, risiko, dan harapan klien secara personal; memberikan informasi sesuai usia, kondisi kesehatan, pendidikan, budaya, dan kesiapan psikologis; membantu klien memahami pilihan yang tersedia; meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan; mendorong perubahan perilaku bertahap; mendeteksi dini masalah reproduksi; serta menentukan kebutuhan rujukan bila ditemukan kondisi di luar kewenangan bidan.

Dalam pendekatan individual, bidan perlu menjaga privasi dan kerahasiaan, menggunakan bahasa sederhana, tidak menakut-nakuti klien, menghormati keputusan klien, dan memastikan pemahaman melalui teknik umpan balik. Misalnya, setelah menjelaskan tanda bahaya menstruasi, bidan dapat bertanya, "Boleh Ibu jelaskan kembali kapan Ibu perlu datang untuk periksa?" Teknik ini membantu memastikan bahwa informasi benar-benar dipahami.

Tabel 6. 8 Tahapan Pendekatan Individual dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Tahap	Kegiatan Bidan	Contoh Penerapan
Membangun hubungan awal	Menyapa klien, memperkenalkan diri, menciptakan suasana nyaman.	"Ibu dapat bercerita dengan tenang, informasi yang Ibu sampaikan akan kami jaga kerahasiaannya."
Menggali kebutuhan	Menanyakan keluhan, riwayat menstruasi, kehamilan, kontrasepsi, penyakit, dan kebutuhan informasi.	Menanyakan alasan klien ingin mengganti metode kontrasepsi.
Mengidentifikasi risiko	Menilai tanda bahaya, faktor risiko anemia, IMS,	Mengidentifikasi perdarahan di luar siklus

	kehamilan tidak direncanakan, atau gangguan reproduksi.	haid atau nyeri panggul berat.
Memberikan edukasi	Menjelaskan kondisi, pilihan layanan, pencegahan, dan tindak lanjut.	Edukasi kebersihan menstruasi, konsumsi TTD, atau skrining kanker serviks.
Mendukung keputusan	Membantu klien menimbang manfaat dan risiko pilihan.	Membandingkan beberapa metode kontrasepsi sesuai kebutuhan klien.
Menyusun tindak lanjut	Menentukan jadwal kontrol, pemeriksaan, atau rujukan.	Menjadwalkan kunjungan ulang setelah pelayanan kontrasepsi.
Dokumentasi	Mencatat hasil konseling, tindakan, edukasi, dan rencana lanjut.	Mencatat keluhan, edukasi yang diberikan, dan keputusan klien.

2. Pendekatan Kelompok

Pendekatan kelompok dilakukan kepada beberapa orang dalam satu kegiatan edukatif. Sasaran dapat berupa perempuan usia subur, calon pengantin, pasangan usia subur, kelompok remaja putri, ibu muda, pekerja perempuan, kader kesehatan, atau peserta Posyandu. Pendekatan kelompok bermanfaat karena peserta dapat belajar bersama, saling berbagi pengalaman, dan membangun dukungan sosial.

Pendekatan kelompok juga dapat mengurangi rasa malu. Perempuan yang awalnya enggan bertanya tentang nyeri haid, anemia, keputihan, kontrasepsi, atau skrining kanker serviks dapat merasa lebih berani ketika mengetahui bahwa masalah serupa juga dialami peserta lain. Namun, bidan tetap perlu menjaga batas privasi. Topik yang sangat personal sebaiknya diarahkan ke konseling individual.

Metode kelompok yang menarik meliputi diskusi interaktif, permainan mitos atau fakta, studi kasus, demonstrasi, kuis singkat, dan curah pendapat anonim. Diskusi interaktif dapat dimulai dengan pertanyaan pemantik, seperti "Apa mitos kontrasepsi yang sering Ibu dengar?" atau "Apa yang biasanya dilakukan saat nyeri haid?" Permainan mitos-fakta dapat membantu meluruskan informasi keliru tanpa membuat peserta merasa disalahkan.

Tabel 6. 9 Bentuk Kegiatan Edukasi Kelompok

Bentuk Kegiatan	Sasaran	Materi yang Sesuai	Catatan Pelaksanaan
Kelas perempuan usia subur	Perempuan usia reproduktif	Menstruasi sehat, anemia, kontrasepsi, skrining kanker serviks.	Gunakan pre-test/post-test singkat dan sesi tanya jawab anonim.
Kelas calon pengantin	Calon pengantin perempuan dan pasangan	Pemeriksaan pranikah, prakonsepsi, perencanaan kehamilan.	Libatkan pasangan tanpa mengurangi privasi perempuan.
Kelas ibu muda	Ibu pascapersalinan atau ibu dengan anak kecil	KB pascapersalinan, pemulihan reproduksi, kesehatan mental.	Sediakan waktu konseling individual setelah kelas.
Kelompok remaja putri	Remaja putri dan mahasiswi	Pubertas, menstruasi, anemia, perlindungan diri.	Gunakan bahasa ramah remaja dan media visual.
Kegiatan desa/Posyandu	Perempuan dan keluarga	Gizi, KB, deteksi dini, rujukan.	Kolaborasi dengan kader untuk tindak lanjut.
Edukasi tempat kerja	Pekerja perempuan	Anemia, menstruasi, kesehatan kerja dan reproduksi.	Sesuaikan waktu dengan jadwal kerja.

3. Pendekatan Keluarga

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur sering dipengaruhi oleh dukungan pasangan dan keluarga. Keputusan menggunakan kontrasepsi, merencanakan kehamilan, melakukan pemeriksaan pranikah, mengikuti skrining kanker serviks, mengonsumsi tablet tambah darah, atau mencari pertolongan saat ada keluhan dapat dipengaruhi oleh suami, orang tua, mertua, atau anggota keluarga lain.

Pendekatan keluarga bertujuan meningkatkan dukungan pasangan dan keluarga terhadap kesehatan reproduksi perempuan, membangun komunikasi yang sehat dalam pengambilan keputusan, mengurangi hambatan keluarga terhadap penggunaan layanan, mendorong pembagian tanggung jawab antara perempuan dan pasangan, serta mencegah keterlambatan pengambilan keputusan ketika muncul tanda bahaya.

Pelibatan keluarga dapat dilakukan melalui konseling pasangan, edukasi keluarga saat kunjungan rumah, keterlibatan keluarga dalam kelas edukasi, dan pendampingan pengambilan keputusan. Namun, pelibatan keluarga harus dilakukan secara proporsional. Bidan perlu meminta persetujuan klien sebelum membahas kondisi pribadinya dengan keluarga. Informasi sensitif tidak boleh disampaikan tanpa izin klien. Bila terdapat tanda kekerasan, ancaman, atau kontrol berlebihan dari pasangan/keluarga, bidan harus mengutamakan keselamatan perempuan.

4. Pendekatan Komunitas

Pendekatan komunitas diperlukan karena banyak perilaku kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh norma sosial. Di beberapa masyarakat, membicarakan menstruasi, organ reproduksi, kontrasepsi, infertilitas, atau IMS masih dianggap tabu. Pendekatan komunitas bertujuan mengubah lingkungan sosial agar lebih mendukung perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksinya.

Bidan dapat bekerja sama dengan kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, organisasi perempuan, perangkat desa, dan kelompok remaja. Kegiatan komunitas dapat berupa kampanye kesehatan reproduksi, Posyandu remaja, kelas perempuan usia subur, diskusi desa, pelatihan kader, dan kegiatan skrining massal. Pelibatan tokoh masyarakat dapat membantu pesan kesehatan lebih mudah diterima, terutama pada wilayah yang masih kuat dipengaruhi norma adat atau agama.

Pendekatan komunitas sebaiknya tidak hanya berupa ceramah. Kegiatan dapat dikembangkan menjadi diskusi masalah lokal, pemetaan hambatan akses layanan, pelatihan kader mengenali tanda bahaya, dan penyusunan jadwal rujukan atau skrining. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tetapi ikut menjadi bagian dari solusi.

5. Pemanfaatan Media Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara perempuan usia subur memperoleh informasi kesehatan. Banyak perempuan mencari informasi tentang menstruasi, kontrasepsi, kehamilan, kesuburan, keputihan, IMS, dan kanker serviks melalui internet atau media sosial. Kondisi ini menjadi peluang

sekaligus tantangan bagi bidan. Di satu sisi, media digital memperluas jangkauan promosi kesehatan. Di sisi lain, informasi keliru dapat menyebar cepat dan memengaruhi keputusan kesehatan.

Pemanfaatan media digital oleh bidan bertujuan memperluas akses informasi, menjangkau kelompok yang sulit hadir dalam kegiatan tatap muka, memperkuat pesan edukasi yang sudah diberikan secara langsung, mengingatkan jadwal pemeriksaan atau skrining, meluruskan informasi keliru, menyediakan ruang tanya jawab yang lebih fleksibel, dan meningkatkan literasi kesehatan digital perempuan usia subur.

Agar penggunaan media digital aman, bidan perlu memperhatikan beberapa prinsip. Informasi harus berbasis sumber tepercaya. Pesan harus singkat, jelas, dan tidak menakutkan. Edukasi digital tidak boleh menggantikan pemeriksaan langsung. Kerahasiaan klien harus dijaga. Bidan sebaiknya menghindari diagnosis terbuka di media sosial. Selain itu, media digital perlu tetap dilengkapi edukasi tatap muka karena tidak semua perempuan memiliki akses internet stabil, kuota, atau literasi digital yang memadai.

F. Prinsip Komunikasi Bidan dalam Promosi Kesehatan Reproduksi

Komunikasi merupakan inti dari promosi kesehatan reproduksi. Informasi yang benar dapat menjadi kurang efektif apabila disampaikan dengan bahasa yang terlalu teknis, nada yang menghakimi, tidak memperhatikan latar belakang sosial budaya, atau tidak memberi ruang bagi perempuan untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya. Subbab ini berfokus pada cara komunikasi, sehingga tidak mengulang daftar materi atau peran yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Komunikasi Berpusat pada Perempuan

Komunikasi berpusat pada perempuan berarti bidan menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam pelayanan, bukan sekadar penerima informasi. Bidan perlu memahami bahwa setiap perempuan memiliki pengalaman, kebutuhan, nilai, keyakinan, ketakutan, dan kondisi sosial yang berbeda. Karena itu, bidan tidak sebaiknya langsung memberi nasihat sebelum memahami situasi klien.

Komunikasi berpusat pada perempuan dapat dimulai dengan pertanyaan terbuka, seperti “Apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini?” atau “Apa yang paling Ibu khawatirkan terkait kesehatan reproduksi Ibu?” Pertanyaan semacam ini memberi ruang bagi klien untuk bercerita. Setelah itu, bidan merespons dengan mendengarkan aktif, tidak memotong pembicaraan, dan menunjukkan bahwa pengalaman klien dihargai.

2. Komunikasi Empatik dan Tidak Menghakimi

Empati berarti kemampuan bidan memahami perasaan klien dan menunjukkan kepedulian secara tulus. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi, empati sangat penting karena banyak perempuan datang dengan rasa malu, takut, bingung, atau merasa bersalah. Sikap menghakimi dapat membuat klien menutup diri dan enggan melanjutkan konsultasi.

Bidan perlu memilih kata yang mendukung. Kalimat "Kenapa baru periksa sekarang?" dapat membuat klien merasa disalahkan. Kalimat tersebut dapat diganti menjadi "Terima kasih Ibu sudah datang. Kita coba lihat bersama keluhannya agar bisa ditangani dengan tepat." Perubahan sederhana dalam pilihan kata dapat menciptakan suasana yang lebih aman.

Komunikasi yang tidak menghakimi bukan berarti membenarkan semua perilaku berisiko. Bidan tetap perlu menyampaikan risiko, tetapi dengan cara yang menghargai martabat klien. Tujuannya adalah membantu klien memahami pilihan yang lebih sehat tanpa merasa dipermalukan.

3. Menjaga Privasi dan Kerahasiaan

Privasi berarti bidan menyediakan ruang komunikasi yang tidak mudah didengar orang lain. Kerahasiaan berarti bidan tidak menyebarkan informasi klien kepada pihak yang tidak berwenang. Dalam praktik pelayanan, kerahasiaan perlu dijelaskan sejak awal, terutama ketika membahas topik sensitif. Misalnya, bidan dapat mengatakan, "Apa yang Ibu sampaikan di sini akan kami jaga kerahasiaannya sesuai ketentuan pelayanan kesehatan."

Menjaga kerahasiaan menjadi sangat penting pada kasus infeksi menular seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kehamilan tidak direncanakan, atau masalah relasi pasangan. Pada kasus seperti ini, pelanggaran kerahasiaan bukan hanya merusak kepercayaan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan klien.

4. Informasi Jelas, Benar, dan Berbasis Bukti

Bidan memiliki tanggung jawab memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak bersumber dari mitos, asumsi pribadi, atau pengalaman terbatas semata. Informasi kesehatan reproduksi harus disampaikan berdasarkan ilmu pengetahuan, pedoman pelayanan, dan kewenangan profesi. Kejelasan informasi penting karena tidak semua klien memiliki tingkat literasi kesehatan yang sama.

Bidan sebaiknya menghindari istilah medis yang sulit dipahami. Bila istilah medis perlu digunakan, bidan perlu menjelaskannya dengan bahasa sederhana. Misalnya, "ovulasi" dapat dijelaskan sebagai masa ketika sel telur keluar dari indung telur dan perempuan berada pada masa subur. "Infeksi menular seksual"

dapat dijelaskan sebagai infeksi yang dapat menular melalui hubungan seksual dan kadang tidak menimbulkan gejala pada awalnya.

Informasi juga perlu diberikan bertahap. Klien tidak selalu membutuhkan semua informasi sekaligus. Dalam konseling, informasi yang terlalu banyak dapat membuat klien bingung. Bidan perlu memilih informasi kunci sesuai kebutuhan klien, menanggapi kekhawatiran klien secara serius, dan memeriksa kembali pemahaman klien.

5. Sensitif terhadap Budaya, Nilai, dan Kondisi Sosial

Komunikasi bidan harus sensitif terhadap budaya dan nilai yang hidup di masyarakat. Kesehatan reproduksi sering berkaitan dengan norma keluarga, agama, adat, relasi gender, dan peran sosial perempuan. Karena itu, bidan perlu memahami konteks kehidupan klien tanpa langsung menilai.

Sensitif budaya tidak berarti membiarkan praktik yang membahayakan kesehatan. Bidan tetap perlu menyampaikan informasi yang benar dan melindungi hak kesehatan perempuan. Misalnya, bila ada mitos bahwa nyeri haid berat adalah hal biasa dan tidak perlu diperiksa, bidan dapat menghargai pengalaman klien sambil menjelaskan bahwa nyeri haid sangat berat, mengganggu aktivitas, atau disertai perdarahan berlebihan perlu diperiksa.

6. Menggunakan Teknik Teach-Back

Teach-back adalah teknik meminta klien menjelaskan kembali informasi dengan bahasanya sendiri. Teknik ini bukan untuk menguji klien, tetapi untuk memastikan bahwa penjelasan bidan sudah dipahami. Misalnya, setelah edukasi kontrasepsi, bidan dapat bertanya, "Agar saya yakin penjelasan saya jelas, boleh Ibu ceritakan kembali kapan Ibu perlu kontrol?"

Teknik ini membantu bidan mengetahui bagian yang belum dipahami klien. Jika klien belum mampu menjelaskan kembali, bidan dapat mengulang penjelasan dengan cara yang lebih sederhana. Teach-back sangat berguna untuk topik yang membutuhkan tindakan lanjutan, seperti minum tablet tambah darah, kontrol kontrasepsi, skrining kanker serviks, rujukan IMS, atau tanda bahaya gangguan reproduksi.

7. Contoh Kalimat Komunikasi yang Ramah Perempuan

Pilihan kata memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan klien. Kalimat yang menghakimi dapat membuat perempuan menutup diri, sedangkan kalimat yang empatik dapat membantu klien merasa aman. Tabel berikut memberikan contoh perubahan kalimat agar lebih mendukung promosi kesehatan reproduksi.

Tabel 6. 10 Contoh Kalimat Komunikasi Bidan yang Lebih Empatik

Situasi	Kalimat yang Perlu Dihindari	Kalimat yang Lebih Disarankan
Klien terlambat memeriksakan keluhan	Kenapa baru datang sekarang?	Terima kasih Ibu sudah datang. Mari kita lihat bersama keluhannya agar bisa ditangani dengan tepat.

Klien takut menggunakan kontrasepsi	Itu cuma mitos, Ibu jangan percaya.	Saya memahami kekhawatiran Ibu. Mari kita bahas informasi yang benar dan pilihan yang paling sesuai.
Klien malu membahas keputihan	Masalah seperti ini jangan ditutup-tutupi.	Keluhan ini bisa dialami banyak perempuan. Ibu boleh bercerita dengan tenang, informasi Ibu akan dijaga.
Klien ragu skrining kanker serviks	Kalau tidak skrining nanti berbahaya.	Skrining bertujuan menemukan perubahan sejak awal, bahkan saat belum ada gejala. Saya bisa jelaskan alurnya.
Klien mengalami tekanan pasangan	Ibu harus tegas kepada suami.	Keputusan kesehatan Ibu penting. Kita dapat membahas cara melibatkan pasangan dengan tetap menjaga kenyamanan dan keamanan Ibu.

8. Indikator Keberhasilan Komunikasi

Komunikasi bidan dapat dikatakan berhasil apabila klien merasa didengarkan, dihormati, dan tidak dihakimi. Klien juga mampu menjelaskan kembali informasi penting, memahami pilihan yang tersedia, mengetahui langkah yang perlu dilakukan, dan bersedia kembali ke layanan bila membutuhkan bantuan.

Tabel 6. 11 Indikator Keberhasilan Komunikasi Bidan

Indikator	Makna Praktis
Klien mampu menyebutkan kembali informasi utama	Pesan yang disampaikan bidan dipahami, bukan hanya didengar.
Klien mengetahui tanda bahaya	Klien tahu kapan harus segera mencari pertolongan.

Klien mengetahui pilihan layanan atau metode	Klien dapat membandingkan pilihan dan mengambil keputusan sadar.
Klien merasa aman untuk bertanya	Hubungan bidan-klien dibangun atas kepercayaan.
Klien mengambil keputusan tanpa paksaan	Prinsip otonomi dan informed choice dihormati.
Klien mengetahui jadwal kontrol atau rujukan	Konseling menghasilkan rencana tindak lanjut yang jelas.
Klien bersedia kembali bila membutuhkan bantuan	Pelayanan dinilai ramah dan dapat dipercaya.

G. Hambatan dalam Promosi Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur

Pelaksanaan promosi kesehatan reproduksi tidak selalu berjalan mudah. Hambatan dapat berasal dari individu, keluarga, budaya, sistem pelayanan, maupun lingkungan digital. Subbab ini membahas hambatan sebagai tantangan lapangan dan mengaitkannya dengan langkah yang dapat dilakukan bidan. Dengan demikian, pembahasan tidak mengulang definisi promosi kesehatan atau ruang lingkup materi, tetapi menyoroti faktor yang dapat menghambat perubahan perilaku dan akses layanan.

1. Rendahnya Literasi Kesehatan Reproduksi

Rendahnya literasi kesehatan reproduksi dapat terlihat dari kurangnya pemahaman tentang siklus menstruasi normal, tanda bahaya gangguan reproduksi, manfaat pemeriksaan pranikah, pentingnya kontrasepsi, tanda infeksi menular seksual, deteksi dini kanker serviks, dan kesiapan kehamilan. Banyak perempuan baru mencari pertolongan ketika keluhan sudah mengganggu aktivitas atau ketika kondisi menjadi berat.

Rendahnya literasi juga membuat perempuan sulit membedakan informasi yang benar dan keliru. Sebagian perempuan mungkin percaya bahwa keputihan selalu normal, nyeri haid berat adalah hal biasa, kontrasepsi menyebabkan kemandulan permanen, atau pemeriksaan organ reproduksi hanya diperlukan bila sudah ada keluhan berat. Kesalahpahaman semacam ini menghambat perilaku pencegahan.

Bidan perlu menjadi penerjemah informasi kesehatan. Materi harus disampaikan dengan bahasa sederhana, contoh dekat kehidupan sehari-hari, media visual, dan teknik teach-back. Bidan juga perlu mengarahkan klien pada sumber informasi tepercaya agar keputusan kesehatan tidak hanya berdasarkan cerita orang lain.

2. Tabu Budaya dalam Membicarakan Kesehatan Reproduksi

Pada sebagian masyarakat, pembicaraan tentang organ reproduksi, menstruasi, hubungan seksual, kontrasepsi, infertilitas, atau infeksi menular seksual masih dianggap tidak pantas dibicarakan terbuka. Akibatnya, perempuan dapat merasa malu bertanya, takut dinilai negatif, atau memilih diam meskipun mengalami keluhan.

Tabu budaya dapat membuat bidan sulit melakukan pengkajian yang tepat. Perempuan yang mengalami nyeri saat berhubungan seksual, perdarahan di luar siklus, keputihan berbau, atau luka pada area genital mungkin menunda konsultasi. Untuk menghadapi hambatan ini, bidan perlu menggunakan bahasa yang sopan, memilih istilah yang mudah diterima, menciptakan ruang konsultasi tertutup, dan menjaga kerahasiaan.

3. Rasa Malu, Takut, dan Kekhawatiran Klien

Rasa malu sering muncul karena topik reproduksi berkaitan dengan bagian tubuh yang sangat pribadi. Ketakutan dapat muncul karena klien khawatir mendapatkan diagnosis buruk, takut diperiksa, takut diketahui keluarga, atau takut mendapat penilaian negatif dari tenaga kesehatan. Klien juga dapat memiliki pengalaman pelayanan sebelumnya yang kurang menyenangkan, seperti pernah dimarahi, diperlakukan terburu-buru, tidak diberi penjelasan, atau merasa tidak dihargai.

Sikap bidan menjadi kunci. Bidan perlu menunjukkan empati, tidak menghakimi, menggunakan nada bicara lembut, memberi kesempatan klien bercerita, dan menegaskan bahwa layanan bersifat rahasia. Kalimat seperti "Ibu tidak perlu malu, keluhan seperti ini bisa terjadi dan kita akan bicarakan dengan tenang" dapat membantu menurunkan kecemasan klien.

4. Stigma terhadap Masalah Seksual dan Reproduksi

Stigma dapat muncul terhadap perempuan yang mengalami infeksi menular seksual, infertilitas, kehamilan tidak direncanakan, keguguran berulang, kekerasan seksual, penggunaan kontrasepsi, atau keluhan tertentu pada organ reproduksi. Stigma membuat perempuan takut dicap buruk, disalahkan, atau dikucilkan. Dalam konteks infertilitas, perempuan sering kali menerima tekanan sosial lebih besar, padahal masalah kesuburan dapat berasal dari perempuan, laki-laki, atau keduanya.

Stigma juga menghambat deteksi dini. Perempuan dengan gejala IMS dapat enggan berobat karena takut dianggap melakukan perilaku menyimpang. Perempuan yang ingin menggunakan kontrasepsi tertentu dapat takut dinilai tidak patuh kepada pasangan atau keluarga. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual dapat memilih diam karena takut disalahkan. Bidan perlu

mengurangi stigma dengan bahasa netral, tidak menyalahkan, tidak memberi label negatif, dan menegaskan bahwa mencari pertolongan adalah langkah bertanggung jawab.

5. Kurangnya Dukungan Pasangan dan Keluarga

Keputusan perempuan terkait kesehatan reproduksi tidak selalu ditentukan oleh dirinya sendiri. Dalam banyak keluarga, keputusan mengenai kontrasepsi, pemeriksaan kesehatan, perencanaan kehamilan, atau rujukan dapat dipengaruhi suami, orang tua, mertua, atau anggota keluarga lain. Ketika pasangan atau keluarga tidak mendukung, perempuan dapat mengalami kesulitan mengakses layanan.

Kurangnya dukungan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pasangan dapat menolak penggunaan kontrasepsi karena takut efek samping atau percaya mitos tertentu. Keluarga dapat melarang pemeriksaan reproduksi karena menganggap tidak perlu. Dalam kasus lain, perempuan mungkin tidak memiliki biaya, transportasi, atau izin untuk datang ke fasilitas kesehatan. Bidan perlu melibatkan pasangan dan keluarga secara bijak melalui konseling pasangan, kelas calon pengantin, kelas keluarga berencana, atau edukasi komunitas, sambil tetap menjaga privasi dan keselamatan perempuan.

6. Hambatan Akses Layanan

Hambatan akses dapat berupa jarak geografis, biaya transportasi, jadwal pelayanan yang tidak sesuai, keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas skrining, atau alur rujukan yang belum jelas. Perempuan yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan sering kali sulit datang ke fasilitas kesehatan pada jam pelayanan tertentu.

Bidan dapat membantu mengurangi hambatan akses dengan memberikan informasi jadwal layanan yang jelas, mengatur edukasi berbasis komunitas, bekerja sama dengan kader untuk mengingatkan sasaran, memfasilitasi rujukan, dan memanfaatkan media digital sebagai pengingat. Namun, media digital tetap harus dilengkapi layanan tatap muka, terutama untuk keluhan yang memerlukan pemeriksaan langsung.

7. Informasi Digital yang Keliru

Media digital memudahkan perempuan mencari informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran informasi keliru. Mitos tentang kontrasepsi, klaim obat herbal, informasi tidak tepat tentang kesuburan, atau konten yang menakutkan kanker dapat memengaruhi keputusan kesehatan. Perempuan dapat menunda pemeriksaan karena merasa cukup mengikuti saran di internet atau membeli produk tanpa konsultasi.

Bidan perlu meningkatkan literasi digital masyarakat. Edukasi dapat mencakup cara mengenali sumber terpercaya, pentingnya memeriksa tanggal dan institusi penerbit informasi, serta anjuran untuk berkonsultasi langsung bila ada keluhan. Bidan juga dapat membuat konten digital sederhana yang meluruskan mitos tanpa mempermalukan masyarakat.

Tabel 6. 12 Hambatan dan Respons Bidan dalam Promosi Kesehatan Reproduksi

Hambatan	Dampak	Respons Bidan
Literasi rendah	Klien sulit memahami tanda bahaya dan informasi layanan.	Gunakan bahasa sederhana, media visual, teach-back, dan contoh sehari-hari.
Tabu budaya	Klien malu bertanya dan menunda pemeriksaan.	Gunakan bahasa sopan, ruang privat, dan pendekatan bertahap.
Rasa takut dan malu	Klien tidak terbuka atau tidak kembali ke layanan.	Bangun hubungan empatik, tidak menghakimi, dan menjaga rahasia.
Stigma	Klien takut dicap buruk dan menghindari layanan.	Gunakan bahasa netral, tekankan hak layanan, dan hindari label negatif.
Kurang dukungan keluarga	Keputusan kesehatan tertunda atau tidak terlaksana.	Libatkan pasangan/keluarga secara bijak dengan persetujuan klien.
Akses layanan terbatas	Skrining, rujukan, atau kontrol tidak dilakukan.	Fasilitasi informasi jadwal, rujukan, kolaborasi kader, dan tindak lanjut.
Informasi digital keliru	Klien percaya mitos atau menunda pemeriksaan.	Berikan edukasi literasi digital dan sumber informasi terpercaya.

8. Keterbatasan Waktu dan Beban Kerja Bidan

Dalam pelayanan primer, bidan sering menghadapi banyak tugas dalam waktu terbatas. Kondisi ini dapat membuat edukasi dan konseling dilakukan singkat, terutama ketika jumlah klien banyak. Akibatnya, klien mungkin menerima informasi dasar, tetapi belum benar-benar memahami pilihan, tanda bahaya, atau

tindak lanjut. Keterbatasan waktu juga dapat membuat isu sensitif tidak tergal, seperti kekerasan, kecemasan, atau hambatan keluarga.

Untuk mengatasi hambatan ini, bidan dapat menggunakan media KIE yang ringkas, lembar konseling, alur edukasi singkat, dan sistem tindak lanjut. Informasi umum dapat diberikan melalui kelas kelompok atau media digital, sedangkan masalah personal diarahkan ke konseling individual. Pembagian peran dengan kader dan tim Puskesmas juga dapat membantu memperluas jangkauan edukasi tanpa mengurangi kualitas layanan.

9. Keterbatasan Sarana, Media, dan Data Program

Promosi kesehatan reproduksi memerlukan dukungan sarana, media, dan data. Tanpa media yang menarik, edukasi mudah menjadi ceramah satu arah. Tanpa data, bidan sulit mengetahui kelompok mana yang paling membutuhkan intervensi. Tanpa alur rujukan yang jelas, klien yang sudah termotivasi untuk diperiksa dapat tetap mengalami hambatan ketika mencari layanan lanjutan.

Bidan dapat mengatasi hambatan ini dengan menyusun media sederhana berbasis kebutuhan lokal, menggunakan data pelayanan untuk memetakan masalah, dan membangun jejaring dengan fasilitas rujukan. Media tidak harus selalu mahal; poster sederhana, kartu tanda bahaya, daftar jadwal skrining, dan lembar rencana kesehatan pribadi dapat sangat membantu bila digunakan secara konsisten.

H. Upaya Penguatan Peran Bidan

Penguatan peran bidan diperlukan agar promosi kesehatan reproduksi tidak berhenti sebagai kegiatan penyuluhan sesekali, tetapi menjadi bagian dari pelayanan kebidanan yang terencana, terintegrasi, dan dapat dievaluasi. Subbab ini tidak mengulang peran bidan yang telah dijelaskan pada Subbab C, tetapi menekankan upaya yang perlu dilakukan agar peran tersebut dapat berjalan lebih kuat di lapangan.

1. Peningkatan Kompetensi Bidan secara Berkelanjutan

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur merupakan bidang yang luas dan terus berkembang. Bidan perlu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai perkembangan ilmu, regulasi, teknologi kesehatan, dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, lokakarya, pembelajaran berbasis kasus, supervisi klinis, diskusi reflektif, dan pembaruan standar operasional prosedur.

Materi pelatihan yang perlu diperkuat meliputi konseling kesehatan reproduksi, pemilihan kontrasepsi, pelayanan prakonsepsi, deteksi dini kanker serviks, pencegahan anemia, kesehatan mental perempuan, edukasi IMS,

penanganan awal kekerasan berbasis gender, literasi digital, dan komunikasi sensitif budaya. Kompetensi konseling menjadi sangat penting karena banyak masalah reproduksi bersifat personal dan sensitif.

Peningkatan kompetensi juga harus mencakup aspek etika dan hak reproduksi. Bidan perlu memahami bahwa setiap perempuan berhak memperoleh informasi yang benar, pelayanan yang aman, serta kesempatan mengambil keputusan tentang kesehatan reproduksinya. Dengan demikian, bidan tidak hanya menjadi pemberi layanan, tetapi juga pendamping dan pelindung hak kesehatan perempuan.

2. Penyediaan Media KIE yang Menarik dan Sesuai Konteks Lokal

Media komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE merupakan sarana penting untuk membantu bidan menyampaikan pesan kesehatan reproduksi secara efektif. Tanpa media yang baik, edukasi sering hanya menjadi ceramah singkat yang mudah dilupakan. Media KIE dapat berupa leaflet, poster, booklet, lembar balik, infografis, video pendek, kartu konseling, modul kelas edukasi, pesan WhatsApp, konten media sosial, maupun alat bantu visual saat konseling.

Media KIE harus menggunakan bahasa sederhana, gambar yang jelas, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan pesan yang tidak menakut-nakuti. Media yang baik bukan hanya menarik secara tampilan, tetapi juga membantu perempuan memahami masalah, mengenali risiko, dan mengetahui tindakan yang perlu dilakukan. Media juga harus memuat informasi praktis, seperti kapan harus datang ke fasilitas kesehatan, ke mana mencari pertolongan, dan layanan apa saja yang tersedia.

Penyusunan media perlu memperhatikan karakteristik sasaran. Media untuk remaja putri berbeda dengan media untuk calon pengantin, pasangan usia subur, ibu muda, atau perempuan dengan keluhan reproduksi. Pada remaja, media perlu lebih komunikatif dan tidak menggurui. Pada calon pengantin, media dapat menekankan pemeriksaan pranikah dan prakonsepsi. Pada pasangan usia subur, media lebih menekankan kontrasepsi, jarak kehamilan, deteksi dini penyakit reproduksi, dan kesehatan keluarga.

3. Penguatan Sistem Rujukan Kesehatan Reproduksi

Promosi kesehatan reproduksi tidak hanya berhenti pada pemberian informasi. Bidan juga perlu mengenali kondisi yang memerlukan penanganan lanjutan dan merujuk klien ke fasilitas atau tenaga kesehatan yang tepat. Kondisi yang memerlukan rujukan dapat berupa perdarahan abnormal, nyeri panggul berat, dugaan IMS, hasil skrining kanker serviks yang mencurigakan, gangguan kesehatan mental berat, infertilitas, kehamilan tidak direncanakan dengan masalah psikososial, kekerasan seksual, atau kekerasan dalam rumah tangga.

Sistem rujukan yang baik mencakup pengetahuan tentang fasilitas rujukan yang tersedia, kriteria rujukan, tanda bahaya, komunikasi rujukan, pencatatan, dan tindak lanjut. Bidan perlu mampu menjelaskan alasan rujukan kepada klien dan keluarga dengan bahasa sederhana. Rujukan juga perlu didokumentasikan agar kesinambungan pelayanan dapat dipantau.

Pada kasus kekerasan berbasis gender, rujukan harus mempertimbangkan keamanan klien. Bidan perlu memberikan dukungan awal yang aman, menjaga kerahasiaan, tidak menyalahkan korban, menilai risiko keselamatan, dan menghubungkan korban dengan layanan kesehatan, psikososial, perlindungan, atau hukum sesuai kebutuhan.

4. Integrasi Promosi Kesehatan Reproduksi ke dalam Layanan Rutin

Promosi kesehatan reproduksi sebaiknya menjadi bagian dari setiap kontak antara bidan dan perempuan usia subur. Integrasi dapat dilakukan dalam pelayanan KB, pemeriksaan calon pengantin, Posyandu, kelas ibu, pelayanan remaja, pelayanan prakonsepsi, kunjungan rumah, pemeriksaan nifas, pelayanan imunisasi, dan kegiatan komunitas.

Saat memberikan pelayanan KB, bidan tidak hanya menjelaskan cara penggunaan kontrasepsi, tetapi juga dapat memberikan edukasi tentang perencanaan kehamilan, tanda bahaya efek samping, pencegahan IMS, dan pentingnya pemeriksaan kanker serviks. Saat melayani calon pengantin, bidan dapat membahas pemeriksaan pranikah, anemia, imunisasi, status gizi, kesiapan psikologis, dan komunikasi pasangan. Saat kegiatan Posyandu, bidan dapat menyisipkan edukasi tentang gizi perempuan usia subur, tablet tambah darah, dan kesehatan reproduksi keluarga.

Integrasi membuat promosi kesehatan lebih efisien, berkesinambungan, dan mudah diterima. Perempuan tidak merasa sedang diceramahi, tetapi menerima informasi sebagai bagian dari pelayanan yang memang dibutuhkan. Dengan demikian, promosi kesehatan menjadi lebih alami dan berdampak langsung pada perilaku kesehatan.

5. Penguatan Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi

Kegiatan promosi kesehatan sering dianggap berhasil hanya karena telah dilaksanakan, padahal keberhasilan perlu diukur melalui data. Tanpa pencatatan dan evaluasi, bidan sulit mengetahui apakah kegiatan edukasi benar-benar meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku, atau memperluas akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Pencatatan dapat mencakup jumlah peserta edukasi, topik yang diberikan, karakteristik sasaran, media yang digunakan, jumlah klien yang mendapat konseling, jumlah klien yang dirujuk, jenis masalah yang ditemukan, serta tindak

lanjut layanan. Pelaporan dapat dilakukan secara berkala sesuai mekanisme di fasilitas kesehatan atau wilayah kerja.

Evaluasi dapat mencakup evaluasi proses, hasil, dan dampak. Evaluasi proses menilai jumlah kegiatan, kehadiran peserta, ketersediaan media, dan keterlibatan kader. Evaluasi hasil menilai perubahan pengetahuan, sikap, atau keterampilan sasaran. Evaluasi dampak menilai perubahan yang lebih luas, seperti meningkatnya pemeriksaan pranikah, penggunaan kontrasepsi sesuai kebutuhan, partisipasi skrining kanker serviks, atau penurunan anemia pada perempuan usia subur.

6. Penguatan Jejaring dan Kepemimpinan Bidan

Bidan perlu membangun jejaring kerja dengan Puskesmas, rumah sakit, laboratorium, ahli gizi, psikolog, dokter, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, tempat kerja, dan lembaga perlindungan perempuan. Jejaring yang kuat membuat pelayanan lebih mudah diakses dan rujukan lebih cepat dilakukan. Jejaring juga membantu bidan mengadvokasi kebutuhan program, seperti pelatihan, media edukasi, alat skrining, dan dukungan kegiatan komunitas.

Kepemimpinan bidan juga penting dalam membangun budaya pelayanan yang ramah perempuan. Bidan dapat menjadi teladan dalam menjaga kerahasiaan, menggunakan bahasa yang menghargai klien, mendokumentasikan layanan dengan baik, dan mengajak tim untuk memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif. Kepemimpinan tidak selalu berarti jabatan struktural; kepemimpinan dapat tampak dari kemampuan bidan menggerakkan perubahan kecil yang berdampak pada kualitas layanan.

7. Penguatan Literasi Digital Bidan dan Masyarakat

Di era digital, bidan perlu memiliki kemampuan memilih, menilai, dan menyebarkan informasi kesehatan yang benar. Bidan juga perlu memahami etika penggunaan media digital, termasuk menjaga privasi klien, tidak membagikan kasus pribadi tanpa izin, tidak memberikan diagnosis terbuka di media sosial, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya.

Bidan dapat membantu masyarakat meningkatkan literasi digital melalui edukasi tentang sumber informasi tepercaya, bahaya klaim kesehatan tanpa dasar, dan pentingnya konsultasi langsung bila terdapat keluhan. Konten digital yang dibuat bidan sebaiknya singkat, menarik, mudah dipahami, dan diakhiri dengan ajakan tindakan yang jelas, misalnya "konsultasikan bila nyeri haid mengganggu aktivitas" atau "datang ke layanan skrining meskipun belum ada gejala".

8. Contoh Rencana Implementasi Penguatan Program

Penguatan peran bidan akan lebih mudah dilakukan bila diterjemahkan ke dalam rencana implementasi yang sederhana. Rencana dapat disusun dalam jangka pendek, menengah, dan berkelanjutan. Pada tahap awal, bidan dapat memetakan masalah prioritas, menyiapkan media edukasi, dan menentukan sasaran. Tahap berikutnya dapat berupa pelaksanaan kelas edukasi, konseling individual, dan rujukan. Tahap berkelanjutan mencakup pencatatan, evaluasi, penguatan kader, dan perbaikan materi berdasarkan umpan balik peserta.

9. Indikator Keberhasilan Penguatan Peran Bidan

Indikator keberhasilan perlu dibuat agar program dapat dinilai secara objektif. Indikator tidak hanya berupa jumlah kegiatan, tetapi juga perubahan pemahaman, akses layanan, dan tindak lanjut. Indikator proses dapat berupa jumlah kelas edukasi, jumlah peserta, jumlah media yang dibagikan, dan jumlah kader yang dilibatkan. Indikator hasil dapat berupa peningkatan skor pengetahuan, jumlah klien yang melakukan konseling, jumlah perempuan yang mengikuti skrining, atau jumlah rujukan yang selesai ditindaklanjuti. Indikator dampak dapat berupa meningkatnya perilaku kesehatan reproduksi yang baik, menurunnya mitos, meningkatnya penggunaan kontrasepsi sesuai kebutuhan, atau meningkatnya kepatuhan konsumsi tablet tambah darah.

I. Penutup

Kesehatan reproduksi perempuan usia subur merupakan bagian penting dari pembangunan kesehatan keluarga dan masyarakat. Perempuan usia subur berada pada fase kehidupan yang strategis karena pada masa ini perempuan menjalankan fungsi biologis reproduksi sekaligus memiliki peran sosial, psikologis, ekonomi, dan keluarga. Oleh karena itu, menjaga kesehatan reproduksi harus dimaknai sebagai proses berkelanjutan sejak perempuan memahami tubuhnya, mampu menjaga kesehatannya, berani mengambil keputusan, dan memperoleh akses pelayanan yang aman serta bermutu.

Bidan memiliki peran sentral dalam proses tersebut karena berada dekat dengan perempuan, keluarga, dan masyarakat. Peran bidan dalam promosi kesehatan reproduksi mencakup edukasi, konseling, fasilitasi akses layanan, advokasi, deteksi dini, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Peran-peran tersebut saling melengkapi. Edukasi meningkatkan pengetahuan, konseling membantu pengambilan keputusan, fasilitasi membuka akses layanan, advokasi melindungi hak perempuan, deteksi dini mencegah keterlambatan, kolaborasi memperluas dukungan, dan pemberdayaan masyarakat membangun lingkungan yang sehat.

Promosi kesehatan reproduksi tidak cukup dilakukan melalui penyuluhan satu arah. Promosi kesehatan harus menjadi proses pemberdayaan yang membantu perempuan memahami pilihan, mengenali risiko, mengakses layanan, dan bertindak sehat sesuai kondisi kehidupannya. Karena itu, bidan perlu mengedepankan pendekatan yang berbasis bukti, ramah perempuan, menjaga kerahasiaan, tidak menghakimi, menghormati pilihan klien, dan sensitif terhadap nilai budaya setempat.

Keberhasilan promosi kesehatan reproduksi juga bergantung pada kemampuan bidan mengatasi hambatan lapangan. Rendahnya literasi kesehatan, tabu budaya, rasa malu, stigma, kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan akses, dan informasi digital yang keliru dapat membuat perempuan menunda pemeriksaan atau mengambil keputusan yang kurang tepat. Bidan perlu hadir sebagai sumber informasi yang tepercaya, pendamping yang empatik, dan penghubung antara kebutuhan perempuan dengan sistem pelayanan kesehatan.

Dengan optimalisasi peran bidan, perempuan usia subur dapat memperoleh pendampingan yang lebih baik dalam menjaga kesehatan reproduksinya. Perempuan yang memiliki literasi kesehatan reproduksi yang baik akan lebih mampu menjaga kebersihan organ reproduksi, mengenali gangguan menstruasi, mencegah anemia, merencanakan kehamilan, memilih kontrasepsi yang sesuai, mengikuti pemeriksaan kesehatan, serta mencari pertolongan ketika mengalami keluhan.

Pada akhirnya, promosi kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari pelayanan kebidanan yang bermutu. Ketika bidan mampu menjalankan perannya secara optimal, perempuan usia subur tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga menjadi subjek yang berdaya, sadar, dan mampu mengambil keputusan terbaik bagi kesehatan reproduksi serta kehidupannya. Dengan demikian, peran bidan tidak hanya berkontribusi pada kesehatan individu perempuan, tetapi juga pada kualitas keluarga, masyarakat, dan generasi masa depan.

Referensi

- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2024). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dalam angka. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5539/>
- Badan Pusat Statistik. (2024, December 11). Persentase wanita berumur 15–49 tahun dan berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat KB. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE4IzI%3D/persentase-wanita-berumur-15-49-tahun-dan-berstatus-kawin-yang-sedang-menggunakan-memakai-alat-kb.html>
- International Confederation of Midwives. (2024). ICM essential competencies for midwifery practice. <https://internationalmidwives.org/resources/essential-competencies-for-midwifery-practice/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Pedoman pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dan wanita usia subur. <https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files99778Revisi%20Buku%20Pencegahan%20dan%20Penanggulangan%20Anemia%20pada%20Rematri%20dan%20WUS.pdf>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018, August 9). Pentingnya menjaga kesehatan reproduksi saat menstruasi. Ayo Sehat. <https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-menjaga-kesehatan-reproduksi-saat-mentruasi>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018, August 10). Pentingnya menjaga kebersihan alat reproduksi. Ayo Sehat. <https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-menjaga-kebersihan-alat-reproduksi>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018, August 14). Pentingnya pemeriksaan kesehatan pra nikah. Ayo Sehat. <https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022, May 23). Kemandulan (infertil): Stigma negatif pada wanita Indonesia. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/12/kemandulan-infertil-stigma-negatif-pada-wanita-indonesia
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024, February 22). Kemenkes bertekad mempercepat eliminasi kanker serviks. <https://kemkes.go.id/id/kemenkes-bertekad-mempercepat-eliminasi-kanker-serviks>

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314518/permenkes-no-2-tahun-2025>
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/details/294077/pp-no-28-tahun-2024>
- United Nations Population Fund, World Health Organization, & International Confederation of Midwives. (2021). The state of the world's midwifery 2021: Building a health workforce to meet the needs of women, newborns and adolescents everywhere. United Nations Population Fund. <https://www.unfpa.org/sowmy>
- World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. <https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/first-global-conference>
- World Health Organization. (2019). WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550505>
- World Health Organization. (2021). Global strategy on digital health 2020–2025. <https://www.who.int/docs/default-source/documents/gd4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf>
- World Health Organization. (n.d.-a). Health promotion. Retrieved May 26, 2026, from <https://www.who.int/health-topics/health-promotion>
- World Health Organization. (n.d.-b). Sexual and reproductive health and rights. Retrieved May 26, 2026, from <https://www.who.int/health-topics/sexual-and-reproductive-health-and-rights>
- World Health Organization, & Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs. (2022). Family planning: A global handbook for providers (4th ed.). <https://fphandbook.org/sites/default/files/WHO-JHU-FPHandbook-2022Ed-v221114b.pdf>
- World Health Organization, & United Nations Population Fund. (2024, November 15). WHO, UNFPA commend Indonesia's efforts to eliminate cervical cancer, urge streamlined vaccine strategy and enhanced screening. <https://www.who.int/indonesia/news/detail/15-11-2024-who--unfpa->

commend-indonesia-s-efforts-to-eliminate-cervical-cancer--urge-streamlined-vaccine-strategy-and-enhanced-screening

CHAPTER 7

EVALUASI PELAYANAN KEBIDANAN PADA PEREMPUAN USIA SUBUR

Sitti Hadriyanti Hamang, S.ST.,M.Keb.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dalam siklus kehidupan perempuan, khususnya pada perempuan usia subur (PUS) atau wanita usia subur (WUS) dengan rentang usia 15–49 tahun. Pelayanan kebidanan pada perempuan usia subur bertujuan untuk menjaga kesehatan reproduksi, mencegah komplikasi, meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta mendukung tercapainya keluarga sehat dan sejahtera. Pelayanan ini meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan secara berkesinambungan (Wratsangka *et al.*, 2025). Pelayanan kebidanan yang efektif harus memperhatikan aspek kesehatan reproduksi secara holistik, termasuk faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan perempuan (Prabandari *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan tenaga medis dalam memberikan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan berkualitas bagi perempuan usia subur (Hamsah *et al.*, 2021).

Menurut World Health Organization, kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya (Benedetto, 2024). Permasalahan kesehatan reproduksi pada perempuan usia subur masih menjadi tantangan global, termasuk tingginya angka kehamilan tidak direncanakan, anemia, infeksi menular seksual, kekerasan berbasis gender, serta rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan sangat penting, terutama dalam konteks kesehatan reproduksi yang masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. (Manurung *et al.*, 2023)

Data WHO tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 287.000 perempuan di dunia meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan, dan sebagian besar terjadi di negara berkembang. Selain itu, masih terdapat jutaan perempuan yang belum memperoleh akses terhadap pelayanan kontrasepsi modern dan pelayanan reproduksi yang aman. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi pelayanan kebidanan agar pelayanan yang diberikan benar-benar efektif, bermutu,

aman, dan sesuai kebutuhan perempuan usia subur. Evaluasi pelayanan kebidanan menjadi langkah penting untuk menilai keberhasilan pelayanan kesehatan reproduksi yang telah diberikan. Evaluasi tidak hanya melihat hasil akhir pelayanan, tetapi juga mencakup aspek mutu pelayanan, kepuasan pasien, keterjangkauan layanan, kompetensi tenaga kesehatan, kesinambungan asuhan, serta efektivitas program kesehatan reproduksi yang dijalankan. Evaluasi yang komprehensif terhadap pelayanan kebidanan dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem kesehatan reproduksi, sehingga perbaikan yang diperlukan dapat segera diimplementasikan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan kebidanan harus dilakukan melalui pelatihan dan edukasi bagi tenaga medis, serta melibatkan partisipasi aktif perempuan untuk mencapai kesehatan reproduksi yang optimal. (Rustandi *et al.*, 2025)

Pelayanan kebidanan yang berkualitas dapat membantu perempuan usia subur dalam menjaga kesehatan reproduksinya melalui deteksi dini masalah kesehatan, peningkatan pengetahuan, penguatan perilaku hidup sehat, penggunaan kontrasepsi yang tepat, serta pencegahan komplikasi reproduksi. Oleh karena itu, evaluasi pelayanan kebidanan perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mencapai target pembangunan kesehatan nasional maupun global. (Rad *et al.*, 2023)

B. Konsep Pelayanan Kebidanan pada Perempuan Usia Subur

Pelayanan kebidanan pada perempuan usia subur merupakan pelayanan profesional yang diberikan oleh bidan untuk membantu perempuan mencapai kesehatan reproduksi optimal. Pelayanan ini dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan sesuai kebutuhan perempuan sepanjang siklus reproduksi. (Yulizawati *et al.*, 2022). Pelayanan kebidanan pada perempuan usia subur meliputi:

1. Pelayanan Promotif. Pelayanan promotif bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan tentang kesehatan reproduksi. Bentuk pelayanan promotif meliputi:
 - a. Pendidikan kesehatan reproduksi
 - b. Konseling pranikah
 - c. Edukasi gizi reproduksi
 - d. Penyuluhan pencegahan infeksi menular seksual
 - e. Edukasi deteksi dini kanker serviks dan payudara

2. Pelayanan Preventif

Pelayanan preventif bertujuan mencegah terjadinya gangguan kesehatan reproduksi, antara lain:

- a. Pelayanan keluarga berencana
- b. Imunisasi tetanus toxoid
- c. Skrining anemia
- d. Pemeriksaan IVA dan Pap smear
- e. Pencegahan penyakit menular seksual

3. Pelayanan Kuratif

Pelayanan kuratif diberikan untuk menangani masalah kesehatan reproduksi yang dialami perempuan usia subur, seperti:

- a. Gangguan menstruasi
- b. Infeksi saluran reproduksi
- c. Anemia
- d. Keputihan patologis
- e. Efek samping kontrasepsi

4. Pelayanan Rehabilitatif

Pelayanan rehabilitatif bertujuan memulihkan kondisi kesehatan perempuan setelah mengalami gangguan kesehatan reproduksi, termasuk:

- a. Pendampingan pasca keguguran
- b. Konseling psikologis
- c. Pemulihan kesehatan reproduksi

C. Tujuan Evaluasi Pelayanan Kebidanan

Evaluasi pelayanan kebidanan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan usia subur. Melalui evaluasi, tenaga kesehatan dapat mengetahui sejauh mana pelayanan yang telah diberikan mampu memenuhi kebutuhan pasien, mencapai tujuan program, serta memberikan dampak positif terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Evaluasi tidak hanya digunakan untuk menilai hasil akhir pelayanan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenali kekuatan, kelemahan, hambatan, dan peluang perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan.

Tujuan utama evaluasi pelayanan kebidanan adalah menilai mutu pelayanan yang diberikan. Mutu pelayanan dapat dilihat dari aspek keamanan tindakan, ketepatan pelayanan, kenyamanan pasien, kelengkapan informasi, serta kesesuaian pelayanan dengan standar profesi dan standar operasional prosedur. Pelayanan kebidanan yang bermutu akan memberikan rasa aman bagi pasien, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat peran bidan sebagai tenaga kesehatan yang profesional.

Selain menilai mutu pelayanan, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien. Kepuasan pasien menjadi salah satu indikator penting karena mencerminkan pengalaman perempuan selama menerima pelayanan kesehatan reproduksi. Pasien yang merasa dihargai, didengarkan, memperoleh informasi yang jelas, dan mendapatkan pelayanan yang ramah cenderung memiliki kepercayaan yang lebih baik terhadap tenaga kesehatan. Kepercayaan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengikuti anjuran, melakukan kunjungan ulang, dan memanfaatkan layanan kesehatan reproduksi secara berkelanjutan.

Evaluasi pelayanan kebidanan juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses pelayanan. Hambatan tersebut dapat berasal dari keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, ketersediaan alat dan obat, sistem rujukan, pembiayaan, maupun faktor sosial budaya masyarakat. Dengan mengetahui hambatan yang ada, fasilitas pelayanan kesehatan dapat menyusun strategi perbaikan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Tujuan lain dari evaluasi adalah mengukur pencapaian program kesehatan reproduksi. Program seperti keluarga berencana, skrining kanker serviks, pencegahan anemia, edukasi kesehatan reproduksi, dan deteksi dini infeksi menular seksual memerlukan pemantauan secara teratur agar tingkat keberhasilannya dapat diketahui. Evaluasi juga dapat menunjukkan apakah upaya promotif dan preventif yang telah dilakukan sudah efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku perempuan usia subur terhadap kesehatan reproduksinya.

Dengan demikian, evaluasi pelayanan kebidanan menjadi dasar penting dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan dapat membantu tenaga kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga perempuan usia subur memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhannya (Sanjaya dan Pemayun, 2023).

D. Komponen Evaluasi Pelayanan Kebidanan

Evaluasi pelayanan kebidanan dapat dilakukan melalui beberapa komponen utama, yaitu evaluasi input, proses, output, dan outcome. Keempat komponen tersebut saling berkaitan dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas pelayanan kebidanan. Evaluasi tidak cukup hanya melihat hasil akhir pelayanan, tetapi juga perlu memperhatikan sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan pelayanan, hasil langsung yang dicapai, serta dampak jangka panjang terhadap kesehatan perempuan usia subur.

Evaluasi input merupakan penilaian terhadap seluruh sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kebidanan. Komponen ini mencakup kompetensi bidan, ketersediaan sarana dan prasarana, kelengkapan alat kesehatan, ketersediaan obat, kebijakan pelayanan, serta pendanaan program. Kompetensi bidan menjadi faktor penting karena kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan bidan dalam memberikan asuhan. Bidan yang kompeten akan mampu melakukan pengkajian, memberikan konseling,

melaksanakan tindakan kebidanan, melakukan deteksi dini, serta memberikan rujukan secara tepat. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan reproduksi. Pelayanan yang baik sulit tercapai apabila fasilitas tidak mendukung, alat tidak tersedia, atau obat yang dibutuhkan tidak mencukupi.

Evaluasi proses berfokus pada cara pelayanan kebidanan dilaksanakan. Dalam komponen ini, penilaian dilakukan terhadap kesesuaian pelayanan dengan standar, pelaksanaan komunikasi terapeutik, pemberian konseling kesehatan reproduksi, pendokumentasian asuhan kebidanan, serta kepatuhan bidan terhadap standar operasional prosedur. Proses pelayanan yang baik menunjukkan bahwa bidan tidak hanya memberikan tindakan secara teknis, tetapi juga memperhatikan hubungan interpersonal dengan pasien. Komunikasi yang jelas, empati, penghargaan terhadap privasi, serta kemampuan memberikan edukasi menjadi bagian penting dalam pelayanan kebidanan yang berkualitas. Pelayanan yang sesuai standar dapat meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi risiko kesalahan tindakan.

Evaluasi output digunakan untuk melihat hasil langsung dari pelayanan yang diberikan. Output dapat berupa cakupan pelayanan keluarga berencana, jumlah kunjungan kesehatan reproduksi, cakupan pemeriksaan IVA, kepatuhan pasien dalam melakukan kunjungan ulang, serta tingkat kepuasan pasien. Hasil langsung ini memberikan gambaran mengenai ketercapaian pelayanan dalam jangka pendek. Misalnya, meningkatnya cakupan pemeriksaan IVA menunjukkan bahwa edukasi dan akses terhadap layanan skrining kanker serviks mulai berjalan dengan baik. Demikian pula, tingginya tingkat kepuasan pasien menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna layanan.

Evaluasi outcome menilai dampak jangka panjang pelayanan kebidanan terhadap status kesehatan perempuan usia subur. Outcome dapat dilihat dari penurunan angka kehamilan yang tidak direncanakan, penurunan anemia, penurunan kejadian infeksi reproduksi, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta penurunan angka kematian ibu. Berbeda dengan output yang menunjukkan hasil langsung, outcome menggambarkan perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi outcome membutuhkan pemantauan berkala dan data yang valid agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu pelayanan.

E. Indikator Evaluasi Pelayanan Kebidanan

Indikator evaluasi merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelayanan kebidanan pada perempuan usia subur. Indikator ini membantu tenaga kesehatan dan pengelola program dalam melihat apakah pelayanan yang diberikan telah mencapai target yang diharapkan. Indikator yang baik harus jelas, terukur, relevan, realistis, dan dapat digunakan untuk menilai perkembangan pelayanan dari waktu ke waktu.

Dalam pelayanan kesehatan reproduksi, beberapa indikator penting yang dapat digunakan antara lain cakupan pelayanan keluarga berencana, peningkatan

pemeriksaan IVA, tingkat kepuasan pasien, jumlah kunjungan konseling reproduksi, penurunan anemia pada perempuan usia subur, serta kepatuhan terhadap SOP pelayanan. Cakupan pelayanan keluarga berencana menggambarkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program kontrasepsi. Target cakupan pelayanan KB yang baik umumnya diarahkan agar mencapai minimal 80% dari sasaran. Sementara itu, pemeriksaan IVA diharapkan mengalami peningkatan setiap tahun sebagai bentuk keberhasilan upaya deteksi dini kanker serviks.

Kepuasan pasien juga menjadi indikator penting dalam evaluasi pelayanan kebidanan. Tingkat kepuasan pasien yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan telah diberikan secara ramah, jelas, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi, kepuasan pasien dapat mendorong perempuan usia subur untuk lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan dan lebih patuh terhadap anjuran tenaga kesehatan. Selain itu, peningkatan kunjungan konseling reproduksi menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk memperoleh informasi dan pendampingan terkait kesehatan reproduksi.

Indikator lain yang perlu diperhatikan adalah penurunan anemia pada perempuan usia subur. Anemia dapat berdampak pada kesehatan reproduksi dan meningkatkan risiko komplikasi apabila perempuan tersebut hamil. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pencegahan dan penatalaksanaan anemia menjadi bagian penting dalam pelayanan kebidanan. Kepatuhan terhadap SOP pelayanan juga harus menjadi indikator utama karena pelayanan yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko kesalahan dan menurunkan kualitas asuhan. Idealnya, kepatuhan terhadap SOP harus mencapai 100% agar keselamatan pasien dapat terjamin.

Dengan penggunaan indikator yang tepat, evaluasi pelayanan kebidanan dapat dilakukan secara lebih objektif. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi fasilitas kesehatan untuk menyusun perencanaan, memperbaiki kelemahan, meningkatkan mutu pelayanan, dan memastikan bahwa perempuan usia subur memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang optimal (Mazur, Brindis, dan Decker, 2018).

F. Metode Evaluasi Pelayanan Kebidanan pada Perempuan Usia Subur

Evaluasi pelayanan kebidanan bagi perempuan usia subur dapat dilakukan melalui berbagai metode. Pemilihan metode evaluasi perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, jenis pelayanan yang dinilai, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik sasaran pelayanan. Evaluasi yang dilakukan dengan metode yang tepat akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai mutu pelayanan, keberhasilan program, serta hambatan yang terjadi di lapangan. Evaluasi yang sistematis juga dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan reproduksi, baik di fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun lanjutan (Teshome et al., 2024).

Salah satu metode evaluasi yang dapat digunakan adalah observasi pelayanan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses pelayanan

kebidanan yang diberikan kepada perempuan usia subur. Melalui observasi, evaluator dapat menilai teknik anamnesis yang dilakukan bidan, cara bidan berkomunikasi dengan pasien, pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi, ketepatan tindakan kebidanan, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Observasi langsung memungkinkan evaluator melihat kondisi nyata pelayanan, bukan hanya berdasarkan laporan tertulis. Dengan demikian, metode ini dapat membantu menemukan kesenjangan antara standar pelayanan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa observasi pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap standar keselamatan pasien dan mutu pelayanan reproduksi (Rasheed et al., 2023).

Metode berikutnya adalah wawancara dan konseling evaluatif. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, kebutuhan, dan tingkat kepuasan perempuan usia subur terhadap pelayanan yang telah diterima. Wawancara dapat dilakukan secara langsung, melalui konseling individual, telepon, kuesioner daring, maupun diskusi kelompok terarah. Melalui pendekatan ini, tenaga kesehatan dapat memahami hambatan yang dialami pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan reproduksi, seperti rasa malu, kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan biaya, jarak fasilitas kesehatan, atau kurangnya informasi. Wawancara juga membantu bidan memperoleh masukan langsung dari pasien sehingga perbaikan pelayanan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Komunikasi interpersonal yang baik antara bidan dan pasien terbukti dapat meningkatkan kepuasan pasien serta kepatuhan terhadap program kesehatan reproduksi (Kassa et al., 2024).

Audit dokumentasi kebidanan juga menjadi metode penting dalam evaluasi pelayanan. Audit dilakukan dengan menilai kelengkapan dan ketepatan pencatatan asuhan kebidanan yang telah diberikan. Aspek yang dapat dinilai meliputi pendokumentasian SOAP, catatan pelayanan kontrasepsi, hasil pemeriksaan IVA, dokumentasi konseling, serta kelengkapan rekam medis pasien. Dokumentasi yang baik menunjukkan bahwa pelayanan telah dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dokumentasi yang lengkap mempermudah kesinambungan pelayanan, terutama ketika pasien membutuhkan tindak lanjut atau rujukan. Dalam praktik kebidanan, dokumentasi juga memiliki nilai legal karena menjadi bukti tertulis atas pelayanan yang telah diberikan. Dokumentasi yang baik berkaitan erat dengan peningkatan kualitas asuhan kebidanan dan keselamatan pasien (Moura et al., 2023).

Survei kepuasan pasien merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengetahui penilaian perempuan usia subur terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Survei ini dapat mencakup sikap dan keramahan petugas, kecepatan pelayanan, privasi dan kenyamanan, ketersediaan fasilitas, serta kejelasan informasi kesehatan yang diberikan. Kepuasan pasien menjadi cerminan keberhasilan pelayanan yang berpusat pada pasien. Pelayanan yang memperhatikan kebutuhan, harapan, dan kenyamanan pasien dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Menurut WHO, pelayanan yang berfokus pada pasien

dapat meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan dan memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat (WHO, 2024).

Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan melalui monitoring dan supervisi berkala. Monitoring merupakan kegiatan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan pelayanan, sedangkan supervisi bertujuan memberikan pembinaan, umpan balik, dan perbaikan terhadap kinerja tenaga kesehatan. Supervisi biasanya dilakukan oleh pimpinan fasilitas kesehatan, koordinator program, atau tim mutu pelayanan. Kegiatan ini mencakup penilaian kinerja tenaga kesehatan, evaluasi pelaksanaan SOP, pemantauan indikator program, serta pemberian arahan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Supervisi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan motivasi tenaga kesehatan dan memperbaiki kualitas pelayanan kebidanan (Mekonnen et al., 2023).

G. Standar Pelayanan Kebidanan pada Perempuan Usia Subur

Standar pelayanan kebidanan merupakan pedoman yang digunakan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, profesional, dan berkualitas. Standar ini penting agar setiap perempuan usia subur memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi kesehatan, hak reproduksi, dan prinsip evidence-based practice. Dengan adanya standar pelayanan, bidan memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan asuhan, melakukan tindakan, memberikan edukasi, serta mengevaluasi hasil pelayanan.

Standar asuhan kebidanan menuntut bidan untuk memberikan pelayanan secara sistematis. Proses asuhan dimulai dari pengkajian data, penegakan diagnosis kebidanan, perencanaan asuhan, pelaksanaan tindakan, evaluasi hasil asuhan, hingga dokumentasi pelayanan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan dan keamanan pelayanan. Pengkajian yang baik akan membantu bidan memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Diagnosis yang tepat menjadi dasar dalam menyusun rencana asuhan. Pelaksanaan tindakan harus dilakukan sesuai standar, sedangkan evaluasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan asuhan yang telah diberikan. Dokumentasi menjadi bagian akhir yang tidak dapat diabaikan karena berfungsi sebagai bukti pelayanan dan dasar tindak lanjut.

Standar komunikasi efektif juga menjadi bagian penting dalam pelayanan kebidanan. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi, perempuan usia subur sering kali menyampaikan masalah yang bersifat pribadi dan sensitif. Oleh karena itu, bidan harus mampu membangun komunikasi yang aman, terbuka, dan menghargai privasi pasien. Bidan perlu mendengarkan keluhan pasien secara aktif, menjelaskan informasi kesehatan dengan bahasa yang mudah dipahami, memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya, serta memberikan dukungan emosional. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan pasien dan keberhasilan konseling kesehatan reproduksi (Nurfatimah et al., 2024).

Standar pelayanan kontrasepsi juga harus diperhatikan dalam pelayanan kebidanan. Pelayanan kontrasepsi harus diberikan berdasarkan prinsip aman,

sukarela, informed choice, tidak diskriminatif, dan menghormati hak reproduksi perempuan. Bidan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai berbagai metode kontrasepsi, termasuk manfaat, efek samping, cara penggunaan, kontraindikasi, dan alternatif metode yang tersedia. Dengan informasi yang jelas, perempuan dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan, dan rencana reproduksinya.

Selain itu, standar pencegahan infeksi menjadi komponen penting dalam menjaga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Pencegahan infeksi dilakukan melalui cuci tangan sesuai prosedur, sterilisasi alat kesehatan, penggunaan alat pelindung diri, pengelolaan limbah medis, serta pencegahan infeksi silang. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi, tindakan pencegahan infeksi harus dilaksanakan secara konsisten karena pelayanan sering kali melibatkan pemeriksaan fisik, penggunaan alat medis, dan kontak langsung dengan pasien. Kepatuhan terhadap standar pencegahan infeksi dapat mengurangi risiko penularan penyakit dan meningkatkan keamanan pelayanan.

H. Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Pelayanan Kebidanan

Program keluarga berencana merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan reproduksi yang sangat penting bagi perempuan usia subur. Program ini bertujuan membantu pasangan dalam merencanakan jumlah anak, jarak kehamilan, serta waktu kehamilan yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kesiapan keluarga. Evaluasi program keluarga berencana diperlukan untuk mengetahui efektivitas pelayanan kontrasepsi dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, meningkatkan kesehatan ibu, serta mendukung kesejahteraan keluarga.

Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah cakupan akseptor KB. Cakupan akseptor menggambarkan jumlah perempuan usia subur atau pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi tertentu. Tingginya cakupan akseptor menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengaturan kehamilan. Namun, cakupan yang tinggi tetap perlu diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik agar penggunaan kontrasepsi dapat berlangsung aman dan berkelanjutan.

Kepatuhan penggunaan kontrasepsi juga menjadi aspek penting dalam evaluasi program KB. Keberhasilan penggunaan kontrasepsi tidak hanya ditentukan oleh pemilihan metode, tetapi juga oleh kepatuhan pasien dalam menggunakannya. Evaluasi dapat dilakukan terhadap kepatuhan jadwal suntik KB, kontrol penggunaan IUD, keteraturan konsumsi pil KB, serta kemampuan pasien dalam mengenali dan menangani efek samping. Ketidakepatuhan dalam penggunaan kontrasepsi dapat meningkatkan risiko kegagalan metode dan terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan.

Kualitas konseling KB merupakan faktor yang sangat memengaruhi keberhasilan program keluarga berencana. Konseling yang baik membantu perempuan memahami pilihan kontrasepsi yang tersedia dan memilih metode yang

paling sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan, dan rencana reproduksinya. Bidan perlu memberikan konseling secara objektif, tidak memaksa, dan menghormati keputusan pasien. Konseling juga harus membahas efek samping, tanda bahaya, jadwal kontrol, serta kemungkinan pergantian metode apabila pasien mengalami ketidaknyamanan.

Evaluasi program KB juga perlu memperhatikan penanganan efek samping kontrasepsi. Beberapa keluhan yang sering muncul antara lain gangguan menstruasi, kenaikan berat badan, sakit kepala, perubahan suasana hati, dan perdarahan tidak normal. Efek samping yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan pasien menghentikan penggunaan kontrasepsi. Oleh karena itu, bidan perlu memberikan informasi yang jelas, melakukan pemantauan, serta memberikan penanganan atau rujukan apabila diperlukan. Pelayanan KB berbasis woman centered care dapat meningkatkan kepuasan pengguna kontrasepsi dan memperkuat keberhasilan program keluarga berencana (Alene et al., 2024).

I. Evaluasi Pelayanan Skrining Kesehatan Reproduksi

Skrining kesehatan reproduksi merupakan upaya deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan yang dapat dialami perempuan usia subur. Melalui skrining, gangguan kesehatan dapat ditemukan lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum terjadi komplikasi yang lebih berat. Evaluasi pelayanan skrining diperlukan untuk mengetahui cakupan pelayanan, kualitas pelaksanaan, kompetensi tenaga kesehatan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta efektivitas edukasi kepada pasien.

Salah satu bentuk skrining kesehatan reproduksi adalah pemeriksaan IVA dan Pap smear. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi dini lesi prakanker atau kanker serviks. Kanker serviks masih menjadi salah satu masalah kesehatan serius pada perempuan, sehingga deteksi dini memiliki peran penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian. Evaluasi pelayanan skrining kanker serviks dapat dilakukan dengan melihat cakupan pemeriksaan IVA, kompetensi tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan, ketersediaan alat, ketepatan pencatatan hasil, serta tindak lanjut bagi pasien dengan hasil pemeriksaan yang tidak normal. Edukasi juga menjadi bagian penting agar perempuan memahami manfaat skrining dan tidak merasa takut atau malu untuk melakukan pemeriksaan.

Selain skrining kanker serviks, skrining anemia juga perlu dilakukan pada perempuan usia subur. Anemia dapat memengaruhi kesehatan reproduksi dan meningkatkan risiko komplikasi ketika perempuan mengalami kehamilan. Evaluasi skrining anemia dapat dilakukan melalui pemeriksaan kadar hemoglobin, pemantauan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, serta edukasi mengenai gizi reproduksi. Bidan perlu memberikan pemahaman kepada perempuan usia subur mengenai pentingnya asupan zat besi, pola makan seimbang, serta pencegahan anemia sejak sebelum kehamilan.

Skrining infeksi menular seksual juga merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Infeksi menular seksual dapat menimbulkan

berbagai komplikasi, seperti nyeri panggul kronis, infertilitas, gangguan kehamilan, bahkan meningkatkan risiko kanker serviks. Pelayanan skrining IMS harus dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan, kenyamanan, dan prinsip non-diskriminasi. Selain pemeriksaan, pasien juga perlu memperoleh konseling mengenai perilaku seksual sehat, pencegahan penularan, pentingnya pengobatan pasangan, serta kepatuhan terhadap terapi.

J. Peran Evidence-Based Practice dalam Evaluasi Pelayanan Kebidanan

Evidence-based practice merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan kebutuhan pasien. Dalam pelayanan kebidanan, penerapan evidence-based practice sangat penting agar tindakan yang diberikan kepada perempuan usia subur benar-benar aman, efektif, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Pelayanan yang berbasis bukti membantu bidan menghindari praktik yang tidak efektif serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis.

Penerapan evidence-based practice dalam evaluasi pelayanan kebidanan dapat digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan rekomendasi ilmiah dan standar terbaru. Bidan perlu memanfaatkan hasil penelitian dalam pelayanan kontrasepsi, konseling kesehatan reproduksi, penatalaksanaan anemia, deteksi dini komplikasi reproduksi, serta pencegahan infeksi. Dengan menggunakan bukti ilmiah, bidan dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evidence-based practice juga membantu meningkatkan keselamatan pasien. Pelayanan yang didasarkan pada bukti ilmiah dapat menurunkan risiko kesalahan tindakan, meningkatkan efektivitas intervensi, serta memperbaiki hasil pelayanan. Dalam konteks perempuan usia subur, pendekatan ini penting karena masalah kesehatan reproduksi sangat beragam dan sering kali dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bidan perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya melalui pelatihan, membaca literatur ilmiah, mengikuti pedoman terbaru, serta melakukan refleksi terhadap praktik pelayanan yang telah dilakukan. Penerapan evidence-based practice terbukti dapat meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kebidanan (Smith et al., 2024).

K. Tantangan Evaluasi Pelayanan Kebidanan

Pelaksanaan evaluasi pelayanan kebidanan pada perempuan usia subur masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang terbatas dapat menyebabkan beban kerja tinggi, waktu pelayanan yang singkat, serta kurang optimalnya pencatatan dan evaluasi pelayanan. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima pasien.

Kurangnya pelatihan dan pembinaan juga menjadi hambatan dalam evaluasi pelayanan kebidanan. Evaluasi yang baik membutuhkan kemampuan tenaga kesehatan dalam memahami indikator, melakukan pencatatan, menganalisis data, serta menyusun tindak lanjut. Apabila tenaga kesehatan belum memperoleh pelatihan yang memadai, proses evaluasi dapat dilakukan secara tidak konsisten dan hasilnya kurang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan pelayanan.

Dokumentasi yang belum optimal juga sering menjadi kendala. Dalam pelayanan kebidanan, dokumentasi memiliki peran penting sebagai bukti pelayanan, sumber data evaluasi, dan dasar kesinambungan asuhan. Dokumentasi yang tidak lengkap dapat menyulitkan tenaga kesehatan dalam menilai perkembangan pasien, mengevaluasi keberhasilan program, serta melakukan rujukan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pencatatan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam peningkatan mutu pelayanan.

Tantangan lain berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi. Sebagian perempuan usia subur masih enggan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi karena rasa malu, takut, kurang informasi, atau pengaruh budaya. Hambatan sosial budaya juga dapat memengaruhi pengambilan keputusan perempuan, terutama dalam penggunaan kontrasepsi, pemeriksaan IVA, atau konsultasi terkait infeksi menular seksual. Selain itu, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian.

Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat juga menuntut pelayanan kebidanan untuk terus beradaptasi. Fasilitas kesehatan perlu mampu memanfaatkan teknologi digital, memperkuat sistem rujukan, dan meningkatkan kualitas komunikasi agar pelayanan tetap relevan, efektif, dan mudah diakses oleh perempuan usia subur.

L. Strategi Penguatan Pelayanan Kebidanan Berkelanjutan

Penguatan pelayanan kebidanan secara berkelanjutan diperlukan agar perempuan usia subur dapat memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu. Salah satu strategi utama adalah peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan berkala. Pelatihan dapat mencakup konseling kesehatan reproduksi, pelayanan kontrasepsi, skrining kanker serviks, penatalaksanaan anemia, pencegahan infeksi, keselamatan pasien, serta penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kebidanan. Dengan kompetensi yang terus diperbarui, bidan dapat memberikan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi strategi penting dalam peningkatan pelayanan. Teknologi dapat digunakan untuk pencatatan elektronik, pemantauan indikator program, telekonseling, edukasi kesehatan melalui media digital, serta pengingat jadwal kunjungan ulang. Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat proses evaluasi dan meningkatkan akses perempuan usia subur terhadap informasi kesehatan reproduksi.

Strategi berikutnya adalah penguatan edukasi kesehatan reproduksi di masyarakat. Edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perempuan usia subur memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, penggunaan kontrasepsi yang tepat, pencegahan anemia, deteksi dini kanker serviks, serta pencegahan infeksi menular seksual. Edukasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan kemandirian perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksinya.

Optimalisasi sistem rujukan juga perlu dilakukan. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi, bidan dapat menemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut oleh dokter atau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Sistem rujukan yang jelas, cepat, dan terkoordinasi akan membantu pasien memperoleh penanganan yang tepat. Selain itu, pengembangan pelayanan ramah perempuan menjadi strategi penting agar perempuan merasa aman, nyaman, dihargai, dan tidak mengalami diskriminasi ketika mengakses pelayanan kesehatan.

Monitoring dan evaluasi harus diperkuat sebagai bagian dari sistem peningkatan mutu. Evaluasi yang dilakukan secara berkala membantu fasilitas kesehatan mengetahui perkembangan pelayanan, mengidentifikasi masalah, dan menyusun perbaikan. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, akademisi, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan agar pelayanan kebidanan dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

M. Pendekatan Woman Centered Care dalam Pelayanan Kebidanan

Pendekatan woman centered care merupakan konsep pelayanan kebidanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat pelayanan. Dalam pendekatan ini, kebutuhan, nilai, pengalaman, hak, dan preferensi perempuan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pelayanan kesehatan reproduksi. Perempuan tidak diposisikan sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memahami kondisi kesehatannya, menyampaikan pendapat, memilih tindakan, dan terlibat aktif dalam proses perawatan.

Pelayanan kebidanan yang berorientasi pada perempuan dapat meningkatkan rasa aman, kenyamanan, serta kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang diterima (Yulizawati et al., 2022). Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan terapeutik antara bidan dan perempuan usia subur. Bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai pendamping, edukator, konselor, dan advokat kesehatan perempuan. Dalam praktiknya, bidan perlu memberikan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan keluhan, kekhawatiran, pengalaman, serta harapan terhadap pelayanan yang diterimanya.

Pendekatan woman centered care juga memperkuat keterlibatan perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksinya. Ketika perempuan memperoleh informasi yang jelas dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih memahami manfaat pelayanan, lebih patuh terhadap anjuran, dan lebih percaya kepada tenaga kesehatan. Pendekatan ini dianggap efektif dalam meningkatkan keberhasilan program kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kontrasepsi,

skrining kanker serviks, pencegahan anemia, dan konseling reproduksi (Alene et al., 2024).

Selain itu, *woman centered care* menuntut bidan untuk memperhatikan aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual perempuan. Pelayanan tidak boleh hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga perlu mempertimbangkan latar belakang keluarga, nilai budaya, dukungan pasangan, kondisi emosional, serta kemampuan perempuan dalam mengakses pelayanan. Bidan diharapkan mampu memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, menjaga kerahasiaan, menghormati privasi, dan memperlakukan setiap perempuan dengan bermartabat. Dengan pendekatan ini, kualitas pelayanan kebidanan dapat meningkat secara menyeluruh.

N. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Evaluasi Pelayanan Kebidanan

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam peningkatan pelayanan kebidanan. Teknologi dapat membantu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan ketepatan dokumentasi, memperluas akses informasi, serta mendukung evaluasi pelayanan secara lebih sistematis. Dalam konteks perempuan usia subur, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kontrasepsi, konseling kesehatan reproduksi, pemantauan anemia, skrining kanker serviks, dan edukasi kesehatan.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital adalah penggunaan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik membantu tenaga kesehatan mendokumentasikan asuhan kebidanan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Data pasien yang tersimpan secara elektronik dapat mempermudah proses evaluasi karena informasi dapat diakses secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, pencatatan elektronik dapat membantu mengurangi risiko kehilangan data dan meningkatkan kesinambungan pelayanan.

Teknologi digital juga dapat digunakan melalui *telehealth* dan *telekonseling* kesehatan reproduksi. Layanan ini memungkinkan perempuan usia subur memperoleh informasi, edukasi, dan konsultasi kesehatan tanpa harus selalu datang langsung ke fasilitas kesehatan. *Telekonseling* sangat bermanfaat bagi perempuan yang tinggal di daerah terpencil, memiliki keterbatasan transportasi, atau membutuhkan konsultasi awal sebelum mengakses layanan langsung. Layanan *telehealth* dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan memperkuat kesinambungan asuhan kebidanan (Mekonnen et al., 2023).

Media digital juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi kesehatan reproduksi. Bidan dapat memanfaatkan media sosial, video edukasi, aplikasi kesehatan, dan platform komunikasi daring untuk menyampaikan informasi mengenai kontrasepsi, pencegahan anemia, pemeriksaan IVA, kesehatan menstruasi, dan pencegahan infeksi menular seksual. Pemanfaatan media digital terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan perempuan tentang kesehatan reproduksi (Kassa et al., 2024).

Meskipun demikian, penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kebidanan masih memiliki tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi

keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat, serta perlindungan kerahasiaan data pasien. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital harus disertai dengan kebijakan yang jelas, pelatihan bagi tenaga kesehatan, edukasi bagi masyarakat, serta sistem keamanan data yang memadai.

O. Peran Bidan dalam Pemberdayaan Perempuan Usia Subur

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesehatan reproduksi. Perempuan usia subur perlu memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatan dirinya. Dalam hal ini, bidan memiliki peran strategis sebagai tenaga kesehatan yang dekat dengan masyarakat dan sering menjadi sumber informasi utama bagi perempuan.

Peran bidan dalam pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui edukasi, konseling, pendampingan, dan advokasi. Edukasi diberikan agar perempuan memahami hak kesehatan reproduksi, pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, penggunaan kontrasepsi yang tepat, pencegahan penyakit reproduksi, serta penerapan pola hidup sehat. Dengan pengetahuan yang baik, perempuan usia subur akan lebih mampu mengenali tanda bahaya, mencegah komplikasi, dan mencari pertolongan kesehatan secara tepat waktu.

Konseling juga menjadi bagian penting dalam pemberdayaan perempuan. Melalui konseling, bidan membantu perempuan memahami pilihan yang tersedia dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Konseling yang baik harus dilakukan secara empatik, tidak menghakimi, dan menghargai keputusan pasien. Dalam pelayanan kontrasepsi, misalnya, bidan perlu memastikan bahwa perempuan memilih metode berdasarkan pemahaman yang jelas, bukan karena paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Selain edukasi dan konseling, bidan juga berperan dalam melibatkan keluarga. Dukungan pasangan dan keluarga sangat penting dalam keberhasilan program kesehatan reproduksi, terutama dalam penggunaan kontrasepsi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan. Keterlibatan keluarga dapat meningkatkan kepatuhan perempuan terhadap program kesehatan reproduksi dan penggunaan kontrasepsi (Rad et al., 2023).

Bidan juga memiliki peran sebagai advokat dalam memperjuangkan hak-hak kesehatan perempuan. Perempuan usia subur berhak memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, mudah diakses, tidak diskriminatif, dan menghormati martabatnya. Dengan menjalankan peran advokasi, bidan dapat membantu perempuan memperoleh akses pelayanan yang lebih baik dan mendukung tercapainya kualitas hidup yang optimal.

P. Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kebidanan

Keselamatan pasien merupakan komponen utama dalam pelayanan kebidanan. Setiap pelayanan kesehatan reproduksi harus dilakukan secara aman untuk mencegah cedera, komplikasi, infeksi, maupun kesalahan tindakan. Dalam praktik kebidanan, keselamatan pasien tidak hanya berkaitan dengan tindakan klinis, tetapi juga mencakup komunikasi, identifikasi pasien, penggunaan obat, dokumentasi, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan.

Upaya keselamatan pasien dalam pelayanan kebidanan dimulai dari identifikasi pasien secara benar. Identifikasi yang tepat diperlukan untuk mencegah kesalahan pemberian tindakan, obat, atau hasil pemeriksaan. Komunikasi efektif antar tenaga kesehatan juga menjadi bagian penting, terutama ketika pasien membutuhkan rujukan atau pelayanan lanjutan. Informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas dapat meningkatkan risiko kesalahan pelayanan.

Pencegahan infeksi juga harus menjadi perhatian utama. Bidan perlu menerapkan cuci tangan sesuai prosedur, menggunakan alat pelindung diri, memastikan sterilisasi alat, dan mengelola limbah medis dengan benar. Selain itu, penggunaan obat secara aman juga perlu diperhatikan, termasuk pemberian informasi mengenai dosis, cara penggunaan, efek samping, dan tanda bahaya yang perlu diwaspadai pasien.

Kepatuhan terhadap SOP menjadi dasar dalam menjaga keselamatan pasien. Setiap tindakan kebidanan harus dilakukan sesuai standar agar risiko kesalahan dapat diminimalkan. Dokumentasi pelayanan yang lengkap juga menjadi bagian penting karena membantu tenaga kesehatan menilai riwayat pelayanan, memberikan tindak lanjut, dan menjamin kesinambungan asuhan. Kesalahan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dapat berdampak serius terhadap kondisi fisik maupun psikologis perempuan usia subur.

Budaya keselamatan pasien juga perlu dibangun di seluruh fasilitas kesehatan. Budaya ini mencakup kerja sama tim, keterbukaan komunikasi, pelaporan insiden keselamatan, serta pembelajaran dari kesalahan yang terjadi. Fasilitas kesehatan yang memiliki budaya keselamatan yang baik akan lebih mampu mencegah kesalahan, memperbaiki sistem pelayanan, dan meningkatkan mutu asuhan kebidanan. Penerapan prinsip keselamatan pasien dalam praktik kebidanan terbukti dapat meningkatkan mutu pelayanan dan menurunkan risiko komplikasi kesehatan reproduksi (Smith et al., 2024; Rasheed et al., 2023).

Q. Kolaborasi Interprofesional dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Pelayanan kesehatan reproduksi pada perempuan usia subur membutuhkan kerja sama berbagai tenaga kesehatan. Permasalahan kesehatan reproduksi sering kali tidak dapat diselesaikan oleh satu profesi saja karena melibatkan aspek medis, gizi, psikologis, sosial, dan edukatif. Oleh karena itu, kolaborasi interprofesional menjadi pendekatan penting dalam memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan.

Kolaborasi interprofesional merupakan kerja sama antara bidan, dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, tenaga laboratorium, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pasien. Setiap profesi memiliki peran dan kompetensi yang saling melengkapi. Dalam pelayanan kesehatan reproduksi, bidan berperan penting dalam edukasi, konseling, deteksi dini, pelayanan kontrasepsi, pemantauan kesehatan reproduksi, serta rujukan apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lanjutan.

Kolaborasi diperlukan dalam berbagai program kesehatan reproduksi, seperti pelayanan keluarga berencana, skrining kanker serviks, penatalaksanaan anemia, pencegahan infeksi menular seksual, dan konseling kesehatan reproduksi. Misalnya, dalam penatalaksanaan anemia, bidan dapat melakukan skrining dan edukasi, ahli gizi memberikan intervensi pola makan, dokter menangani kondisi medis tertentu, dan apoteker memastikan penggunaan tablet tambah darah secara tepat. Kerja sama yang baik antarprofesi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan mempercepat penanganan masalah kesehatan perempuan usia subur.

Selain kolaborasi antar tenaga kesehatan, kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah juga diperlukan. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan, fasilitas, pembiayaan, dan sistem rujukan. Masyarakat berperan dalam mendukung penerimaan program kesehatan reproduksi, mengurangi stigma, dan meningkatkan kesadaran perempuan untuk mengakses pelayanan. Kolaborasi yang kuat antara tenaga kesehatan, pemerintah, keluarga, dan masyarakat akan memperkuat keberhasilan pelayanan kebidanan dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi perempuan.

R. Penutup

Evaluasi pelayanan kebidanan pada perempuan usia subur merupakan langkah penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan. Evaluasi membantu tenaga kesehatan menilai mutu pelayanan, mengetahui kepuasan pasien, mengukur pencapaian program, serta mengidentifikasi hambatan yang masih perlu diperbaiki. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, pelayanan kebidanan dapat terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan standar pelayanan kesehatan.

Pelayanan kebidanan yang berkualitas harus dilaksanakan secara komprehensif, aman, berkesinambungan, dan berpusat pada kebutuhan perempuan. Dalam pelayanan kepada perempuan usia subur, bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai edukator, konselor, advokat, pendamping, dan penggerak masyarakat. Peran tersebut sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan, kemandirian, dan kemampuan perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksinya.

Penguatan pelayanan kebidanan perlu dilakukan melalui penerapan evidence-based practice, pendekatan woman centered care, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan keselamatan pasien, dan kolaborasi interprofesional. Strategi tersebut dapat membantu meningkatkan mutu pelayanan dan memastikan bahwa

perempuan usia subur memperoleh pelayanan yang sesuai dengan hak, kebutuhan, dan kondisi kesehatannya.

Kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah, keluarga, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mendukung tercapainya kesehatan reproduksi yang optimal. Dengan evaluasi pelayanan yang baik, diharapkan kualitas pelayanan kebidanan semakin meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya perempuan usia subur yang sehat, mandiri, produktif, dan berkualitas.

Referensi

- Alene, M., et al. (2024). Women-centered contraceptive counseling and reproductive health outcomes. *BMC Women's Health*, 24(1), 112–121.
- Ardianti, I. (2019). Pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi pada wanita usia subur di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Humanis*, 3(1), 25–29.
- Aslam, R. W., Hendry, M., Booth, A., Carter, B., Charles, J. M., Craine, N., Edwards, R. T., Noyes, J., Ntambwe, L. I., Pasterfield, D., Rycroft-Malone, J., Williams, N., & Whitaker, R. (2017). Intervention now to eliminate repeat unintended pregnancy in teenagers (INTERUPT): A systematic review of intervention effectiveness and cost-effectiveness, and qualitative and realist synthesis of implementation factors and user engagement. *BMC Medicine*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12916-017-0904-7>
- Barnes, D. M., & Harrison, C. L. (2004). Refugee women's reproductive health in early resettlement. *JOGNN - Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*, 33(6), 723–728. <https://doi.org/10.1177/0884217504270668>
- Benedetto, C. (2024). Sexual and reproductive health and rights. Dalam *Textbook of Contraception, Sexual and Reproductive Health* (pp. 1–7). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108961097.001>
- Biswas, K. K., Hossain, A., Chowdhury, R., Andersen, K., Sultana, S., Shahidullah, S. M., & Pearson, E. (2017). Using mHealth to support postabortion contraceptive use: Results from a feasibility study in urban Bangladesh. *JMIR Formative Research*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.2196/FORMATIVE.5151>
- Chen, H. H., Lee, C., Huang, J., Chi, L., & Hsiung, Y. (2021). Effect of an mHealth-based intervention on excessive gestational weight gain prevention among overweight and obese women: A randomized controlled trial. *JMIR mHealth and uHealth*, 9(10), 1–12. <https://doi.org/10.2196/25413>
- Hamsah, M., et al. (2021). Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan usia subur. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(1), 45–53.
- Kassa, G., et al. (2024). Patient satisfaction and reproductive healthcare quality. *Reproductive Health Journal*, 21(3), 89–97.
- Manurung, S., et al. (2023). Midwifery service quality in reproductive healthcare. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 14(2), 101–109.
- Mantell, J. E., et al. (2006). School-based interventions for reproductive health. *Journal of Adolescent Health*, 39(4), 491–500.

- Mazur, A., Brindis, C. D., & Decker, M. J. (2018). Assessing youth-friendly sexual and reproductive health services: A systematic review. *BMC Health Services Research*, 18(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12913-018-2982-4>
- Mekonnen, T., et al. (2023). Supportive supervision and healthcare quality improvement. *BMC Health Services Research*, 23(1), 771–780.
- Moura, E., et al. (2023). Documentation quality in midwifery care. *Midwifery*, 118, 103578.
- Nurfatimah, N., et al. (2024). Effective communication in reproductive healthcare services. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 15(1), 11–20.
- Prabandari, Y. S., et al. (2023). Women reproductive health services in primary healthcare. *Kesmas: National Public Health Journal*, 18(2), 88–96.
- Rad, M., et al. (2023). Quality improvement in reproductive healthcare services. *Healthcare*, 11(9), 1301.
- Rasheed, S., et al. (2023). Observation-based quality assessment in maternal health services. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 615–623.
- Rustandi, R., et al. (2025). Evaluation of midwifery services in reproductive health programs. *Journal of Midwifery Care*, 5(1), 55–68.
- Sanjaya, I. N. H., & Pemayun, C. I. M. (2023a). Improving the quality of midwife services with gentle birth. *Indonesian Journal of Perinatology*, 4(1), 15–18. <https://doi.org/10.51595/inajol.v4i1.31>
- Smith, J., et al. (2024). Evidence-based midwifery practice and patient safety. *Midwifery Research Review*, 19(2), 77–85.
- Teshome, A., et al. (2024). Monitoring and evaluation of reproductive health services. *Global Health Research and Policy*, 9(1), 14–25.
- World Health Organization. (2024). *Sexual and reproductive health and rights*. Geneva: WHO.
- Wratsangka, R., et al. (2025). Midwifery care and reproductive health outcomes among women of reproductive age. *Asian Journal of Midwifery*, 7(1), 1–12.
- Yulizawati, Y., et al. (2022). Pemberdayaan perempuan melalui pelaksanaan continuity of care dalam pelayanan kebidanan. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 29(3), 171–179. <https://doi.org/10.25077/jwa.29.3.171-179.2022>

PROFIL PENULIS



Dr. Bdn. Eny Retna Ambarwati, S.Si.T., M.Kes.

Lahir di Klaten. Pendidikan tertinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S3 pada Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Minat Promosi Kesehatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2016. Perjalanan akademisnya dimulai pada tahun 2002, dengan mengabdikan diri sebagai dosen tetap. Dengan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala 550 AK. Penulis aktif sebagai reviewer di berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, selain itu juga sebagai asesor akreditasi Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM PT.Kes) serta Evaluator pembukaan Program Studi Kebidanan (SIAGA) kemendiktisatek. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: enyretna@gmail.com



Syahridayanti, S.ST., M.Kes.

Lahir di Pattiro Bajo, 12 Mei 1990. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Program Studi Kebidanan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2012. Melanjutkan pendidikan DIV Kebidanan pada STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Reproduksi di Universitas Muslim Indonesia Makassar dan lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017, penulis bekerja sebagai dosen pada prodi D-III kebidanan di Akbid Menara Bunda Kolaka. Saat ini penulis bekerja di Universitas Cokroaminoto Makassar dan mengampu mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Pengantar Asuhan Kebidanan Kehamilan, Persalinan, Nifas dan BBL, serta KDK. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional dan internasional, seminar, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: antyaudiyah@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dwi Ardani Rochmaniah, SST., Bdn., M.Keb

Lahir di Madiun, 30 Maret 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Pada Prodi DIII Kebidanan Stikes Muhammadiyah Klaten tahun 2009. kemudian S1 pada Program Studi DIV Kebidanan Klinik, Poltekkes Kemenkes Surabaya (Kampus Magetan) tahun 2012. Dilanjutkan profesi pada Prodi pendidikan profesi Bidan, Universitas Strada Indonesia tahun 2026. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2019. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bhakti Hasta Mulia Kota Madiun, Jawa Timur. Penulis mengampu mata kuliah Askeb Kehamilan, Askeb Persalinan, Askeb Nifas, Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengajar, juga sebagai Gugus Kendali Mutu (GKM) pada Prodi S1 Kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dwiardani.rochmaniah@gmail.com

Motto: "From zero to Hero"



Bdn. Ida Susila, S.ST., M.Kes.

lahir di Lamongan pada 23 Maret 1985. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada Diploma III Kebidanan IIK NU Tuban, kemudian menempuh Diploma IV Bidan Pendidik Di STIKES Insan Unggul Surabaya dan lulus pada tahun 2007. Karier profesional dimulai pada tahun 2007 sebagai dosen Di STIKES Insan Unggul Surabaya, lalu melanjutkan studi Magister promosi kesehatan Universitas Diponegoro Semarang dengan peminatan Kesehatan Reproduksi HIV/AIDS selesai pada tahun 2014. Profesi Bidan di STIKES Husada Jombang Lulus Tahun 2024, Saat ini sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan, mengampu mata kuliah kesehatan reproduksi. Penulis menjabat sebagai Direktur Sekolah Vokasi Prodi D3 Kebidanan dan aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, di antaranya menulis buku, mempublikasikan karya ilmiah, menjadi narasumber seminar, dan pembicara dalam berbagai kegiatan. Email: idasusila18@gmail.com

Motto : "Kesuksesan buah dari kesabaran dan doa".

PROFIL PENULIS



Januar Dwichristy, SST., Bd., M.Kes.

Lahir di kabupaten Sidoarjo Prov. Jawa Timur, pada 2 Januari 1988, Menyelesaikan Magister Pada Tahun 2017 di Univ. Diponegoro Semarang, dan pernah bekerja di UPT. Di Kabupaten Sidoarjo dan Menjadi Dosen Tetap sekaligus Kasie LPPM di AKBID Mandiri Gresik mulai 2010 – 2017., dan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang menjadi Dosen Tetap sekaligus Wakil Ketua III di STIKES Griya Husada Surabaya, Telah mengikuti seminar, pelatihan baik

dibidang kebidanan dan Kesehatan.

Aktif melakukan penulisan buku yang telah di HKI dan ISBN, adapun buku berjudul Buku Pegangan Kader Posyandu, Asuhan Kebidanan Keluarga berencana, Prediksi Soal UKOM D III Kebidanan, Buku Ajar Psikologi Kebidanan, Buku SOP KDKK. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: christy.akgh@gmail.com

Motto: "Do The Best In My Life"



Liana Muslihah, S.SiT., M.KM

Penulis lahir di Kota Serang, pada 01 Januari 1985 dan menyelesaikan pendidikan program studi D3 kebidanan di STIKes Aisyiyah Yogyakarta pada tahun 2005, kemudian menyelesaikan D4 Kebidanan di STIKes Mitra Ria Husada Jakarta Tahun 2008 dan selanjutnya menyelesaikan Pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Hamka Jakarta Tahun 2017. Sampai saat ini penulis sebagai dosen di Program studi D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan 'Aisyiyah Banten dengan jabatan akademik sebagai Asisten Ahli.

Alamat email penulis lianamuslihah@gmail.com

Motto : Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan (QS.94 ayat 5-6)

PROFIL PENULIS



Sitti Hadriyanti Hamang, S.Si.T.,M.Keb.

Assalamualaikum Wr.Wb. Penulis merupakan salah satu dosen pada Program Studi Kebidanan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Penulis Lahir di Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis sebelumnya kuliah pada program D3 Kebidanan FKM UMI dan selesai pada tahun 2011, kemudian penulis mengambil D4 Bidan di Politeknik Kesehatan Makassar dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis mengabdikan kembali di Prodi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya penulis melanjutkan S2 Ilmu Kebidanan di Kampus Universitas Hasanuddin dan lulus pada tahun 2020. Saat ini penulis berprofesi sebagai akademisi di Prodi Kebidanan FKM UMI dan mengajarkan mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga dan aktif melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berfokus pada Kesehatan Reproduksi.

Sinopsis

bunga rampai "Pelayanan Kebidanan pada Perempuan Usia Subur dalam Upaya Menjaga Kesehatan Reproduksi" ini menyajikan rangkaian pembahasan komprehensif mengenai peran pelayanan kebidanan bagi perempuan usia subur sebagai upaya promotif, preventif, deteksi dini, hingga evaluasi layanan untuk menjaga kesehatan reproduksi secara berkelanjutan. Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan rujukan yang sistematis dan aplikatif, mengingat kompleksitas masalah kesehatan reproduksi yang dapat memengaruhi kualitas hidup, kesiapan kehamilan, serta kesejahteraan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Pembahasan diawali dengan penguatan landasan konsep tentang perempuan usia subur dan kesehatan reproduksi sebagai pijakan praktik kebidanan yang berbasis kebutuhan. Selanjutnya, buku mengurai berbagai permasalahan kesehatan reproduksi yang umum dijumpai, termasuk faktor risiko dan dampaknya. Bab berikutnya menitikberatkan pada deteksi dini gangguan menstruasi dan infeksi saluran reproduksi sebagai langkah penting mencegah komplikasi. Buku ini juga mengintegrasikan aspek perilaku hidup sehat yang relevan bagi perempuan usia subur serta strategi skrining kesehatan reproduksi disertai edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan literasi kesehatan dan kemandirian perempuan dalam menjaga kesehatannya.

Sebagai inti, bunga rampai ini menegaskan peran bidan dalam promosi kesehatan reproduksi melalui edukasi, konseling, komunikasi efektif, advokasi, kolaborasi lintas profesi, serta pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ramah perempuan dan menjaga kerahasiaan. Bagian akhir memfokuskan pada evaluasi pelayanan kebidanan pada perempuan usia subur, termasuk indikator capaian, mutu layanan, tindak lanjut, dan perbaikan berkelanjutan.

Sinopsis bunga rampai “Pelayanan Kebidanan pada Perempuan Usia Subur dalam Upaya Menjaga Kesehatan Reproduksi” ini menyajikan rangkaian pembahasan komprehensif mengenai peran pelayanan kebidanan bagi perempuan usia subur sebagai upaya promotif, preventif, deteksi dini, hingga evaluasi layanan untuk menjaga kesehatan reproduksi secara berkelanjutan. Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan rujukan yang sistematis dan aplikatif, mengingat kompleksitas masalah kesehatan reproduksi yang dapat memengaruhi kualitas hidup, kesiapan kehamilan, serta kesejahteraan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Pembahasan diawali dengan penguatan landasan konsep tentang perempuan usia subur dan kesehatan reproduksi sebagai pijakan praktik kebidanan yang berbasis kebutuhan. Selanjutnya, buku mengurai berbagai permasalahan kesehatan reproduksi yang umum dijumpai, termasuk faktor risiko dan dampaknya. Bab berikutnya menitikberatkan pada deteksi dini gangguan menstruasi dan infeksi saluran reproduksi sebagai langkah penting mencegah komplikasi. Buku ini juga mengintegrasikan aspek perilaku hidup sehat yang relevan bagi perempuan usia subur serta strategi skrining kesehatan reproduksi disertai edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan literasi kesehatan dan kemandirian perempuan dalam menjaga kesehatannya.

Sebagai inti, bunga rampai ini menegaskan peran bidan dalam promosi kesehatan reproduksi melalui edukasi, konseling, komunikasi efektif, advokasi, kolaborasi lintas profesi, serta pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ramah perempuan dan menjaga kerahasiaan. Bagian akhir memfokuskan pada evaluasi pelayanan kebidanan pada perempuan usia subur, termasuk indikator capaian, mutu layanan, tindak lanjut, dan perbaikan berkelanjutan. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa kebidanan, bidan praktik, tenaga kesehatan, dosen, serta pengelola program kesehatan sebagai referensi untuk memperkuat kualitas pelayanan kebidanan yang holistik, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan perempuan.



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-47-3 (PDF)



9

786347

756473